

Especialidad: Medicina Interna

Tema: Endocrinología

Subtema: Diabetes Mellitus

Dificultad: alta

Caso clínico: Paciente de 58 años con diabetes mellitus tipo 2, obesidad central e hipertensión tratada; refiere adherencia irregular, automonitoreos repetidamente elevados y no ha presentado hipoglucemia grave. Está alerta, sin datos de infección, con función renal estable y exploración sin deshidratación ni focalización neurológica. La evolución se ha modificado durante las últimas 12 horas y los familiares pueden aportar una cronología fiable. La valoración integral confirma hiperglucemia persistente sin crisis metabólica.

Pregunta: ¿Cuál es la primera decisión integral más adecuada?

- A. individualizar la meta glucémica y reforzar alimentación, actividad física, adherencia y automonitoreo antes de modificar el esquema*
- B. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- C. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: La guía propone una atención individualizada: confirmar persistencia, valorar riesgos y fortalecer las intervenciones no farmacológicas antes de una escalada reflexiva. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Diagnóstico y Tratamiento Farmacológico de la Diabetes Mellitus Tipo 2 en el Primer Nivel de Atención. GPC-IMSS-718-18, 2018.

Especialidad: Medicina Interna

Tema: Endocrinología

Subtema: Diabetes Mellitus

Dificultad: alta

Caso clínico: Paciente de 58 años con diabetes mellitus tipo 2, obesidad central e hipertensión tratada; refiere adherencia irregular, automonitoreos repetidamente elevados y no ha presentado hipoglucemia grave. Está alerta, sin datos de infección, con función renal estable y exploración sin deshidratación ni focalización neurológica. La evolución se ha modificado durante las últimas 12 horas y los familiares pueden aportar una cronología fiable. La valoración integral confirma hiperglucemia persistente sin crisis metabólica.

Pregunta: ¿Qué conducta terapéutica es más congruente con una intensificación segura?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. intensificar de manera escalonada el tratamiento farmacológico y revisar tolerancia, función renal y riesgo de hipoglucemia*
- C. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: La intensificación debe ser gradual e individualizada; la selección farmacológica depende de eficacia, seguridad renal y probabilidad de hipoglucemia. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Diagnóstico y Tratamiento Farmacológico de la Diabetes Mellitus Tipo 2 en el Primer Nivel de Atención. GPC-IMSS-718-18, 2018.

Especialidad: Medicina Interna

Tema: Endocrinología

Subtema: Diabetes Mellitus

Dificultad: alta

Caso clínico: Paciente de 58 años con diabetes mellitus tipo 2, obesidad central e hipertensión tratada; refiere adherencia irregular, automonitoreos repetidamente elevados y no ha presentado hipoglucemia grave. Está alerta, sin datos de infección, con función renal estable y exploración sin deshidratación ni focalización neurológica. La evolución se ha modificado durante las últimas 12 horas y los familiares pueden aportar una cronología fiable. La valoración integral confirma hiperglucemia persistente sin crisis metabólica.

Pregunta: ¿Qué paso evita atribuir el descontrol a una sola cifra aislada?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- C. identificar una causa reversible de descontrol y documentar complicaciones microvasculares antes de elegir el siguiente fármaco*
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: La revisión de adherencia, fármacos intercurrentes, técnica de aplicación y daño a órgano blanco cambia la elección terapéutica y previene escaladas inapropiadas. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Diagnóstico y Tratamiento Farmacológico de la Diabetes Mellitus Tipo 2 en el Primer Nivel de Atención. GPC-IMSS-718-18, 2018.

Especialidad: Medicina Interna

Tema: Endocrinología

Subtema: Diabetes Mellitus

Dificultad: alta

Caso clínico: Paciente de 58 años con diabetes mellitus tipo 2, obesidad central e hipertensión tratada; refiere adherencia irregular, automonitoreos repetidamente elevados y no ha presentado hipoglucemia grave. Está alerta, sin datos de infección, con función renal estable y exploración sin deshidratación ni focalización neurológica. La evolución se ha modificado durante las últimas 12 horas y los familiares pueden aportar una cronología fiable. La valoración integral confirma hiperglucemia persistente sin crisis metabólica.

Pregunta: ¿Cuál debe ser el componente decisivo del seguimiento?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- C. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación
- D. programar seguimiento temprano con metas explícitas y ajuste según la respuesta objetiva*

Explicación: El ajuste terapéutico requiere una meta pactada y reevaluación cercana, no una prescripción sin verificación de respuesta. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Diagnóstico y Tratamiento Farmacológico de la Diabetes Mellitus Tipo 2 en el Primer Nivel de Atención. GPC-IMSS-718-18, 2018.

Especialidad: Medicina Interna

Tema: Endocrinología

Subtema: Diabetes Mellitus

Dificultad: alta

Caso clínico: Paciente de 58 años con diabetes mellitus tipo 2, obesidad central e hipertensión tratada; refiere adherencia irregular, automonitoreos repetidamente elevados y no ha presentado hipoglucemia grave. Está alerta, sin datos de infección, con función renal estable y exploración sin deshidratación ni focalización neurológica. La evolución se ha modificado durante las últimas 12 horas y los familiares pueden aportar una cronología fiable. La valoración integral confirma hiperglucemia persistente sin crisis metabólica.

Pregunta: ¿Qué característica del esquema es prioritaria en este escenario?

- A. priorizar un esquema con bajo riesgo de hipoglucemia cuando el contexto clínico lo exige*
- B. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- C. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: En una persona susceptible a hipoglucemia, la seguridad debe guiar la elección junto con la eficacia y el contexto clínico. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Diagnóstico y Tratamiento Farmacológico de la Diabetes Mellitus Tipo 2 en el Primer Nivel de Atención. GPC-IMSS-718-18, 2018.

Especialidad: Medicina Interna

Tema: Endocrinología

Subtema: Diabetes Mellitus

Dificultad: alta

Caso clínico: Paciente de 58 años con diabetes mellitus tipo 2, obesidad central e hipertensión tratada; refiere adherencia irregular, automonitoreos repetidamente elevados y no ha presentado hipoglucemia grave. Está alerta, sin datos de infección, con función renal estable y exploración sin deshidratación ni focalización neurológica. No existen antecedentes de alergia medicamentosa, pero hay barreras para regresar con rapidez si empeora. La valoración integral confirma hiperglucemia persistente sin crisis metabólica.

Pregunta: ¿Cuál es la primera decisión integral más adecuada?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. individualizar la meta glucémica y reforzar alimentación, actividad física, adherencia y automonitoreo antes de modificar el esquema*
- C. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: La guía propone una atención individualizada: confirmar persistencia, valorar riesgos y fortalecer las intervenciones no farmacológicas antes de una escalada reflexiva. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Diagnóstico y Tratamiento Farmacológico de la Diabetes Mellitus Tipo 2 en el Primer Nivel de Atención. GPC-IMSS-718-18, 2018.

Especialidad: Medicina Interna

Tema: Endocrinología

Subtema: Diabetes Mellitus

Dificultad: alta

Caso clínico: Paciente de 58 años con diabetes mellitus tipo 2, obesidad central e hipertensión tratada; refiere adherencia irregular, automonitoreos repetidamente elevados y no ha presentado hipoglucemia grave. Está alerta, sin datos de infección, con función renal estable y exploración sin deshidratación ni focalización neurológica. No existen antecedentes de alergia medicamentosa, pero hay barreras para regresar con rapidez si empeora. La valoración integral confirma hiperglucemia persistente sin crisis metabólica.

Pregunta: ¿Qué conducta terapéutica es más congruente con una intensificación segura?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- C. intensificar de manera escalonada el tratamiento farmacológico y revisar tolerancia, función renal y riesgo de hipoglucemia*
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: La intensificación debe ser gradual e individualizada; la selección farmacológica depende de eficacia, seguridad renal y probabilidad de hipoglucemia. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Diagnóstico y Tratamiento Farmacológico de la Diabetes Mellitus Tipo 2 en el Primer Nivel de Atención. GPC-IMSS-718-18, 2018.

Especialidad: Medicina Interna

Tema: Endocrinología

Subtema: Diabetes Mellitus

Dificultad: alta

Caso clínico: Paciente de 58 años con diabetes mellitus tipo 2, obesidad central e hipertensión tratada; refiere adherencia irregular, automonitoreos repetidamente elevados y no ha presentado hipoglucemia grave. Está alerta, sin datos de infección, con función renal estable y exploración sin deshidratación ni focalización neurológica. No existen antecedentes de alergia medicamentosa, pero hay barreras para regresar con rapidez si empeora. La valoración integral confirma hiperglucemia persistente sin crisis metabólica.

Pregunta: ¿Qué paso evita atribuir el descontrol a una sola cifra aislada?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- C. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación
- D. identificar una causa reversible de descontrol y documentar complicaciones microvasculares antes de elegir el siguiente fármaco*

Explicación: La revisión de adherencia, fármacos intercurrentes, técnica de aplicación y daño a órgano blanco cambia la elección terapéutica y previene escaladas inapropiadas. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Diagnóstico y Tratamiento Farmacológico de la Diabetes Mellitus Tipo 2 en el Primer Nivel de Atención. GPC-IMSS-718-18, 2018.

Especialidad: Medicina Interna

Tema: Endocrinología

Subtema: Diabetes Mellitus

Dificultad: alta

Caso clínico: Paciente de 58 años con diabetes mellitus tipo 2, obesidad central e hipertensión tratada; refiere adherencia irregular, automonitoreos repetidamente elevados y no ha presentado hipoglucemia grave. Está alerta, sin datos de infección, con función renal estable y exploración sin deshidratación ni focalización neurológica. No existen antecedentes de alergia medicamentosa, pero hay barreras para regresar con rapidez si empeora. La valoración integral confirma hiperglucemia persistente sin crisis metabólica.

Pregunta: ¿Cuál debe ser el componente decisivo del seguimiento?

- A. programar seguimiento temprano con metas explícitas y ajuste según la respuesta objetiva*
- B. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- C. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: El ajuste terapéutico requiere una meta pactada y reevaluación cercana, no una prescripción sin verificación de respuesta. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Diagnóstico y Tratamiento Farmacológico de la Diabetes Mellitus Tipo 2 en el Primer Nivel de Atención. GPC-IMSS-718-18, 2018.

Especialidad: Medicina Interna

Tema: Endocrinología

Subtema: Diabetes Mellitus

Dificultad: alta

Caso clínico: Paciente de 58 años con diabetes mellitus tipo 2, obesidad central e hipertensión tratada; refiere adherencia irregular, automonitoreos repetidamente elevados y no ha presentado hipoglucemia grave. Está alerta, sin datos de infección, con función renal estable y exploración sin deshidratación ni focalización neurológica. No existen antecedentes de alergia medicamentosa, pero hay barreras para regresar con rapidez si empeora. La valoración integral confirma hiperglucemia persistente sin crisis metabólica.

Pregunta: ¿Qué característica del esquema es prioritaria en este escenario?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. priorizar un esquema con bajo riesgo de hipoglucemia cuando el contexto clínico lo exige*
- C. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: En una persona susceptible a hipoglucemia, la seguridad debe guiar la elección junto con la eficacia y el contexto clínico. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Diagnóstico y Tratamiento Farmacológico de la Diabetes Mellitus Tipo 2 en el Primer Nivel de Atención. GPC-IMSS-718-18, 2018.

Especialidad: Medicina Interna

Tema: Endocrinología

Subtema: Diabetes Mellitus

Dificultad: alta

Caso clínico: Paciente de 58 años con diabetes mellitus tipo 2, obesidad central e hipertensión tratada; refiere adherencia irregular, automonitoreos repetidamente elevados y no ha presentado hipoglucemia grave. Está alerta, sin datos de infección, con función renal estable y exploración sin deshidratación ni focalización neurológica. La revisión de medicamentos identifica una posible exposición reciente que debe considerarse al integrar el riesgo. La valoración integral confirma hiperglucemia persistente sin crisis metabólica.

Pregunta: ¿Cuál es la primera decisión integral más adecuada?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- C. individualizar la meta glucémica y reforzar alimentación, actividad física, adherencia y automonitoreo antes de modificar el esquema*
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: La guía propone una atención individualizada: confirmar persistencia, valorar riesgos y fortalecer las intervenciones no farmacológicas antes de una escalada reflexiva. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Diagnóstico y Tratamiento Farmacológico de la Diabetes Mellitus Tipo 2 en el Primer Nivel de Atención. GPC-IMSS-718-18, 2018.

Especialidad: Medicina Interna

Tema: Endocrinología

Subtema: Diabetes Mellitus

Dificultad: alta

Caso clínico: Paciente de 58 años con diabetes mellitus tipo 2, obesidad central e hipertensión tratada; refiere adherencia irregular, automonitoreos repetidamente elevados y no ha presentado hipoglucemia grave. Está alerta, sin datos de infección, con función renal estable y exploración sin deshidratación ni focalización neurológica. La revisión de medicamentos identifica una posible exposición reciente que debe considerarse al integrar el riesgo. La valoración integral confirma hiperglucemia persistente sin crisis metabólica.

Pregunta: ¿Qué conducta terapéutica es más congruente con una intensificación segura?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- C. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación
- D. intensificar de manera escalonada el tratamiento farmacológico y revisar tolerancia, función renal y riesgo de hipoglucemia*

Explicación: La intensificación debe ser gradual e individualizada; la selección farmacológica depende de eficacia, seguridad renal y probabilidad de hipoglucemia. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Diagnóstico y Tratamiento Farmacológico de la Diabetes Mellitus Tipo 2 en el Primer Nivel de Atención. GPC-IMSS-718-18, 2018.

Especialidad: Medicina Interna

Tema: Endocrinología

Subtema: Diabetes Mellitus

Dificultad: alta

Caso clínico: Paciente de 58 años con diabetes mellitus tipo 2, obesidad central e hipertensión tratada; refiere adherencia irregular, automonitoreos repetidamente elevados y no ha presentado hipoglucemia grave. Está alerta, sin datos de infección, con función renal estable y exploración sin deshidratación ni focalización neurológica. La revisión de medicamentos identifica una posible exposición reciente que debe considerarse al integrar el riesgo. La valoración integral confirma hiperglucemia persistente sin crisis metabólica.

Pregunta: ¿Qué paso evita atribuir el descontrol a una sola cifra aislada?

- A. identificar una causa reversible de descontrol y documentar complicaciones microvasculares antes de elegir el siguiente fármaco*
- B. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- C. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: La revisión de adherencia, fármacos intercurrentes, técnica de aplicación y daño a órgano blanco cambia la elección terapéutica y previene escaladas inapropiadas. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Diagnóstico y Tratamiento Farmacológico de la Diabetes Mellitus Tipo 2 en el Primer Nivel de Atención. GPC-IMSS-718-18, 2018.

Especialidad: Medicina Interna

Tema: Endocrinología

Subtema: Diabetes Mellitus

Dificultad: alta

Caso clínico: Paciente de 58 años con diabetes mellitus tipo 2, obesidad central e hipertensión tratada; refiere adherencia irregular, automonitoreos repetidamente elevados y no ha presentado hipoglucemia grave. Está alerta, sin datos de infección, con función renal estable y exploración sin deshidratación ni focalización neurológica. La revisión de medicamentos identifica una posible exposición reciente que debe considerarse al integrar el riesgo. La valoración integral confirma hiperglucemia persistente sin crisis metabólica.

Pregunta: ¿Cuál debe ser el componente decisivo del seguimiento?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. programar seguimiento temprano con metas explícitas y ajuste según la respuesta objetiva*
- C. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: El ajuste terapéutico requiere una meta pactada y reevaluación cercana, no una prescripción sin verificación de respuesta. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Diagnóstico y Tratamiento Farmacológico de la Diabetes Mellitus Tipo 2 en el Primer Nivel de Atención. GPC-IMSS-718-18, 2018.

Especialidad: Medicina Interna

Tema: Endocrinología

Subtema: Diabetes Mellitus

Dificultad: alta

Caso clínico: Paciente de 58 años con diabetes mellitus tipo 2, obesidad central e hipertensión tratada; refiere adherencia irregular, automonitoreos repetidamente elevados y no ha presentado hipoglucemia grave. Está alerta, sin datos de infección, con función renal estable y exploración sin deshidratación ni focalización neurológica. La revisión de medicamentos identifica una posible exposición reciente que debe considerarse al integrar el riesgo. La valoración integral confirma hiperglucemia persistente sin crisis metabólica.

Pregunta: ¿Qué característica del esquema es prioritaria en este escenario?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- C. priorizar un esquema con bajo riesgo de hipoglucemia cuando el contexto clínico lo exige*
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: En una persona susceptible a hipoglucemia, la seguridad debe guiar la elección junto con la eficacia y el contexto clínico. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Diagnóstico y Tratamiento Farmacológico de la Diabetes Mellitus Tipo 2 en el Primer Nivel de Atención. GPC-IMSS-718-18, 2018.

Especialidad: Medicina Interna

Tema: Endocrinología

Subtema: Diabetes Mellitus

Dificultad: alta

Caso clínico: Paciente de 58 años con diabetes mellitus tipo 2, obesidad central e hipertensión tratada; refiere adherencia irregular, automonitoreos repetidamente elevados y no ha presentado hipoglucemia grave. Está alerta, sin datos de infección, con función renal estable y exploración sin deshidratación ni focalización neurológica. Los signos vitales se repiten después de una primera medida de soporte y muestran la misma tendencia clínica. La valoración integral confirma hiperglucemia persistente sin crisis metabólica.

Pregunta: ¿Cuál es la primera decisión integral más adecuada?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- C. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación
- D. individualizar la meta glucémica y reforzar alimentación, actividad física, adherencia y automonitoreo antes de modificar el esquema*

Explicación: La guía propone una atención individualizada: confirmar persistencia, valorar riesgos y fortalecer las intervenciones no farmacológicas antes de una escalada reflexiva. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Diagnóstico y Tratamiento Farmacológico de la Diabetes Mellitus Tipo 2 en el Primer Nivel de Atención. GPC-IMSS-718-18, 2018.

Especialidad: Medicina Interna

Tema: Endocrinología

Subtema: Diabetes Mellitus

Dificultad: alta

Caso clínico: Paciente de 58 años con diabetes mellitus tipo 2, obesidad central e hipertensión tratada; refiere adherencia irregular, automonitoreos repetidamente elevados y no ha presentado hipoglucemia grave. Está alerta, sin datos de infección, con función renal estable y exploración sin deshidratación ni focalización neurológica. Los signos vitales se repiten después de una primera medida de soporte y muestran la misma tendencia clínica. La valoración integral confirma hiperglucemia persistente sin crisis metabólica.

Pregunta: ¿Qué conducta terapéutica es más congruente con una intensificación segura?

- A. intensificar de manera escalonada el tratamiento farmacológico y revisar tolerancia, función renal y riesgo de hipoglucemia*
- B. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- C. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: La intensificación debe ser gradual e individualizada; la selección farmacológica depende de eficacia, seguridad renal y probabilidad de hipoglucemia. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Diagnóstico y Tratamiento Farmacológico de la Diabetes Mellitus Tipo 2 en el Primer Nivel de Atención. GPC-IMSS-718-18, 2018.

Especialidad: Medicina Interna

Tema: Endocrinología

Subtema: Diabetes Mellitus

Dificultad: alta

Caso clínico: Paciente de 58 años con diabetes mellitus tipo 2, obesidad central e hipertensión tratada; refiere adherencia irregular, automonitoreos repetidamente elevados y no ha presentado hipoglucemia grave. Está alerta, sin datos de infección, con función renal estable y exploración sin deshidratación ni focalización neurológica. Los signos vitales se repiten después de una primera medida de soporte y muestran la misma tendencia clínica. La valoración integral confirma hiperglucemia persistente sin crisis metabólica.

Pregunta: ¿Qué paso evita atribuir el descontrol a una sola cifra aislada?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. identificar una causa reversible de descontrol y documentar complicaciones microvasculares antes de elegir el siguiente fármaco*
- C. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: La revisión de adherencia, fármacos intercurrentes, técnica de aplicación y daño a órgano blanco cambia la elección terapéutica y previene escaladas inapropiadas. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Diagnóstico y Tratamiento Farmacológico de la Diabetes Mellitus Tipo 2 en el Primer Nivel de Atención. GPC-IMSS-718-18, 2018.

Especialidad: Medicina Interna

Tema: Endocrinología

Subtema: Diabetes Mellitus

Dificultad: alta

Caso clínico: Paciente de 58 años con diabetes mellitus tipo 2, obesidad central e hipertensión tratada; refiere adherencia irregular, automonitoreos repetidamente elevados y no ha presentado hipoglucemia grave. Está alerta, sin datos de infección, con función renal estable y exploración sin deshidratación ni focalización neurológica. Los signos vitales se repiten después de una primera medida de soporte y muestran la misma tendencia clínica. La valoración integral confirma hiperglucemia persistente sin crisis metabólica.

Pregunta: ¿Cuál debe ser el componente decisivo del seguimiento?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- C. programar seguimiento temprano con metas explícitas y ajuste según la respuesta objetiva*
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: El ajuste terapéutico requiere una meta pactada y reevaluación cercana, no una prescripción sin verificación de respuesta. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Diagnóstico y Tratamiento Farmacológico de la Diabetes Mellitus Tipo 2 en el Primer Nivel de Atención. GPC-IMSS-718-18, 2018.

Especialidad: Medicina Interna

Tema: Endocrinología

Subtema: Diabetes Mellitus

Dificultad: alta

Caso clínico: Paciente de 58 años con diabetes mellitus tipo 2, obesidad central e hipertensión tratada; refiere adherencia irregular, automonitoreos repetidamente elevados y no ha presentado hipoglucemia grave. Está alerta, sin datos de infección, con función renal estable y exploración sin deshidratación ni focalización neurológica. Los signos vitales se repiten después de una primera medida de soporte y muestran la misma tendencia clínica. La valoración integral confirma hiperglucemia persistente sin crisis metabólica.

Pregunta: ¿Qué característica del esquema es prioritaria en este escenario?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- C. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación
- D. priorizar un esquema con bajo riesgo de hipoglucemia cuando el contexto clínico lo exige*

Explicación: En una persona susceptible a hipoglucemia, la seguridad debe guiar la elección junto con la eficacia y el contexto clínico. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Diagnóstico y Tratamiento Farmacológico de la Diabetes Mellitus Tipo 2 en el Primer Nivel de Atención. GPC-IMSS-718-18, 2018.

Especialidad: Medicina Interna

Tema: Endocrinología

Subtema: Cetoacidosis

Dificultad: alta

Caso clínico: Paciente de 34 años con diabetes conocida consulta por poliuria, polidipsia, dolor abdominal, respiración profunda y deterioro progresivo durante 24 horas tras suspender insulina por vómito. Tiene mucosas secas, taquicardia y sin foco neurológico. Los resultados iniciales muestran hiperglucemia marcada, cetonemia y acidosis metabólica con anión gap elevado. La evolución se ha modificado durante las últimas 12 horas y los familiares pueden aportar una cronología fiable. El cuadro es compatible con una descompensación hiperglucémica aguda que exige estabilización y búsqueda del desencadenante.

Pregunta: ¿Cuál es la medida inicial más segura?

- A. iniciar reanimación con líquidos isotónicos, vigilar potasio y comenzar insulina solo después de confirmar que el potasio permite hacerlo*
- B. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- C. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: La reposición de volumen y la vigilancia de potasio anteceden a una insulino terapia segura; iniciar insulina con hipopotasemia puede precipitar arritmia. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Diagnóstico y Tratamiento Farmacológico de la Diabetes Mellitus Tipo 2 en el Primer Nivel de Atención. GPC-IMSS-718-18, 2018.

Especialidad: Medicina Interna

Tema: Endocrinología

Subtema: Cetoacidosis

Dificultad: alta

Caso clínico: Paciente de 34 años con diabetes conocida consulta por poliuria, polidipsia, dolor abdominal, respiración profunda y deterioro progresivo durante 24 horas tras suspender insulina por vómito. Tiene mucosas secas, taquicardia y sin foco neurológico. Los resultados iniciales muestran hiperglucemia marcada, cetonemia y acidosis metabólica con anión gap elevado. La evolución se ha modificado durante las últimas 12 horas y los familiares pueden aportar una cronología fiable. El cuadro es compatible con una descompensación hiperglucémica aguda que exige estabilización y búsqueda del desencadenante.

Pregunta: ¿Qué evaluación paralela es indispensable durante la estabilización?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. solicitar gases, electrolitos, cetonas y estudios dirigidos a desencadenante mientras se corrige volumen intravascular*
- C. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: La crisis requiere cuantificar acidosis, cetosis y electrolitos, al mismo tiempo que se investiga infección, omisión de insulina u otro precipitante. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Diagnóstico y Tratamiento Farmacológico de la Diabetes Mellitus Tipo 2 en el Primer Nivel de Atención. GPC-IMSS-718-18, 2018.

Especialidad: Medicina Interna

Tema: Endocrinología

Subtema: Cetoacidosis

Dificultad: alta

Caso clínico: Paciente de 34 años con diabetes conocida consulta por poliuria, polidipsia, dolor abdominal, respiración profunda y deterioro progresivo durante 24 horas tras suspender insulina por vómito. Tiene mucosas secas, taquicardia y sin foco neurológico. Los resultados iniciales muestran hiperglucemia marcada, cetonemia y acidosis metabólica con anión gap elevado. La evolución se ha modificado durante las últimas 12 horas y los familiares pueden aportar una cronología fiable. El cuadro es compatible con una descompensación hiperglucémica aguda que exige estabilización y búsqueda del desencadenante.

Pregunta: ¿Cuál es la estrategia correcta cuando disminuye la glucemia pero persiste la acidosis?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- C. añadir glucosa a los líquidos cuando descienda la glucemia sin suspender la insulina hasta resolver la cetosis*
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: La insulina se mantiene para suprimir cetogénesis; se administra glucosa para evitar hipoglucemia mientras se corrige la acidosis. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Diagnóstico y Tratamiento Farmacológico de la Diabetes Mellitus Tipo 2 en el Primer Nivel de Atención. GPC-IMSS-718-18, 2018.

Especialidad: Medicina Interna

Tema: Endocrinología

Subtema: Cetoacidosis

Dificultad: alta

Caso clínico: Paciente de 34 años con diabetes conocida consulta por poliuria, polidipsia, dolor abdominal, respiración profunda y deterioro progresivo durante 24 horas tras suspender insulina por vómito. Tiene mucosas secas, taquicardia y sin foco neurológico. Los resultados iniciales muestran hiperglucemia marcada, cetonemia y acidosis metabólica con anión gap elevado. La evolución se ha modificado durante las últimas 12 horas y los familiares pueden aportar una cronología fiable. El cuadro es compatible con una descompensación hiperglucémica aguda que exige estabilización y búsqueda del desencadenante.

Pregunta: ¿Qué elemento condiciona el inicio y la vigilancia de insulina?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- C. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación
- D. corregir el potasio de acuerdo con mediciones seriadas antes y durante la insulinoterapia*

Explicación: El potasio se desplaza con insulina y corrección de acidosis, por lo que las determinaciones seriadas dirigen una reposición segura. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Diagnóstico y Tratamiento Farmacológico de la Diabetes Mellitus Tipo 2 en el Primer Nivel de Atención. GPC-IMSS-718-18, 2018.

Especialidad: Medicina Interna

Tema: Endocrinología

Subtema: Cetoacidosis

Dificultad: alta

Caso clínico: Paciente de 34 años con diabetes conocida consulta por poliuria, polidipsia, dolor abdominal, respiración profunda y deterioro progresivo durante 24 horas tras suspender insulina por vómito. Tiene mucosas secas, taquicardia y sin foco neurológico. Los resultados iniciales muestran hiperglucemia marcada, cetonemia y acidosis metabólica con anión gap elevado. La evolución se ha modificado durante las últimas 12 horas y los familiares pueden aportar una cronología fiable. El cuadro es compatible con una descompensación hiperglucémica aguda que exige estabilización y búsqueda del desencadenante.

Pregunta: ¿Qué criterio confirma resolución metabólica real?

- A. definir resolución por cierre de la acidosis y de la cetosis, no por una glucosa aislada*
- B. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- C. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: La normalización aislada de glucosa no equivale a resolución; deben corregirse cetosis y acidosis. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Diagnóstico y Tratamiento Farmacológico de la Diabetes Mellitus Tipo 2 en el Primer Nivel de Atención. GPC-IMSS-718-18, 2018.

Especialidad: Medicina Interna

Tema: Endocrinología

Subtema: Cetoacidosis

Dificultad: alta

Caso clínico: Paciente de 34 años con diabetes conocida consulta por poliuria, polidipsia, dolor abdominal, respiración profunda y deterioro progresivo durante 24 horas tras suspender insulina por vómito. Tiene mucosas secas, taquicardia y sin foco neurológico. Los resultados iniciales muestran hiperglucemia marcada, cetonemia y acidosis metabólica con anión gap elevado. No existen antecedentes de alergia medicamentosa, pero hay barreras para regresar con rapidez si empeora. El cuadro es compatible con una descompensación hiperglucémica aguda que exige estabilización y búsqueda del desencadenante.

Pregunta: ¿Cuál es la medida inicial más segura?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. iniciar reanimación con líquidos isotónicos, vigilar potasio y comenzar insulina solo después de confirmar que el potasio permite hacerlo*
- C. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: La reposición de volumen y la vigilancia de potasio anteceden a una insulino terapia segura; iniciar insulina con hipopotasemia puede precipitar arritmia. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Diagnóstico y Tratamiento Farmacológico de la Diabetes Mellitus Tipo 2 en el Primer Nivel de Atención. GPC-IMSS-718-18, 2018.

Especialidad: Medicina Interna

Tema: Endocrinología

Subtema: Cetoacidosis

Dificultad: alta

Caso clínico: Paciente de 34 años con diabetes conocida consulta por poliuria, polidipsia, dolor abdominal, respiración profunda y deterioro progresivo durante 24 horas tras suspender insulina por vómito. Tiene mucosas secas, taquicardia y sin foco neurológico. Los resultados iniciales muestran hiperglucemia marcada, cetonemia y acidosis metabólica con anión gap elevado. No existen antecedentes de alergia medicamentosa, pero hay barreras para regresar con rapidez si empeora. El cuadro es compatible con una descompensación hiperglucémica aguda que exige estabilización y búsqueda del desencadenante.

Pregunta: ¿Qué evaluación paralela es indispensable durante la estabilización?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- C. solicitar gases, electrolitos, cetonas y estudios dirigidos a desencadenante mientras se corrige volumen intravascular*
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: La crisis requiere cuantificar acidosis, cetosis y electrolitos, al mismo tiempo que se investiga infección, omisión de insulina u otro precipitante. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Diagnóstico y Tratamiento Farmacológico de la Diabetes Mellitus Tipo 2 en el Primer Nivel de Atención. GPC-IMSS-718-18, 2018.

Especialidad: Medicina Interna

Tema: Endocrinología

Subtema: Cetoacidosis

Dificultad: alta

Caso clínico: Paciente de 34 años con diabetes conocida consulta por poliuria, polidipsia, dolor abdominal, respiración profunda y deterioro progresivo durante 24 horas tras suspender insulina por vómito. Tiene mucosas secas, taquicardia y sin foco neurológico. Los resultados iniciales muestran hiperglucemia marcada, cetonemia y acidosis metabólica con anión gap elevado. No existen antecedentes de alergia medicamentosa, pero hay barreras para regresar con rapidez si empeora. El cuadro es compatible con una descompensación hiperglucémica aguda que exige estabilización y búsqueda del desencadenante.

Pregunta: ¿Cuál es la estrategia correcta cuando disminuye la glucemia pero persiste la acidosis?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- C. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación
- D. añadir glucosa a los líquidos cuando descienda la glucemia sin suspender la insulina hasta resolver la cetosis*

Explicación: La insulina se mantiene para suprimir cetogénesis; se administra glucosa para evitar hipoglucemia mientras se corrige la acidosis. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Diagnóstico y Tratamiento Farmacológico de la Diabetes Mellitus Tipo 2 en el Primer Nivel de Atención. GPC-IMSS-718-18, 2018.

Especialidad: Medicina Interna

Tema: Endocrinología

Subtema: Cetoacidosis

Dificultad: alta

Caso clínico: Paciente de 34 años con diabetes conocida consulta por poliuria, polidipsia, dolor abdominal, respiración profunda y deterioro progresivo durante 24 horas tras suspender insulina por vómito. Tiene mucosas secas, taquicardia y sin foco neurológico. Los resultados iniciales muestran hiperglucemia marcada, cetonemia y acidosis metabólica con anión gap elevado. No existen antecedentes de alergia medicamentosa, pero hay barreras para regresar con rapidez si empeora. El cuadro es compatible con una descompensación hiperglucémica aguda que exige estabilización y búsqueda del desencadenante.

Pregunta: ¿Qué elemento condiciona el inicio y la vigilancia de insulina?

- A. corregir el potasio de acuerdo con mediciones seriadas antes y durante la insulino terapia*
- B. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- C. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: El potasio se desplaza con insulina y corrección de acidosis, por lo que las determinaciones seriadas dirigen una reposición segura. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Diagnóstico y Tratamiento Farmacológico de la Diabetes Mellitus Tipo 2 en el Primer Nivel de Atención. GPC-IMSS-718-18, 2018.

Especialidad: Medicina Interna

Tema: Endocrinología

Subtema: Cetoacidosis

Dificultad: alta

Caso clínico: Paciente de 34 años con diabetes conocida consulta por poliuria, polidipsia, dolor abdominal, respiración profunda y deterioro progresivo durante 24 horas tras suspender insulina por vómito. Tiene mucosas secas, taquicardia y sin foco neurológico. Los resultados iniciales muestran hiperglucemia marcada, cetonemia y acidosis metabólica con anión gap elevado. No existen antecedentes de alergia medicamentosa, pero hay barreras para regresar con rapidez si empeora. El cuadro es compatible con una descompensación hiperglucémica aguda que exige estabilización y búsqueda del desencadenante.

Pregunta: ¿Qué criterio confirma resolución metabólica real?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. definir resolución por cierre de la acidosis y de la cetosis, no por una glucosa aislada*
- C. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: La normalización aislada de glucosa no equivale a resolución; deben corregirse cetosis y acidosis. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Diagnóstico y Tratamiento Farmacológico de la Diabetes Mellitus Tipo 2 en el Primer Nivel de Atención. GPC-IMSS-718-18, 2018.

Especialidad: Medicina Interna

Tema: Endocrinología

Subtema: Cetoacidosis

Dificultad: alta

Caso clínico: Paciente de 34 años con diabetes conocida consulta por poliuria, polidipsia, dolor abdominal, respiración profunda y deterioro progresivo durante 24 horas tras suspender insulina por vómito. Tiene mucosas secas, taquicardia y sin foco neurológico. Los resultados iniciales muestran hiperglucemia marcada, cetonemia y acidosis metabólica con anión gap elevado. La revisión de medicamentos identifica una posible exposición reciente que debe considerarse al integrar el riesgo. El cuadro es compatible con una descompensación hiperglucémica aguda que exige estabilización y búsqueda del desencadenante.

Pregunta: ¿Cuál es la medida inicial más segura?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- C. iniciar reanimación con líquidos isotónicos, vigilar potasio y comenzar insulina solo después de confirmar que el potasio permite hacerlo*
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: La reposición de volumen y la vigilancia de potasio anteceden a una insulino terapia segura; iniciar insulina con hipopotasemia puede precipitar arritmia. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Diagnóstico y Tratamiento Farmacológico de la Diabetes Mellitus Tipo 2 en el Primer Nivel de Atención. GPC-IMSS-718-18, 2018.

Especialidad: Medicina Interna

Tema: Endocrinología

Subtema: Cetoacidosis

Dificultad: alta

Caso clínico: Paciente de 34 años con diabetes conocida consulta por poliuria, polidipsia, dolor abdominal, respiración profunda y deterioro progresivo durante 24 horas tras suspender insulina por vómito. Tiene mucosas secas, taquicardia y sin foco neurológico. Los resultados iniciales muestran hiperglucemia marcada, cetonemia y acidosis metabólica con anión gap elevado. La revisión de medicamentos identifica una posible exposición reciente que debe considerarse al integrar el riesgo. El cuadro es compatible con una descompensación hiperglucémica aguda que exige estabilización y búsqueda del desencadenante.

Pregunta: ¿Qué evaluación paralela es indispensable durante la estabilización?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- C. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación
- D. solicitar gases, electrolitos, cetonas y estudios dirigidos a desencadenante mientras se corrige volumen intravascular*

Explicación: La crisis requiere cuantificar acidosis, cetosis y electrolitos, al mismo tiempo que se investiga infección, omisión de insulina u otro precipitante. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Diagnóstico y Tratamiento Farmacológico de la Diabetes Mellitus Tipo 2 en el Primer Nivel de Atención. GPC-IMSS-718-18, 2018.

Especialidad: Medicina Interna

Tema: Endocrinología

Subtema: Cetoacidosis

Dificultad: alta

Caso clínico: Paciente de 34 años con diabetes conocida consulta por poliuria, polidipsia, dolor abdominal, respiración profunda y deterioro progresivo durante 24 horas tras suspender insulina por vómito. Tiene mucosas secas, taquicardia y sin foco neurológico. Los resultados iniciales muestran hiperglucemia marcada, cetonemia y acidosis metabólica con anión gap elevado. La revisión de medicamentos identifica una posible exposición reciente que debe considerarse al integrar el riesgo. El cuadro es compatible con una descompensación hiperglucémica aguda que exige estabilización y búsqueda del desencadenante.

Pregunta: ¿Cuál es la estrategia correcta cuando disminuye la glucemia pero persiste la acidosis?

- A. añadir glucosa a los líquidos cuando descienda la glucemia sin suspender la insulina hasta resolver la cetosis*
- B. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- C. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: La insulina se mantiene para suprimir cetogénesis; se administra glucosa para evitar hipoglucemia mientras se corrige la acidosis. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Diagnóstico y Tratamiento Farmacológico de la Diabetes Mellitus Tipo 2 en el Primer Nivel de Atención. GPC-IMSS-718-18, 2018.

Especialidad: Medicina Interna

Tema: Endocrinología

Subtema: Cetoacidosis

Dificultad: alta

Caso clínico: Paciente de 34 años con diabetes conocida consulta por poliuria, polidipsia, dolor abdominal, respiración profunda y deterioro progresivo durante 24 horas tras suspender insulina por vómito. Tiene mucosas secas, taquicardia y sin foco neurológico. Los resultados iniciales muestran hiperglucemia marcada, cetonemia y acidosis metabólica con anión gap elevado. La revisión de medicamentos identifica una posible exposición reciente que debe considerarse al integrar el riesgo. El cuadro es compatible con una descompensación hiperglucémica aguda que exige estabilización y búsqueda del desencadenante.

Pregunta: ¿Qué elemento condiciona el inicio y la vigilancia de insulina?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. corregir el potasio de acuerdo con mediciones seriadas antes y durante la insulino terapia*
- C. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: El potasio se desplaza con insulina y corrección de acidosis, por lo que las determinaciones seriadas dirigen una reposición segura. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Diagnóstico y Tratamiento Farmacológico de la Diabetes Mellitus Tipo 2 en el Primer Nivel de Atención. GPC-IMSS-718-18, 2018.

Especialidad: Medicina Interna

Tema: Endocrinología

Subtema: Cetoacidosis

Dificultad: alta

Caso clínico: Paciente de 34 años con diabetes conocida consulta por poliuria, polidipsia, dolor abdominal, respiración profunda y deterioro progresivo durante 24 horas tras suspender insulina por vómito. Tiene mucosas secas, taquicardia y sin foco neurológico. Los resultados iniciales muestran hiperglucemia marcada, cetonemia y acidosis metabólica con anión gap elevado. La revisión de medicamentos identifica una posible exposición reciente que debe considerarse al integrar el riesgo. El cuadro es compatible con una descompensación hiperglucémica aguda que exige estabilización y búsqueda del desencadenante.

Pregunta: ¿Qué criterio confirma resolución metabólica real?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- C. definir resolución por cierre de la acidosis y de la cetosis, no por una glucosa aislada*
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: La normalización aislada de glucosa no equivale a resolución; deben corregirse cetosis y acidosis. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Diagnóstico y Tratamiento Farmacológico de la Diabetes Mellitus Tipo 2 en el Primer Nivel de Atención. GPC-IMSS-718-18, 2018.

Especialidad: Medicina Interna

Tema: Endocrinología

Subtema: Cetoacidosis

Dificultad: alta

Caso clínico: Paciente de 34 años con diabetes conocida consulta por poliuria, polidipsia, dolor abdominal, respiración profunda y deterioro progresivo durante 24 horas tras suspender insulina por vómito. Tiene mucosas secas, taquicardia y sin foco neurológico. Los resultados iniciales muestran hiperglucemia marcada, cetonemia y acidosis metabólica con anión gap elevado. Los signos vitales se repiten después de una primera medida de soporte y muestran la misma tendencia clínica. El cuadro es compatible con una descompensación hiperglucémica aguda que exige estabilización y búsqueda del desencadenante.

Pregunta: ¿Cuál es la medida inicial más segura?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- C. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación
- D. iniciar reanimación con líquidos isotónicos, vigilar potasio y comenzar insulina solo después de confirmar que el potasio permite hacerlo*

Explicación: La reposición de volumen y la vigilancia de potasio anteceden a una insulino terapia segura; iniciar insulina con hipopotasemia puede precipitar arritmia. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Diagnóstico y Tratamiento Farmacológico de la Diabetes Mellitus Tipo 2 en el Primer Nivel de Atención. GPC-IMSS-718-18, 2018.

Especialidad: Medicina Interna

Tema: Endocrinología

Subtema: Cetoacidosis

Dificultad: alta

Caso clínico: Paciente de 34 años con diabetes conocida consulta por poliuria, polidipsia, dolor abdominal, respiración profunda y deterioro progresivo durante 24 horas tras suspender insulina por vómito. Tiene mucosas secas, taquicardia y sin foco neurológico. Los resultados iniciales muestran hiperglucemia marcada, cetonemia y acidosis metabólica con anión gap elevado. Los signos vitales se repiten después de una primera medida de soporte y muestran la misma tendencia clínica. El cuadro es compatible con una descompensación hiperglucémica aguda que exige estabilización y búsqueda del desencadenante.

Pregunta: ¿Qué evaluación paralela es indispensable durante la estabilización?

- A. solicitar gases, electrolitos, cetonas y estudios dirigidos a desencadenante mientras se corrige volumen intravascular*
- B. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- C. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: La crisis requiere cuantificar acidosis, cetosis y electrolitos, al mismo tiempo que se investiga infección, omisión de insulina u otro precipitante. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Diagnóstico y Tratamiento Farmacológico de la Diabetes Mellitus Tipo 2 en el Primer Nivel de Atención. GPC-IMSS-718-18, 2018.

Especialidad: Medicina Interna

Tema: Endocrinología

Subtema: Cetoacidosis

Dificultad: alta

Caso clínico: Paciente de 34 años con diabetes conocida consulta por poliuria, polidipsia, dolor abdominal, respiración profunda y deterioro progresivo durante 24 horas tras suspender insulina por vómito. Tiene mucosas secas, taquicardia y sin foco neurológico. Los resultados iniciales muestran hiperglucemia marcada, cetonemia y acidosis metabólica con anión gap elevado. Los signos vitales se repiten después de una primera medida de soporte y muestran la misma tendencia clínica. El cuadro es compatible con una descompensación hiperglucémica aguda que exige estabilización y búsqueda del desencadenante.

Pregunta: ¿Cuál es la estrategia correcta cuando disminuye la glucemia pero persiste la acidosis?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. añadir glucosa a los líquidos cuando descienda la glucemia sin suspender la insulina hasta resolver la cetosis*
- C. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: La insulina se mantiene para suprimir cetogénesis; se administra glucosa para evitar hipoglucemia mientras se corrige la acidosis. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Diagnóstico y Tratamiento Farmacológico de la Diabetes Mellitus Tipo 2 en el Primer Nivel de Atención. GPC-IMSS-718-18, 2018.

Especialidad: Medicina Interna

Tema: Endocrinología

Subtema: Cetoacidosis

Dificultad: alta

Caso clínico: Paciente de 34 años con diabetes conocida consulta por poliuria, polidipsia, dolor abdominal, respiración profunda y deterioro progresivo durante 24 horas tras suspender insulina por vómito. Tiene mucosas secas, taquicardia y sin foco neurológico. Los resultados iniciales muestran hiperglucemia marcada, cetonemia y acidosis metabólica con anión gap elevado. Los signos vitales se repiten después de una primera medida de soporte y muestran la misma tendencia clínica. El cuadro es compatible con una descompensación hiperglucémica aguda que exige estabilización y búsqueda del desencadenante.

Pregunta: ¿Qué elemento condiciona el inicio y la vigilancia de insulina?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- C. corregir el potasio de acuerdo con mediciones seriadas antes y durante la insulino terapia*
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: El potasio se desplaza con insulina y corrección de acidosis, por lo que las determinaciones seriadas dirigen una reposición segura. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Diagnóstico y Tratamiento Farmacológico de la Diabetes Mellitus Tipo 2 en el Primer Nivel de Atención. GPC-IMSS-718-18, 2018.

Especialidad: Medicina Interna

Tema: Endocrinología

Subtema: Cetoacidosis

Dificultad: alta

Caso clínico: Paciente de 34 años con diabetes conocida consulta por poliuria, polidipsia, dolor abdominal, respiración profunda y deterioro progresivo durante 24 horas tras suspender insulina por vómito. Tiene mucosas secas, taquicardia y sin foco neurológico. Los resultados iniciales muestran hiperglucemia marcada, cetonemia y acidosis metabólica con anión gap elevado. Los signos vitales se repiten después de una primera medida de soporte y muestran la misma tendencia clínica. El cuadro es compatible con una descompensación hiperglucémica aguda que exige estabilización y búsqueda del desencadenante.

Pregunta: ¿Qué criterio confirma resolución metabólica real?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- C. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación
- D. definir resolución por cierre de la acidosis y de la cetosis, no por una glucosa aislada*

Explicación: La normalización aislada de glucosa no equivale a resolución; deben corregirse cetosis y acidosis. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Diagnóstico y Tratamiento Farmacológico de la Diabetes Mellitus Tipo 2 en el Primer Nivel de Atención. GPC-IMSS-718-18, 2018.

Especialidad: Cirugía

Tema: Cirrosis y sus Complicaciones

Subtema: Encefalopatía Hepática

Dificultad: alta

Caso clínico: Paciente de 61 años con cirrosis descompensada es llevado por inversión del sueño, desorientación, asterixis y lenguaje enlentecido. No tiene déficit focal. Familiares refieren estreñimiento de varios días y uso reciente de sedantes. Se documenta ascitis y no existe una hemorragia manifiesta en la valoración inicial. La evolución se ha modificado durante las últimas 12 horas y los familiares pueden aportar una cronología fiable. La presentación es sugestiva de encefalopatía hepática manifiesta y obliga a excluir precipitantes corregibles.

Pregunta: ¿Cuál es la conducta inicial más apropiada?

- A. iniciar tratamiento para reducir la carga nitrogenada intestinal y corregir en paralelo el precipitante identificado*
- B. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- C. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: La encefalopatía exige disminuir la producción y absorción intestinal de compuestos nitrogenados y resolver el precipitante; ambos componentes son complementarios. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Encefalopatía Hepática en el Adulto. GPC-IMSS-685-13.

Especialidad: Cirugía

Tema: Cirrosis y sus Complicaciones

Subtema: Encefalopatía Hepática

Dificultad: alta

Caso clínico: Paciente de 61 años con cirrosis descompensada es llevado por inversión del sueño, desorientación, asterixis y lenguaje enlentecido. No tiene déficit focal. Familiares refieren estreñimiento de varios días y uso reciente de sedantes. Se documenta ascitis y no existe una hemorragia manifiesta en la valoración inicial. La evolución se ha modificado durante las últimas 12 horas y los familiares pueden aportar una cronología fiable. La presentación es sugestiva de encefalopatía hepática manifiesta y obliga a excluir precipitantes corregibles.

Pregunta: ¿Qué estrategia diagnóstica cambia de forma inmediata el pronóstico?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. buscar de forma dirigida infección, hemorragia digestiva, estreñimiento, deshidratación, alteraciones electrolíticas y fármacos depresores*
- C. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: La causa precipitante suele ser reversible y puede ser más peligrosa que la elevación de amonio por sí sola. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Encefalopatía Hepática en el Adulto. GPC-IMSS-685-13.

Especialidad: Cirugía

Tema: Cirrosis y sus Complicaciones

Subtema: Encefalopatía Hepática

Dificultad: alta

Caso clínico: Paciente de 61 años con cirrosis descompensada es llevado por inversión del sueño, desorientación, asterixis y lenguaje enlentecido. No tiene déficit focal. Familiares refieren estreñimiento de varios días y uso reciente de sedantes. Se documenta ascitis y no existe una hemorragia manifiesta en la valoración inicial. La evolución se ha modificado durante las últimas 12 horas y los familiares pueden aportar una cronología fiable. La presentación es sugestiva de encefalopatía hepática manifiesta y obliga a excluir precipitantes corregibles.

Pregunta: ¿Cuándo debe priorizarse soporte crítico?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- C. proteger vía aérea y hospitalizar si el estado mental impide una administración segura o existe riesgo de aspiración*
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: El compromiso profundo de conciencia transforma el caso en una urgencia de vía aérea y vigilancia hospitalaria. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Encefalopatía Hepática en el Adulto. GPC-IMSS-685-13.

Especialidad: Cirugía

Tema: Cirrosis y sus Complicaciones

Subtema: Encefalopatía Hepática

Dificultad: alta

Caso clínico: Paciente de 61 años con cirrosis descompensada es llevado por inversión del sueño, desorientación, asterixis y lenguaje enlentecido. No tiene déficit focal. Familiares refieren estreñimiento de varios días y uso reciente de sedantes. Se documenta ascitis y no existe una hemorragia manifiesta en la valoración inicial. La evolución se ha modificado durante las últimas 12 horas y los familiares pueden aportar una cronología fiable. La presentación es sugestiva de encefalopatía hepática manifiesta y obliga a excluir precipitantes corregibles.

Pregunta: ¿Qué intervención nutricional debe evitarse?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- C. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación
- D. evitar restricción proteica sostenida y mantener un aporte nutricional adecuado una vez estabilizado*

Explicación: La restricción proteica prolongada empeora sarcopenia y no es el objetivo terapéutico; la nutrición debe preservarse. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Encefalopatía Hepática en el Adulto. GPC-IMSS-685-13.

Especialidad: Cirugía

Tema: Cirrosis y sus Complicaciones

Subtema: Encefalopatía Hepática

Dificultad: alta

Caso clínico: Paciente de 61 años con cirrosis descompensada es llevado por inversión del sueño, desorientación, asterixis y lenguaje enlentecido. No tiene déficit focal. Familiares refieren estreñimiento de varios días y uso reciente de sedantes. Se documenta ascitis y no existe una hemorragia manifiesta en la valoración inicial. La evolución se ha modificado durante las últimas 12 horas y los familiares pueden aportar una cronología fiable. La presentación es sugestiva de encefalopatía hepática manifiesta y obliga a excluir precipitantes corregibles.

Pregunta: ¿Qué conducta reduce recurrencias después de recuperar el estado mental?

- A. planear prevención secundaria tras la recuperación mediante control de precipitantes y tratamiento intestinal*
- B. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- C. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: La recurrencia disminuye al controlar estreñimiento, infecciones y otros disparadores, junto con un esquema preventivo individualizado. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Encefalopatía Hepática en el Adulto. GPC-IMSS-685-13.

Especialidad: Cirugía

Tema: Cirrosis y sus Complicaciones

Subtema: Encefalopatía Hepática

Dificultad: alta

Caso clínico: Paciente de 61 años con cirrosis descompensada es llevado por inversión del sueño, desorientación, asterixis y lenguaje enlentecido. No tiene déficit focal. Familiares refieren estreñimiento de varios días y uso reciente de sedantes. Se documenta ascitis y no existe una hemorragia manifiesta en la valoración inicial. No existen antecedentes de alergia medicamentosa, pero hay barreras para regresar con rapidez si empeora. La presentación es sugestiva de encefalopatía hepática manifiesta y obliga a excluir precipitantes corregibles.

Pregunta: ¿Cuál es la conducta inicial más apropiada?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. iniciar tratamiento para reducir la carga nitrogenada intestinal y corregir en paralelo el precipitante identificado*
- C. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: La encefalopatía exige disminuir la producción y absorción intestinal de compuestos nitrogenados y resolver el precipitante; ambos componentes son complementarios. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Encefalopatía Hepática en el Adulto. GPC-IMSS-685-13.

Especialidad: Cirugía

Tema: Cirrosis y sus Complicaciones

Subtema: Encefalopatía Hepática

Dificultad: alta

Caso clínico: Paciente de 61 años con cirrosis descompensada es llevado por inversión del sueño, desorientación, asterixis y lenguaje enlentecido. No tiene déficit focal. Familiares refieren estreñimiento de varios días y uso reciente de sedantes. Se documenta ascitis y no existe una hemorragia manifiesta en la valoración inicial. No existen antecedentes de alergia medicamentosa, pero hay barreras para regresar con rapidez si empeora. La presentación es sugestiva de encefalopatía hepática manifiesta y obliga a excluir precipitantes corregibles.

Pregunta: ¿Qué estrategia diagnóstica cambia de forma inmediata el pronóstico?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- C. buscar de forma dirigida infección, hemorragia digestiva, estreñimiento, deshidratación, alteraciones electrolíticas y fármacos depresores*
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: La causa precipitante suele ser reversible y puede ser más peligrosa que la elevación de amonio por sí sola. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Encefalopatía Hepática en el Adulto. GPC-IMSS-685-13.

Especialidad: Cirugía

Tema: Cirrosis y sus Complicaciones

Subtema: Encefalopatía Hepática

Dificultad: alta

Caso clínico: Paciente de 61 años con cirrosis descompensada es llevado por inversión del sueño, desorientación, asterixis y lenguaje enlentecido. No tiene déficit focal. Familiares refieren estreñimiento de varios días y uso reciente de sedantes. Se documenta ascitis y no existe una hemorragia manifiesta en la valoración inicial. No existen antecedentes de alergia medicamentosa, pero hay barreras para regresar con rapidez si empeora. La presentación es sugestiva de encefalopatía hepática manifiesta y obliga a excluir precipitantes corregibles.

Pregunta: ¿Cuándo debe priorizarse soporte crítico?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- C. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación
- D. proteger vía aérea y hospitalizar si el estado mental impide una administración segura o existe riesgo de aspiración*

Explicación: El compromiso profundo de conciencia transforma el caso en una urgencia de vía aérea y vigilancia hospitalaria. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Encefalopatía Hepática en el Adulto. GPC-IMSS-685-13.

Especialidad: Cirugía

Tema: Cirrosis y sus Complicaciones

Subtema: Encefalopatía Hepática

Dificultad: alta

Caso clínico: Paciente de 61 años con cirrosis descompensada es llevado por inversión del sueño, desorientación, asterixis y lenguaje enlentecido. No tiene déficit focal. Familiares refieren estreñimiento de varios días y uso reciente de sedantes. Se documenta ascitis y no existe una hemorragia manifiesta en la valoración inicial. No existen antecedentes de alergia medicamentosa, pero hay barreras para regresar con rapidez si empeora. La presentación es sugestiva de encefalopatía hepática manifiesta y obliga a excluir precipitantes corregibles.

Pregunta: ¿Qué intervención nutricional debe evitarse?

- A. evitar restricción proteica sostenida y mantener un aporte nutricional adecuado una vez estabilizado*
- B. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- C. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: La restricción proteica prolongada empeora sarcopenia y no es el objetivo terapéutico; la nutrición debe preservarse. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Encefalopatía Hepática en el Adulto. GPC-IMSS-685-13.

Especialidad: Cirugía

Tema: Cirrosis y sus Complicaciones

Subtema: Encefalopatía Hepática

Dificultad: alta

Caso clínico: Paciente de 61 años con cirrosis descompensada es llevado por inversión del sueño, desorientación, asterixis y lenguaje enlentecido. No tiene déficit focal. Familiares refieren estreñimiento de varios días y uso reciente de sedantes. Se documenta ascitis y no existe una hemorragia manifiesta en la valoración inicial. No existen antecedentes de alergia medicamentosa, pero hay barreras para regresar con rapidez si empeora. La presentación es sugestiva de encefalopatía hepática manifiesta y obliga a excluir precipitantes corregibles.

Pregunta: ¿Qué conducta reduce recurrencias después de recuperar el estado mental?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. planear prevención secundaria tras la recuperación mediante control de precipitantes y tratamiento intestinal*
- C. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: La recurrencia disminuye al controlar estreñimiento, infecciones y otros disparadores, junto con un esquema preventivo individualizado. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Encefalopatía Hepática en el Adulto. GPC-IMSS-685-13.

Especialidad: Cirugía

Tema: Cirrosis y sus Complicaciones

Subtema: Encefalopatía Hepática

Dificultad: alta

Caso clínico: Paciente de 61 años con cirrosis descompensada es llevado por inversión del sueño, desorientación, asterixis y lenguaje enlentecido. No tiene déficit focal. Familiares refieren estreñimiento de varios días y uso reciente de sedantes. Se documenta ascitis y no existe una hemorragia manifiesta en la valoración inicial. La revisión de medicamentos identifica una posible exposición reciente que debe considerarse al integrar el riesgo. La presentación es sugestiva de encefalopatía hepática manifiesta y obliga a excluir precipitantes corregibles.

Pregunta: ¿Cuál es la conducta inicial más apropiada?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- C. iniciar tratamiento para reducir la carga nitrogenada intestinal y corregir en paralelo el precipitante identificado*
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: La encefalopatía exige disminuir la producción y absorción intestinal de compuestos nitrogenados y resolver el precipitante; ambos componentes son complementarios. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Encefalopatía Hepática en el Adulto. GPC-IMSS-685-13.

Especialidad: Cirugía

Tema: Cirrosis y sus Complicaciones

Subtema: Encefalopatía Hepática

Dificultad: alta

Caso clínico: Paciente de 61 años con cirrosis descompensada es llevado por inversión del sueño, desorientación, asterixis y lenguaje enlentecido. No tiene déficit focal. Familiares refieren estreñimiento de varios días y uso reciente de sedantes. Se documenta ascitis y no existe una hemorragia manifiesta en la valoración inicial. La revisión de medicamentos identifica una posible exposición reciente que debe considerarse al integrar el riesgo. La presentación es sugestiva de encefalopatía hepática manifiesta y obliga a excluir precipitantes corregibles.

Pregunta: ¿Qué estrategia diagnóstica cambia de forma inmediata el pronóstico?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- C. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación
- D. buscar de forma dirigida infección, hemorragia digestiva, estreñimiento, deshidratación, alteraciones electrolíticas y fármacos depresores*

Explicación: La causa precipitante suele ser reversible y puede ser más peligrosa que la elevación de amonio por sí sola. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Encefalopatía Hepática en el Adulto. GPC-IMSS-685-13.

Especialidad: Cirugía

Tema: Cirrosis y sus Complicaciones

Subtema: Encefalopatía Hepática

Dificultad: alta

Caso clínico: Paciente de 61 años con cirrosis descompensada es llevado por inversión del sueño, desorientación, asterixis y lenguaje enlentecido. No tiene déficit focal. Familiares refieren estreñimiento de varios días y uso reciente de sedantes. Se documenta ascitis y no existe una hemorragia manifiesta en la valoración inicial. La revisión de medicamentos identifica una posible exposición reciente que debe considerarse al integrar el riesgo. La presentación es sugestiva de encefalopatía hepática manifiesta y obliga a excluir precipitantes corregibles.

Pregunta: ¿Cuándo debe priorizarse soporte crítico?

- A. proteger vía aérea y hospitalizar si el estado mental impide una administración segura o existe riesgo de aspiración*
- B. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- C. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: El compromiso profundo de conciencia transforma el caso en una urgencia de vía aérea y vigilancia hospitalaria. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Encefalopatía Hepática en el Adulto. GPC-IMSS-685-13.

Especialidad: Cirugía

Tema: Cirrosis y sus Complicaciones

Subtema: Encefalopatía Hepática

Dificultad: alta

Caso clínico: Paciente de 61 años con cirrosis descompensada es llevado por inversión del sueño, desorientación, asterixis y lenguaje enlentecido. No tiene déficit focal. Familiares refieren estreñimiento de varios días y uso reciente de sedantes. Se documenta ascitis y no existe una hemorragia manifiesta en la valoración inicial. La revisión de medicamentos identifica una posible exposición reciente que debe considerarse al integrar el riesgo. La presentación es sugestiva de encefalopatía hepática manifiesta y obliga a excluir precipitantes corregibles.

Pregunta: ¿Qué intervención nutricional debe evitarse?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. evitar restricción proteica sostenida y mantener un aporte nutricional adecuado una vez estabilizado*
- C. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: La restricción proteica prolongada empeora sarcopenia y no es el objetivo terapéutico; la nutrición debe preservarse. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Encefalopatía Hepática en el Adulto. GPC-IMSS-685-13.

Especialidad: Cirugía

Tema: Cirrosis y sus Complicaciones

Subtema: Encefalopatía Hepática

Dificultad: alta

Caso clínico: Paciente de 61 años con cirrosis descompensada es llevado por inversión del sueño, desorientación, asterixis y lenguaje enlentecido. No tiene déficit focal. Familiares refieren estreñimiento de varios días y uso reciente de sedantes. Se documenta ascitis y no existe una hemorragia manifiesta en la valoración inicial. La revisión de medicamentos identifica una posible exposición reciente que debe considerarse al integrar el riesgo. La presentación es sugestiva de encefalopatía hepática manifiesta y obliga a excluir precipitantes corregibles.

Pregunta: ¿Qué conducta reduce recurrencias después de recuperar el estado mental?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- C. planear prevención secundaria tras la recuperación mediante control de precipitantes y tratamiento intestinal*
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: La recurrencia disminuye al controlar estreñimiento, infecciones y otros disparadores, junto con un esquema preventivo individualizado. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Encefalopatía Hepática en el Adulto. GPC-IMSS-685-13.

Especialidad: Cirugía

Tema: Cirrosis y sus Complicaciones

Subtema: Encefalopatía Hepática

Dificultad: alta

Caso clínico: Paciente de 61 años con cirrosis descompensada es llevado por inversión del sueño, desorientación, asterixis y lenguaje enlentecido. No tiene déficit focal. Familiares refieren estreñimiento de varios días y uso reciente de sedantes. Se documenta ascitis y no existe una hemorragia manifiesta en la valoración inicial. Los signos vitales se repiten después de una primera medida de soporte y muestran la misma tendencia clínica. La presentación es sugestiva de encefalopatía hepática manifiesta y obliga a excluir precipitantes corregibles.

Pregunta: ¿Cuál es la conducta inicial más apropiada?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- C. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación
- D. iniciar tratamiento para reducir la carga nitrogenada intestinal y corregir en paralelo el precipitante identificado*

Explicación: La encefalopatía exige disminuir la producción y absorción intestinal de compuestos nitrogenados y resolver el precipitante; ambos componentes son complementarios. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Encefalopatía Hepática en el Adulto. GPC-IMSS-685-13.

Especialidad: Cirugía

Tema: Cirrosis y sus Complicaciones

Subtema: Encefalopatía Hepática

Dificultad: alta

Caso clínico: Paciente de 61 años con cirrosis descompensada es llevado por inversión del sueño, desorientación, asterixis y lenguaje enlentecido. No tiene déficit focal. Familiares refieren estreñimiento de varios días y uso reciente de sedantes. Se documenta ascitis y no existe una hemorragia manifiesta en la valoración inicial. Los signos vitales se repiten después de una primera medida de soporte y muestran la misma tendencia clínica. La presentación es sugestiva de encefalopatía hepática manifiesta y obliga a excluir precipitantes corregibles.

Pregunta: ¿Qué estrategia diagnóstica cambia de forma inmediata el pronóstico?

- A. buscar de forma dirigida infección, hemorragia digestiva, estreñimiento, deshidratación, alteraciones electrolíticas y fármacos depresores*
- B. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- C. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: La causa precipitante suele ser reversible y puede ser más peligrosa que la elevación de amonio por sí sola. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Encefalopatía Hepática en el Adulto. GPC-IMSS-685-13.

Especialidad: Cirugía

Tema: Cirrosis y sus Complicaciones

Subtema: Encefalopatía Hepática

Dificultad: alta

Caso clínico: Paciente de 61 años con cirrosis descompensada es llevado por inversión del sueño, desorientación, asterixis y lenguaje enlentecido. No tiene déficit focal. Familiares refieren estreñimiento de varios días y uso reciente de sedantes. Se documenta ascitis y no existe una hemorragia manifiesta en la valoración inicial. Los signos vitales se repiten después de una primera medida de soporte y muestran la misma tendencia clínica. La presentación es sugestiva de encefalopatía hepática manifiesta y obliga a excluir precipitantes corregibles.

Pregunta: ¿Cuándo debe priorizarse soporte crítico?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. proteger vía aérea y hospitalizar si el estado mental impide una administración segura o existe riesgo de aspiración*
- C. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: El compromiso profundo de conciencia transforma el caso en una urgencia de vía aérea y vigilancia hospitalaria. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Encefalopatía Hepática en el Adulto. GPC-IMSS-685-13.

Especialidad: Cirugía

Tema: Cirrosis y sus Complicaciones

Subtema: Encefalopatía Hepática

Dificultad: alta

Caso clínico: Paciente de 61 años con cirrosis descompensada es llevado por inversión del sueño, desorientación, asterixis y lenguaje enlentecido. No tiene déficit focal. Familiares refieren estreñimiento de varios días y uso reciente de sedantes. Se documenta ascitis y no existe una hemorragia manifiesta en la valoración inicial. Los signos vitales se repiten después de una primera medida de soporte y muestran la misma tendencia clínica. La presentación es sugestiva de encefalopatía hepática manifiesta y obliga a excluir precipitantes corregibles.

Pregunta: ¿Qué intervención nutricional debe evitarse?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- C. evitar restricción proteica sostenida y mantener un aporte nutricional adecuado una vez estabilizado*
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: La restricción proteica prolongada empeora sarcopenia y no es el objetivo terapéutico; la nutrición debe preservarse. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Encefalopatía Hepática en el Adulto. GPC-IMSS-685-13.

Especialidad: Cirugía

Tema: Cirrosis y sus Complicaciones

Subtema: Encefalopatía Hepática

Dificultad: alta

Caso clínico: Paciente de 61 años con cirrosis descompensada es llevado por inversión del sueño, desorientación, asterixis y lenguaje enlentecido. No tiene déficit focal. Familiares refieren estreñimiento de varios días y uso reciente de sedantes. Se documenta ascitis y no existe una hemorragia manifiesta en la valoración inicial. Los signos vitales se repiten después de una primera medida de soporte y muestran la misma tendencia clínica. La presentación es sugestiva de encefalopatía hepática manifiesta y obliga a excluir precipitantes corregibles.

Pregunta: ¿Qué conducta reduce recurrencias después de recuperar el estado mental?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- C. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación
- D. planear prevención secundaria tras la recuperación mediante control de precipitantes y tratamiento intestinal*

Explicación: La recurrencia disminuye al controlar estreñimiento, infecciones y otros disparadores, junto con un esquema preventivo individualizado. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Encefalopatía Hepática en el Adulto. GPC-IMSS-685-13.

Especialidad: Cirugía

Tema: Patología Biliar

Subtema: Colecistitis

Dificultad: alta

Caso clínico: Paciente de 46 años con dolor persistente en hipocondrio derecho tras ingesta grasa, náusea, fiebre y signo de Murphy. La biometría muestra leucocitosis y la ecografía identifica litos, engrosamiento de pared y líquido perivesicular, sin una dilatación clara de la vía biliar principal. La evolución se ha modificado durante las últimas 12 horas y los familiares pueden aportar una cronología fiable. Los datos clínicos y ultrasonográficos integran colecistitis aguda litiásica sin evidencia inicial de obstrucción biliar mayor.

Pregunta: ¿Cuál es el manejo inicial más congruente?

- A. iniciar analgesia, ayuno, líquidos y antimicrobianos cuando estén indicados, con valoración para colecistectomía temprana*
- B. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- C. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: La estabilización incluye analgesia, medidas de soporte y valoración quirúrgica oportuna; el manejo definitivo no debe sustituirse por analgesia aislada. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Diagnóstico y Tratamiento de Colecistitis y Colelitiasis en el Primero y Segundo Nivel de Atención. GPC-IMSS-237-09.

Especialidad: Cirugía

Tema: Patología Biliar

Subtema: Colecistitis

Dificultad: alta

Caso clínico: Paciente de 46 años con dolor persistente en hipocondrio derecho tras ingesta grasa, náusea, fiebre y signo de Murphy. La biometría muestra leucocitosis y la ecografía identifica litos, engrosamiento de pared y líquido perivesicular, sin una dilatación clara de la vía biliar principal. La evolución se ha modificado durante las últimas 12 horas y los familiares pueden aportar una cronología fiable. Los datos clínicos y ultrasonográficos integran colecistitis aguda litiásica sin evidencia inicial de obstrucción biliar mayor.

Pregunta: ¿Qué paso evita explorar la vía biliar sin justificación?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. evaluar datos clínicos y bioquímicos de coledocolitiasis antes de indicar estudio o intervención de la vía biliar*
- C. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: La probabilidad de coledocolitiasis se estima con clínica, pruebas hepáticas e imagen, para reservar estudios invasivos a quienes los necesitan. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Diagnóstico y Tratamiento de Colecistitis y Colelitiasis en el Primero y Segundo Nivel de Atención. GPC-IMSS-237-09.

Especialidad: Cirugía

Tema: Patología Biliar

Subtema: Colecistitis

Dificultad: alta

Caso clínico: Paciente de 46 años con dolor persistente en hipocondrio derecho tras ingesta grasa, náusea, fiebre y signo de Murphy. La biometría muestra leucocitosis y la ecografía identifica litos, engrosamiento de pared y líquido perivesicular, sin una dilatación clara de la vía biliar principal. La evolución se ha modificado durante las últimas 12 horas y los familiares pueden aportar una cronología fiable. Los datos clínicos y ultrasonográficos integran colecistitis aguda litiásica sin evidencia inicial de obstrucción biliar mayor.

Pregunta: ¿Qué variable debe ordenar la estrategia de control del foco?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- C. definir gravedad y comorbilidades antes de decidir abordaje quirúrgico o drenaje*
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: La gravedad fisiológica y el riesgo quirúrgico determinan si conviene intervención temprana, drenaje o estabilización previa. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Diagnóstico y Tratamiento de Colecistitis y Colelitiasis en el Primero y Segundo Nivel de Atención. GPC-IMSS-237-09.

Especialidad: Cirugía

Tema: Patología Biliar

Subtema: Colecistitis

Dificultad: alta

Caso clínico: Paciente de 46 años con dolor persistente en hipocondrio derecho tras ingesta grasa, náusea, fiebre y signo de Murphy. La biometría muestra leucocitosis y la ecografía identifica litos, engrosamiento de pared y líquido perivesicular, sin una dilatación clara de la vía biliar principal. La evolución se ha modificado durante las últimas 12 horas y los familiares pueden aportar una cronología fiable. Los datos clínicos y ultrasonográficos integran colecistitis aguda litiásica sin evidencia inicial de obstrucción biliar mayor.

Pregunta: ¿Cuál es el estudio inicial de mayor utilidad en este cuadro?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- C. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación
- D. solicitar ultrasonido como estudio inicial cuando el cuadro clínico es compatible*

Explicación: El ultrasonido integra cálculos, pared vesicular, Murphy sonográfico y cambios perivesiculares, por lo que es la primera herramienta apropiada. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Diagnóstico y Tratamiento de Colecistitis y Colelitiasis en el Primero y Segundo Nivel de Atención. GPC-IMSS-237-09.

Especialidad: Cirugía

Tema: Patología Biliar

Subtema: Colecistitis

Dificultad: alta

Caso clínico: Paciente de 46 años con dolor persistente en hipocondrio derecho tras ingesta grasa, náusea, fiebre y signo de Murphy. La biometría muestra leucocitosis y la ecografía identifica litos, engrosamiento de pared y líquido perivesicular, sin una dilatación clara de la vía biliar principal. La evolución se ha modificado durante las últimas 12 horas y los familiares pueden aportar una cronología fiable. Los datos clínicos y ultrasonográficos integran colecistitis aguda litiásica sin evidencia inicial de obstrucción biliar mayor.

Pregunta: ¿Qué conducta evita manejo incompleto de la enfermedad litiásica?

- A. vigilar evolución y establecer un plan de resolución definitiva, no solo el alivio transitorio de síntomas*
- B. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- C. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: La mejoría sintomática no elimina la fuente litiásica ni previene nuevos episodios; debe planearse resolución definitiva. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Diagnóstico y Tratamiento de Colecistitis y Colelitiasis en el Primero y Segundo Nivel de Atención. GPC-IMSS-237-09.

Especialidad: Cirugía

Tema: Patología Biliar

Subtema: Colecistitis

Dificultad: alta

Caso clínico: Paciente de 46 años con dolor persistente en hipocondrio derecho tras ingesta grasa, náusea, fiebre y signo de Murphy. La biometría muestra leucocitosis y la ecografía identifica litos, engrosamiento de pared y líquido perivesicular, sin una dilatación clara de la vía biliar principal. No existen antecedentes de alergia medicamentosa, pero hay barreras para regresar con rapidez si empeora. Los datos clínicos y ultrasonográficos integran colecistitis aguda litiásica sin evidencia inicial de obstrucción biliar mayor.

Pregunta: ¿Cuál es el manejo inicial más congruente?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. iniciar analgesia, ayuno, líquidos y antimicrobianos cuando estén indicados, con valoración para colecistectomía temprana*
- C. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: La estabilización incluye analgesia, medidas de soporte y valoración quirúrgica oportuna; el manejo definitivo no debe sustituirse por analgesia aislada. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Diagnóstico y Tratamiento de Colecistitis y Colelitiasis en el Primero y Segundo Nivel de Atención. GPC-IMSS-237-09.

Especialidad: Cirugía

Tema: Patología Biliar

Subtema: Colecistitis

Dificultad: alta

Caso clínico: Paciente de 46 años con dolor persistente en hipocondrio derecho tras ingesta grasa, náusea, fiebre y signo de Murphy. La biometría muestra leucocitosis y la ecografía identifica litos, engrosamiento de pared y líquido perivesicular, sin una dilatación clara de la vía biliar principal. No existen antecedentes de alergia medicamentosa, pero hay barreras para regresar con rapidez si empeora. Los datos clínicos y ultrasonográficos integran colecistitis aguda litiásica sin evidencia inicial de obstrucción biliar mayor.

Pregunta: ¿Qué paso evita explorar la vía biliar sin justificación?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- C. evaluar datos clínicos y bioquímicos de coledocolitiasis antes de indicar estudio o intervención de la vía biliar*
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: La probabilidad de coledocolitiasis se estima con clínica, pruebas hepáticas e imagen, para reservar estudios invasivos a quienes los necesitan. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Diagnóstico y Tratamiento de Colecistitis y Colelitiasis en el Primero y Segundo Nivel de Atención. GPC-IMSS-237-09.

Especialidad: Cirugía

Tema: Patología Biliar

Subtema: Colecistitis

Dificultad: alta

Caso clínico: Paciente de 46 años con dolor persistente en hipocondrio derecho tras ingesta grasa, náusea, fiebre y signo de Murphy. La biometría muestra leucocitosis y la ecografía identifica litos, engrosamiento de pared y líquido perivesicular, sin una dilatación clara de la vía biliar principal. No existen antecedentes de alergia medicamentosa, pero hay barreras para regresar con rapidez si empeora. Los datos clínicos y ultrasonográficos integran colecistitis aguda litiásica sin evidencia inicial de obstrucción biliar mayor.

Pregunta: ¿Qué variable debe ordenar la estrategia de control del foco?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- C. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación
- D. definir gravedad y comorbilidades antes de decidir abordaje quirúrgico o drenaje*

Explicación: La gravedad fisiológica y el riesgo quirúrgico determinan si conviene intervención temprana, drenaje o estabilización previa. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Diagnóstico y Tratamiento de Colecistitis y Colelitiasis en el Primero y Segundo Nivel de Atención. GPC-IMSS-237-09.

Especialidad: Cirugía

Tema: Patología Biliar

Subtema: Colecistitis

Dificultad: alta

Caso clínico: Paciente de 46 años con dolor persistente en hipocondrio derecho tras ingesta grasa, náusea, fiebre y signo de Murphy. La biometría muestra leucocitosis y la ecografía identifica litos, engrosamiento de pared y líquido perivesicular, sin una dilatación clara de la vía biliar principal. No existen antecedentes de alergia medicamentosa, pero hay barreras para regresar con rapidez si empeora. Los datos clínicos y ultrasonográficos integran colecistitis aguda litiásica sin evidencia inicial de obstrucción biliar mayor.

Pregunta: ¿Cuál es el estudio inicial de mayor utilidad en este cuadro?

- A. solicitar ultrasonido como estudio inicial cuando el cuadro clínico es compatible*
- B. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- C. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: El ultrasonido integra cálculos, pared vesicular, Murphy sonográfico y cambios perivesiculares, por lo que es la primera herramienta apropiada. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Diagnóstico y Tratamiento de Colecistitis y Colelitiasis en el Primero y Segundo Nivel de Atención. GPC-IMSS-237-09.

Especialidad: Cirugía

Tema: Patología Biliar

Subtema: Colecistitis

Dificultad: alta

Caso clínico: Paciente de 46 años con dolor persistente en hipocondrio derecho tras ingesta grasa, náusea, fiebre y signo de Murphy. La biometría muestra leucocitosis y la ecografía identifica litos, engrosamiento de pared y líquido perivesicular, sin una dilatación clara de la vía biliar principal. No existen antecedentes de alergia medicamentosa, pero hay barreras para regresar con rapidez si empeora. Los datos clínicos y ultrasonográficos integran colecistitis aguda litiásica sin evidencia inicial de obstrucción biliar mayor.

Pregunta: ¿Qué conducta evita manejo incompleto de la enfermedad litiásica?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. vigilar evolución y establecer un plan de resolución definitiva, no solo el alivio transitorio de síntomas*
- C. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: La mejoría sintomática no elimina la fuente litiásica ni previene nuevos episodios; debe planearse resolución definitiva. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Diagnóstico y Tratamiento de Colecistitis y Colelitiasis en el Primero y Segundo Nivel de Atención. GPC-IMSS-237-09.

Especialidad: Cirugía

Tema: Patología Biliar

Subtema: Colecistitis

Dificultad: alta

Caso clínico: Paciente de 46 años con dolor persistente en hipocondrio derecho tras ingesta grasa, náusea, fiebre y signo de Murphy. La biometría muestra leucocitosis y la ecografía identifica litos, engrosamiento de pared y líquido perivesicular, sin una dilatación clara de la vía biliar principal. La revisión de medicamentos identifica una posible exposición reciente que debe considerarse al integrar el riesgo. Los datos clínicos y ultrasonográficos integran colecistitis aguda litiásica sin evidencia inicial de obstrucción biliar mayor.

Pregunta: ¿Cuál es el manejo inicial más congruente?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- C. iniciar analgesia, ayuno, líquidos y antimicrobianos cuando estén indicados, con valoración para colecistectomía temprana*
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: La estabilización incluye analgesia, medidas de soporte y valoración quirúrgica oportuna; el manejo definitivo no debe sustituirse por analgesia aislada. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Diagnóstico y Tratamiento de Colecistitis y Colelitiasis en el Primero y Segundo Nivel de Atención. GPC-IMSS-237-09.

Especialidad: Cirugía

Tema: Patología Biliar

Subtema: Colecistitis

Dificultad: alta

Caso clínico: Paciente de 46 años con dolor persistente en hipocondrio derecho tras ingesta grasa, náusea, fiebre y signo de Murphy. La biometría muestra leucocitosis y la ecografía identifica litos, engrosamiento de pared y líquido perivesicular, sin una dilatación clara de la vía biliar principal. La revisión de medicamentos identifica una posible exposición reciente que debe considerarse al integrar el riesgo. Los datos clínicos y ultrasonográficos integran colecistitis aguda litiásica sin evidencia inicial de obstrucción biliar mayor.

Pregunta: ¿Qué paso evita explorar la vía biliar sin justificación?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- C. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación
- D. evaluar datos clínicos y bioquímicos de coledocolitiasis antes de indicar estudio o intervención de la vía biliar*

Explicación: La probabilidad de coledocolitiasis se estima con clínica, pruebas hepáticas e imagen, para reservar estudios invasivos a quienes los necesitan. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Diagnóstico y Tratamiento de Colecistitis y Colelitiasis en el Primero y Segundo Nivel de Atención. GPC-IMSS-237-09.

Especialidad: Cirugía

Tema: Patología Biliar

Subtema: Colecistitis

Dificultad: alta

Caso clínico: Paciente de 46 años con dolor persistente en hipocondrio derecho tras ingesta grasa, náusea, fiebre y signo de Murphy. La biometría muestra leucocitosis y la ecografía identifica litos, engrosamiento de pared y líquido perivesicular, sin una dilatación clara de la vía biliar principal. La revisión de medicamentos identifica una posible exposición reciente que debe considerarse al integrar el riesgo. Los datos clínicos y ultrasonográficos integran colecistitis aguda litiásica sin evidencia inicial de obstrucción biliar mayor.

Pregunta: ¿Qué variable debe ordenar la estrategia de control del foco?

- A. definir gravedad y comorbilidades antes de decidir abordaje quirúrgico o drenaje*
- B. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- C. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: La gravedad fisiológica y el riesgo quirúrgico determinan si conviene intervención temprana, drenaje o estabilización previa. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Diagnóstico y Tratamiento de Colecistitis y Colelitiasis en el Primero y Segundo Nivel de Atención. GPC-IMSS-237-09.

Especialidad: Cirugía

Tema: Patología Biliar

Subtema: Colecistitis

Dificultad: alta

Caso clínico: Paciente de 46 años con dolor persistente en hipocondrio derecho tras ingesta grasa, náusea, fiebre y signo de Murphy. La biometría muestra leucocitosis y la ecografía identifica litos, engrosamiento de pared y líquido perivesicular, sin una dilatación clara de la vía biliar principal. La revisión de medicamentos identifica una posible exposición reciente que debe considerarse al integrar el riesgo. Los datos clínicos y ultrasonográficos integran colecistitis aguda litiásica sin evidencia inicial de obstrucción biliar mayor.

Pregunta: ¿Cuál es el estudio inicial de mayor utilidad en este cuadro?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. solicitar ultrasonido como estudio inicial cuando el cuadro clínico es compatible*
- C. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: El ultrasonido integra cálculos, pared vesicular, Murphy sonográfico y cambios perivesiculares, por lo que es la primera herramienta apropiada. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Diagnóstico y Tratamiento de Colecistitis y Colelitiasis en el Primero y Segundo Nivel de Atención. GPC-IMSS-237-09.

Especialidad: Cirugía

Tema: Patología Biliar

Subtema: Colecistitis

Dificultad: alta

Caso clínico: Paciente de 46 años con dolor persistente en hipocondrio derecho tras ingesta grasa, náusea, fiebre y signo de Murphy. La biometría muestra leucocitosis y la ecografía identifica litos, engrosamiento de pared y líquido perivesicular, sin una dilatación clara de la vía biliar principal. La revisión de medicamentos identifica una posible exposición reciente que debe considerarse al integrar el riesgo. Los datos clínicos y ultrasonográficos integran colecistitis aguda litiásica sin evidencia inicial de obstrucción biliar mayor.

Pregunta: ¿Qué conducta evita manejo incompleto de la enfermedad litiásica?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- C. vigilar evolución y establecer un plan de resolución definitiva, no solo el alivio transitorio de síntomas*
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: La mejoría sintomática no elimina la fuente litiásica ni previene nuevos episodios; debe planearse resolución definitiva. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Diagnóstico y Tratamiento de Colecistitis y Colelitiasis en el Primero y Segundo Nivel de Atención. GPC-IMSS-237-09.

Especialidad: Cirugía

Tema: Patología Biliar

Subtema: Colecistitis

Dificultad: alta

Caso clínico: Paciente de 46 años con dolor persistente en hipocondrio derecho tras ingesta grasa, náusea, fiebre y signo de Murphy. La biometría muestra leucocitosis y la ecografía identifica litos, engrosamiento de pared y líquido perivesicular, sin una dilatación clara de la vía biliar principal. Los signos vitales se repiten después de una primera medida de soporte y muestran la misma tendencia clínica. Los datos clínicos y ultrasonográficos integran colecistitis aguda litiásica sin evidencia inicial de obstrucción biliar mayor.

Pregunta: ¿Cuál es el manejo inicial más congruente?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- C. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación
- D. iniciar analgesia, ayuno, líquidos y antimicrobianos cuando estén indicados, con valoración para colecistectomía temprana*

Explicación: La estabilización incluye analgesia, medidas de soporte y valoración quirúrgica oportuna; el manejo definitivo no debe sustituirse por analgesia aislada. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Diagnóstico y Tratamiento de Colecistitis y Colelitiasis en el Primero y Segundo Nivel de Atención. GPC-IMSS-237-09.

Especialidad: Cirugía

Tema: Patología Biliar

Subtema: Colecistitis

Dificultad: alta

Caso clínico: Paciente de 46 años con dolor persistente en hipocondrio derecho tras ingesta grasa, náusea, fiebre y signo de Murphy. La biometría muestra leucocitosis y la ecografía identifica litos, engrosamiento de pared y líquido perivesicular, sin una dilatación clara de la vía biliar principal. Los signos vitales se repiten después de una primera medida de soporte y muestran la misma tendencia clínica. Los datos clínicos y ultrasonográficos integran colecistitis aguda litiásica sin evidencia inicial de obstrucción biliar mayor.

Pregunta: ¿Qué paso evita explorar la vía biliar sin justificación?

- A. evaluar datos clínicos y bioquímicos de coledocolitiasis antes de indicar estudio o intervención de la vía biliar*
- B. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- C. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: La probabilidad de coledocolitiasis se estima con clínica, pruebas hepáticas e imagen, para reservar estudios invasivos a quienes los necesitan. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Diagnóstico y Tratamiento de Colecistitis y Colelitiasis en el Primero y Segundo Nivel de Atención. GPC-IMSS-237-09.

Especialidad: Cirugía

Tema: Patología Biliar

Subtema: Colecistitis

Dificultad: alta

Caso clínico: Paciente de 46 años con dolor persistente en hipocondrio derecho tras ingesta grasa, náusea, fiebre y signo de Murphy. La biometría muestra leucocitosis y la ecografía identifica litos, engrosamiento de pared y líquido perivesicular, sin una dilatación clara de la vía biliar principal. Los signos vitales se repiten después de una primera medida de soporte y muestran la misma tendencia clínica. Los datos clínicos y ultrasonográficos integran colecistitis aguda litiásica sin evidencia inicial de obstrucción biliar mayor.

Pregunta: ¿Qué variable debe ordenar la estrategia de control del foco?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. definir gravedad y comorbilidades antes de decidir abordaje quirúrgico o drenaje*
- C. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: La gravedad fisiológica y el riesgo quirúrgico determinan si conviene intervención temprana, drenaje o estabilización previa. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Diagnóstico y Tratamiento de Colecistitis y Colelitiasis en el Primero y Segundo Nivel de Atención. GPC-IMSS-237-09.

Especialidad: Cirugía

Tema: Patología Biliar

Subtema: Colecistitis

Dificultad: alta

Caso clínico: Paciente de 46 años con dolor persistente en hipocondrio derecho tras ingesta grasa, náusea, fiebre y signo de Murphy. La biometría muestra leucocitosis y la ecografía identifica litos, engrosamiento de pared y líquido perivesicular, sin una dilatación clara de la vía biliar principal. Los signos vitales se repiten después de una primera medida de soporte y muestran la misma tendencia clínica. Los datos clínicos y ultrasonográficos integran colecistitis aguda litiásica sin evidencia inicial de obstrucción biliar mayor.

Pregunta: ¿Cuál es el estudio inicial de mayor utilidad en este cuadro?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- C. solicitar ultrasonido como estudio inicial cuando el cuadro clínico es compatible*
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: El ultrasonido integra cálculos, pared vesicular, Murphy sonográfico y cambios perivesiculares, por lo que es la primera herramienta apropiada. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Diagnóstico y Tratamiento de Colecistitis y Colelitiasis en el Primero y Segundo Nivel de Atención. GPC-IMSS-237-09.

Especialidad: Cirugía

Tema: Patología Biliar

Subtema: Colecistitis

Dificultad: alta

Caso clínico: Paciente de 46 años con dolor persistente en hipocondrio derecho tras ingesta grasa, náusea, fiebre y signo de Murphy. La biometría muestra leucocitosis y la ecografía identifica litos, engrosamiento de pared y líquido perivesicular, sin una dilatación clara de la vía biliar principal. Los signos vitales se repiten después de una primera medida de soporte y muestran la misma tendencia clínica. Los datos clínicos y ultrasonográficos integran colecistitis aguda litiásica sin evidencia inicial de obstrucción biliar mayor.

Pregunta: ¿Qué conducta evita manejo incompleto de la enfermedad litiásica?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- C. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación
- D. vigilar evolución y establecer un plan de resolución definitiva, no solo el alivio transitorio de síntomas*

Explicación: La mejoría sintomática no elimina la fuente litiásica ni previene nuevos episodios; debe planearse resolución definitiva. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Diagnóstico y Tratamiento de Colecistitis y Colelitiasis en el Primero y Segundo Nivel de Atención. GPC-IMSS-237-09.

Especialidad: Cirugía

Tema: Patología Biliar

Subtema: Colelitiasis

Dificultad: alta

Caso clínico: Paciente de 39 años con cólico biliar recurrente, desencadenado por alimentos grasos, sin fiebre ni ictericia. Entre episodios permanece asintomática. El ultrasonido muestra múltiples cálculos vesiculares sin engrosamiento, líquido perivesicular ni dilatación de la vía biliar. La evolución se ha modificado durante las últimas 12 horas y los familiares pueden aportar una cronología fiable. La información es consistente con colelitiasis sintomática sin datos de colecistitis ni de coledocolitiasis.

Pregunta: ¿Cuál es la conducta definitiva más adecuada?

- A. explicar el carácter sintomático de la enfermedad y ofrecer resolución quirúrgica electiva tras valorar riesgos*
- B. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- C. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: El cólico biliar recurrente indica enfermedad sintomática; la colecistectomía electiva previene nuevos episodios y complicaciones. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Diagnóstico y Tratamiento de Colecistitis y Colelitiasis en el Primero y Segundo Nivel de Atención. GPC-IMSS-237-09.

Especialidad: Cirugía

Tema: Patología Biliar

Subtema: Colelitiasis

Dificultad: alta

Caso clínico: Paciente de 39 años con cólico biliar recurrente, desencadenado por alimentos grasos, sin fiebre ni ictericia. Entre episodios permanece asintomática. El ultrasonido muestra múltiples cálculos vesiculares sin engrosamiento, líquido perivesicular ni dilatación de la vía biliar. La evolución se ha modificado durante las últimas 12 horas y los familiares pueden aportar una cronología fiable. La información es consistente con colelitiasis sintomática sin datos de colecistitis ni de coledocolitiasis.

Pregunta: ¿Qué dato orienta a una complicación inflamatoria y modifica el manejo?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. distinguir cólico biliar de colecistitis mediante duración del dolor, fiebre, exploración y ultrasonido*
- C. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: Dolor prolongado con fiebre, Murphy y cambios inflamatorios cambia la sospecha hacia colecistitis aguda. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Diagnóstico y Tratamiento de Colecistitis y Colelitiasis en el Primero y Segundo Nivel de Atención. GPC-IMSS-237-09.

Especialidad: Cirugía

Tema: Patología Biliar

Subtema: Colelitiasis

Dificultad: alta

Caso clínico: Paciente de 39 años con cólico biliar recurrente, desencadenado por alimentos grasos, sin fiebre ni ictericia. Entre episodios permanece asintomática. El ultrasonido muestra múltiples cálculos vesiculares sin engrosamiento, líquido perivesicular ni dilatación de la vía biliar. La evolución se ha modificado durante las últimas 12 horas y los familiares pueden aportar una cronología fiable. La información es consistente con colelitiasis sintomática sin datos de colecistitis ni de coledocolitiasis.

Pregunta: ¿Qué intervención debe evitarse en este momento?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- C. no indicar antibiótico si no hay evidencia clínica de infección biliar*
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: Sin evidencia de infección, antibióticos no sustituyen el tratamiento definitivo ni aportan beneficio. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Diagnóstico y Tratamiento de Colecistitis y Colelitiasis en el Primero y Segundo Nivel de Atención. GPC-IMSS-237-09.

Especialidad: Cirugía

Tema: Patología Biliar

Subtema: Colelitiasis

Dificultad: alta

Caso clínico: Paciente de 39 años con cólico biliar recurrente, desencadenado por alimentos grasos, sin fiebre ni ictericia. Entre episodios permanece asintomática. El ultrasonido muestra múltiples cálculos vesiculares sin engrosamiento, líquido perivesicular ni dilatación de la vía biliar. La evolución se ha modificado durante las últimas 12 horas y los familiares pueden aportar una cronología fiable. La información es consistente con colelitiasis sintomática sin datos de colecistitis ni de coledocolitiasis.

Pregunta: ¿Qué evaluación identifica una posible coledocolitiasis?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- C. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación
- D. revisar ictericia, coluria, pruebas hepáticas y diámetro de vía biliar antes de buscar cálculos ductales*

Explicación: La evaluación clínica, hepática y ecográfica estratifica la probabilidad de un cálculo en vía biliar principal. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Diagnóstico y Tratamiento de Colecistitis y Colelitiasis en el Primero y Segundo Nivel de Atención. GPC-IMSS-237-09.

Especialidad: Cirugía

Tema: Patología Biliar

Subtema: Colelitiasis

Dificultad: alta

Caso clínico: Paciente de 39 años con cólico biliar recurrente, desencadenado por alimentos grasos, sin fiebre ni ictericia. Entre episodios permanece asintomática. El ultrasonido muestra múltiples cálculos vesiculares sin engrosamiento, líquido perivesicular ni dilatación de la vía biliar. La evolución se ha modificado durante las últimas 12 horas y los familiares pueden aportar una cronología fiable. La información es consistente con colelitiasis sintomática sin datos de colecistitis ni de coledocolitiasis.

Pregunta: ¿Qué recomendación de seguridad es esencial en el seguimiento?

- A. indicar medidas de alarma y seguimiento si cambia el patrón del dolor*
- B. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- C. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: Fiebre, ictericia, dolor persistente o intolerancia oral deben motivar reevaluación urgente por posible complicación. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Diagnóstico y Tratamiento de Colecistitis y Colelitiasis en el Primero y Segundo Nivel de Atención. GPC-IMSS-237-09.

Especialidad: Cirugía

Tema: Patología Biliar

Subtema: Colelitiasis

Dificultad: alta

Caso clínico: Paciente de 39 años con cólico biliar recurrente, desencadenado por alimentos grasos, sin fiebre ni ictericia. Entre episodios permanece asintomática. El ultrasonido muestra múltiples cálculos vesiculares sin engrosamiento, líquido perivesicular ni dilatación de la vía biliar. No existen antecedentes de alergia medicamentosa, pero hay barreras para regresar con rapidez si empeora. La información es consistente con colelitiasis sintomática sin datos de colecistitis ni de coledocolitiasis.

Pregunta: ¿Cuál es la conducta definitiva más adecuada?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. explicar el carácter sintomático de la enfermedad y ofrecer resolución quirúrgica electiva tras valorar riesgos*
- C. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: El cólico biliar recurrente indica enfermedad sintomática; la colecistectomía electiva previene nuevos episodios y complicaciones. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Diagnóstico y Tratamiento de Colecistitis y Colelitiasis en el Primero y Segundo Nivel de Atención. GPC-IMSS-237-09.

Especialidad: Cirugía

Tema: Patología Biliar

Subtema: Colelitiasis

Dificultad: alta

Caso clínico: Paciente de 39 años con cólico biliar recurrente, desencadenado por alimentos grasos, sin fiebre ni ictericia. Entre episodios permanece asintomática. El ultrasonido muestra múltiples cálculos vesiculares sin engrosamiento, líquido perivesicular ni dilatación de la vía biliar. No existen antecedentes de alergia medicamentosa, pero hay barreras para regresar con rapidez si empeora. La información es consistente con colelitiasis sintomática sin datos de colecistitis ni de coledocolitiasis.

Pregunta: ¿Qué dato orienta a una complicación inflamatoria y modifica el manejo?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- C. distinguir cólico biliar de colecistitis mediante duración del dolor, fiebre, exploración y ultrasonido*
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: Dolor prolongado con fiebre, Murphy y cambios inflamatorios cambia la sospecha hacia colecistitis aguda. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Diagnóstico y Tratamiento de Colecistitis y Colelitiasis en el Primero y Segundo Nivel de Atención. GPC-IMSS-237-09.

Especialidad: Cirugía

Tema: Patología Biliar

Subtema: Colelitiasis

Dificultad: alta

Caso clínico: Paciente de 39 años con cólico biliar recurrente, desencadenado por alimentos grasos, sin fiebre ni ictericia. Entre episodios permanece asintomática. El ultrasonido muestra múltiples cálculos vesiculares sin engrosamiento, líquido perivesicular ni dilatación de la vía biliar. No existen antecedentes de alergia medicamentosa, pero hay barreras para regresar con rapidez si empeora. La información es consistente con colelitiasis sintomática sin datos de colecistitis ni de coledocolitiasis.

Pregunta: ¿Qué intervención debe evitarse en este momento?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- C. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación
- D. no indicar antibiótico si no hay evidencia clínica de infección biliar*

Explicación: Sin evidencia de infección, antibióticos no sustituyen el tratamiento definitivo ni aportan beneficio. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Diagnóstico y Tratamiento de Colecistitis y Colelitiasis en el Primero y Segundo Nivel de Atención. GPC-IMSS-237-09.

Especialidad: Cirugía

Tema: Patología Biliar

Subtema: Colelitiasis

Dificultad: alta

Caso clínico: Paciente de 39 años con cólico biliar recurrente, desencadenado por alimentos grasos, sin fiebre ni ictericia. Entre episodios permanece asintomática. El ultrasonido muestra múltiples cálculos vesiculares sin engrosamiento, líquido perivesicular ni dilatación de la vía biliar. No existen antecedentes de alergia medicamentosa, pero hay barreras para regresar con rapidez si empeora. La información es consistente con colelitiasis sintomática sin datos de colecistitis ni de coledocolitiasis.

Pregunta: ¿Qué evaluación identifica una posible coledocolitiasis?

- A. revisar ictericia, coluria, pruebas hepáticas y diámetro de vía biliar antes de buscar cálculos ductales*
- B. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- C. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: La evaluación clínica, hepática y ecográfica estratifica la probabilidad de un cálculo en vía biliar principal. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Diagnóstico y Tratamiento de Colecistitis y Colelitiasis en el Primero y Segundo Nivel de Atención. GPC-IMSS-237-09.

Especialidad: Cirugía

Tema: Patología Biliar

Subtema: Colelitiasis

Dificultad: alta

Caso clínico: Paciente de 39 años con cólico biliar recurrente, desencadenado por alimentos grasos, sin fiebre ni ictericia. Entre episodios permanece asintomática. El ultrasonido muestra múltiples cálculos vesiculares sin engrosamiento, líquido perivesicular ni dilatación de la vía biliar. No existen antecedentes de alergia medicamentosa, pero hay barreras para regresar con rapidez si empeora. La información es consistente con colelitiasis sintomática sin datos de colecistitis ni de coledocolitiasis.

Pregunta: ¿Qué recomendación de seguridad es esencial en el seguimiento?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. indicar medidas de alarma y seguimiento si cambia el patrón del dolor*
- C. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: Fiebre, ictericia, dolor persistente o intolerancia oral deben motivar reevaluación urgente por posible complicación. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Diagnóstico y Tratamiento de Colecistitis y Colelitiasis en el Primero y Segundo Nivel de Atención. GPC-IMSS-237-09.

Especialidad: Cirugía

Tema: Patología Pancreática

Subtema: Pancreatitis Aguda

Dificultad: alta

Caso clínico: Paciente de 52 años con dolor epigástrico intenso irradiado a espalda, náusea y vómito. Tiene lipasa elevada más de tres veces el límite superior y ultrasonido con litiasis vesicular. Al ingreso presenta hemoconcentración leve, sin hipotensión sostenida, ictericia ni datos de colangitis. La evolución se ha modificado durante las últimas 12 horas y los familiares pueden aportar una cronología fiable. La combinación clínica, bioquímica e imagenológica sustenta pancreatitis aguda de probable etiología biliar.

Pregunta: ¿Cuál es la intervención inicial más apropiada?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- C. iniciar reanimación con cristaloides, analgesia, vigilancia clínica estrecha y alimentación enteral temprana cuando sea tolerada*
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: El soporte inicial se centra en líquidos, analgesia, vigilancia y nutrición enteral tan pronto sea posible; son medidas que modifican evolución. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Diagnóstico y Tratamiento de Pancreatitis Aguda. GPC-IMSS-239-09.

Especialidad: Cirugía

Tema: Patología Pancreática

Subtema: Pancreatitis Aguda

Dificultad: alta

Caso clínico: Paciente de 52 años con dolor epigástrico intenso irradiado a espalda, náusea y vómito. Tiene lipasa elevada más de tres veces el límite superior y ultrasonido con litiasis vesicular. Al ingreso presenta hemoconcentración leve, sin hipotensión sostenida, ictericia ni datos de colangitis. La evolución se ha modificado durante las últimas 12 horas y los familiares pueden aportar una cronología fiable. La combinación clínica, bioquímica e imagenológica sustenta pancreatitis aguda de probable etiología biliar.

Pregunta: ¿Qué evaluación permite ajustar la intensidad de vigilancia?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- C. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación
- D. estratificar gravedad con datos de falla orgánica, respuesta a reanimación y evolución durante las primeras horas*

Explicación: La gravedad no se define por una sola enzima; falla orgánica y respuesta temprana guían la necesidad de cuidados críticos. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Diagnóstico y Tratamiento de Pancreatitis Aguda. GPC-IMSS-239-09.

Especialidad: Cirugía

Tema: Patología Pancreática

Subtema: Pancreatitis Aguda

Dificultad: alta

Caso clínico: Paciente de 52 años con dolor epigástrico intenso irradiado a espalda, náusea y vómito. Tiene lipasa elevada más de tres veces el límite superior y ultrasonido con litiasis vesicular. Al ingreso presenta hemoconcentración leve, sin hipotensión sostenida, ictericia ni datos de colangitis. La evolución se ha modificado durante las últimas 12 horas y los familiares pueden aportar una cronología fiable. La combinación clínica, bioquímica e imagenológica sustenta pancreatitis aguda de probable etiología biliar.

Pregunta: ¿Qué condición justificaría una intervención biliar urgente?

- A. buscar obstrucción biliar persistente o colangitis antes de indicar una intervención endoscópica urgente*
- B. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- C. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: La obstrucción persistente acompañada de colangitis requiere descompresión biliar; la endoscopia urgente no es rutinaria en todos los casos. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Diagnóstico y Tratamiento de Pancreatitis Aguda. GPC-IMSS-239-09.

Especialidad: Cirugía

Tema: Patología Pancreática

Subtema: Pancreatitis Aguda

Dificultad: alta

Caso clínico: Paciente de 52 años con dolor epigástrico intenso irradiado a espalda, náusea y vómito. Tiene lipasa elevada más de tres veces el límite superior y ultrasonido con litiasis vesicular. Al ingreso presenta hemoconcentración leve, sin hipotensión sostenida, ictericia ni datos de colangitis. La evolución se ha modificado durante las últimas 12 horas y los familiares pueden aportar una cronología fiable. La combinación clínica, bioquímica e imagenológica sustenta pancreatitis aguda de probable etiología biliar.

Pregunta: ¿Qué conducta antimicrobiana es correcta?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. no usar antibióticos profilácticos en pancreatitis intersticial sin infección documentada*
- C. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: Los antibióticos profilácticos no previenen de forma consistente infección pancreática y exponen a efectos adversos y resistencia. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Diagnóstico y Tratamiento de Pancreatitis Aguda. GPC-IMSS-239-09.

Especialidad: Cirugía

Tema: Patología Pancreática

Subtema: Pancreatitis Aguda

Dificultad: alta

Caso clínico: Paciente de 52 años con dolor epigástrico intenso irradiado a espalda, náusea y vómito. Tiene lipasa elevada más de tres veces el límite superior y ultrasonido con litiasis vesicular. Al ingreso presenta hemoconcentración leve, sin hipotensión sostenida, ictericia ni datos de colangitis. La evolución se ha modificado durante las últimas 12 horas y los familiares pueden aportar una cronología fiable. La combinación clínica, bioquímica e imagenológica sustenta pancreatitis aguda de probable etiología biliar.

Pregunta: ¿Qué medida previene recurrencia en pancreatitis biliar leve?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- C. planear colecistectomía durante el mismo ingreso si se confirma enfermedad biliar leve y se resuelve el episodio*
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: En pancreatitis biliar leve, resolver la fuente litiasica durante el ingreso reduce recurrencias. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Diagnóstico y Tratamiento de Pancreatitis Aguda. GPC-IMSS-239-09.

Especialidad: Cirugía

Tema: Patología Pancreática

Subtema: Pancreatitis Aguda

Dificultad: alta

Caso clínico: Paciente de 52 años con dolor epigástrico intenso irradiado a espalda, náusea y vómito. Tiene lipasa elevada más de tres veces el límite superior y ultrasonido con litiasis vesicular. Al ingreso presenta hemoconcentración leve, sin hipotensión sostenida, ictericia ni datos de colangitis. No existen antecedentes de alergia medicamentosa, pero hay barreras para regresar con rapidez si empeora. La combinación clínica, bioquímica e imagenológica sustenta pancreatitis aguda de probable etiología biliar.

Pregunta: ¿Cuál es la intervención inicial más apropiada?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- C. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación
- D. iniciar reanimación con cristaloides, analgesia, vigilancia clínica estrecha y alimentación enteral temprana cuando sea tolerada*

Explicación: El soporte inicial se centra en líquidos, analgesia, vigilancia y nutrición enteral tan pronto sea posible; son medidas que modifican evolución. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Diagnóstico y Tratamiento de Pancreatitis Aguda. GPC-IMSS-239-09.

Especialidad: Cirugía

Tema: Patología Pancreática

Subtema: Pancreatitis Aguda

Dificultad: alta

Caso clínico: Paciente de 52 años con dolor epigástrico intenso irradiado a espalda, náusea y vómito. Tiene lipasa elevada más de tres veces el límite superior y ultrasonido con litiasis vesicular. Al ingreso presenta hemoconcentración leve, sin hipotensión sostenida, ictericia ni datos de colangitis. No existen antecedentes de alergia medicamentosa, pero hay barreras para regresar con rapidez si empeora. La combinación clínica, bioquímica e imagenológica sustenta pancreatitis aguda de probable etiología biliar.

Pregunta: ¿Qué evaluación permite ajustar la intensidad de vigilancia?

- A. estratificar gravedad con datos de falla orgánica, respuesta a reanimación y evolución durante las primeras horas*
- B. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- C. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: La gravedad no se define por una sola enzima; falla orgánica y respuesta temprana guían la necesidad de cuidados críticos. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Diagnóstico y Tratamiento de Pancreatitis Aguda. GPC-IMSS-239-09.

Especialidad: Cirugía

Tema: Patología Pancreática

Subtema: Pancreatitis Aguda

Dificultad: alta

Caso clínico: Paciente de 52 años con dolor epigástrico intenso irradiado a espalda, náusea y vómito. Tiene lipasa elevada más de tres veces el límite superior y ultrasonido con litiasis vesicular. Al ingreso presenta hemoconcentración leve, sin hipotensión sostenida, ictericia ni datos de colangitis. No existen antecedentes de alergia medicamentosa, pero hay barreras para regresar con rapidez si empeora. La combinación clínica, bioquímica e imagenológica sustenta pancreatitis aguda de probable etiología biliar.

Pregunta: ¿Qué condición justificaría una intervención biliar urgente?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. buscar obstrucción biliar persistente o colangitis antes de indicar una intervención endoscópica urgente*
- C. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: La obstrucción persistente acompañada de colangitis requiere descompresión biliar; la endoscopia urgente no es rutinaria en todos los casos. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Diagnóstico y Tratamiento de Pancreatitis Aguda. GPC-IMSS-239-09.

Especialidad: Cirugía

Tema: Patología Pancreática

Subtema: Pancreatitis Aguda

Dificultad: alta

Caso clínico: Paciente de 52 años con dolor epigástrico intenso irradiado a espalda, náusea y vómito. Tiene lipasa elevada más de tres veces el límite superior y ultrasonido con litiasis vesicular. Al ingreso presenta hemoconcentración leve, sin hipotensión sostenida, ictericia ni datos de colangitis. No existen antecedentes de alergia medicamentosa, pero hay barreras para regresar con rapidez si empeora. La combinación clínica, bioquímica e imagenológica sustenta pancreatitis aguda de probable etiología biliar.

Pregunta: ¿Qué conducta antimicrobiana es correcta?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- C. no usar antibióticos profilácticos en pancreatitis intersticial sin infección documentada*
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: Los antibióticos profilácticos no previenen de forma consistente infección pancreática y exponen a efectos adversos y resistencia. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Diagnóstico y Tratamiento de Pancreatitis Aguda. GPC-IMSS-239-09.

Especialidad: Cirugía

Tema: Patología Pancreática

Subtema: Pancreatitis Aguda

Dificultad: alta

Caso clínico: Paciente de 52 años con dolor epigástrico intenso irradiado a espalda, náusea y vómito. Tiene lipasa elevada más de tres veces el límite superior y ultrasonido con litiasis vesicular. Al ingreso presenta hemoconcentración leve, sin hipotensión sostenida, ictericia ni datos de colangitis. No existen antecedentes de alergia medicamentosa, pero hay barreras para regresar con rapidez si empeora. La combinación clínica, bioquímica e imagenológica sustenta pancreatitis aguda de probable etiología biliar.

Pregunta: ¿Qué medida previene recurrencia en pancreatitis biliar leve?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- C. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación
- D. planear colecistectomía durante el mismo ingreso si se confirma enfermedad biliar leve y se resuelve el episodio*

Explicación: En pancreatitis biliar leve, resolver la fuente litiasica durante el ingreso reduce recurrencias. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Diagnóstico y Tratamiento de Pancreatitis Aguda. GPC-IMSS-239-09.

Especialidad: Cirugía

Tema: Patología Pancreática

Subtema: Pancreatitis Aguda

Dificultad: alta

Caso clínico: Paciente de 52 años con dolor epigástrico intenso irradiado a espalda, náusea y vómito. Tiene lipasa elevada más de tres veces el límite superior y ultrasonido con litiasis vesicular. Al ingreso presenta hemoconcentración leve, sin hipotensión sostenida, ictericia ni datos de colangitis. La revisión de medicamentos identifica una posible exposición reciente que debe considerarse al integrar el riesgo. La combinación clínica, bioquímica e imagenológica sustenta pancreatitis aguda de probable etiología biliar.

Pregunta: ¿Cuál es la intervención inicial más apropiada?

- A. iniciar reanimación con cristaloides, analgesia, vigilancia clínica estrecha y alimentación enteral temprana cuando sea tolerada*
- B. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- C. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: El soporte inicial se centra en líquidos, analgesia, vigilancia y nutrición enteral tan pronto sea posible; son medidas que modifican evolución. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Diagnóstico y Tratamiento de Pancreatitis Aguda. GPC-IMSS-239-09.

Especialidad: Cirugía

Tema: Patología Pancreática

Subtema: Pancreatitis Aguda

Dificultad: alta

Caso clínico: Paciente de 52 años con dolor epigástrico intenso irradiado a espalda, náusea y vómito. Tiene lipasa elevada más de tres veces el límite superior y ultrasonido con litiasis vesicular. Al ingreso presenta hemoconcentración leve, sin hipotensión sostenida, ictericia ni datos de colangitis. La revisión de medicamentos identifica una posible exposición reciente que debe considerarse al integrar el riesgo. La combinación clínica, bioquímica e imagenológica sustenta pancreatitis aguda de probable etiología biliar.

Pregunta: ¿Qué evaluación permite ajustar la intensidad de vigilancia?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. estratificar gravedad con datos de falla orgánica, respuesta a reanimación y evolución durante las primeras horas*
- C. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: La gravedad no se define por una sola enzima; falla orgánica y respuesta temprana guían la necesidad de cuidados críticos. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Diagnóstico y Tratamiento de Pancreatitis Aguda. GPC-IMSS-239-09.

Especialidad: Cirugía

Tema: Patología Pancreática

Subtema: Pancreatitis Aguda

Dificultad: alta

Caso clínico: Paciente de 52 años con dolor epigástrico intenso irradiado a espalda, náusea y vómito. Tiene lipasa elevada más de tres veces el límite superior y ultrasonido con litiasis vesicular. Al ingreso presenta hemoconcentración leve, sin hipotensión sostenida, ictericia ni datos de colangitis. La revisión de medicamentos identifica una posible exposición reciente que debe considerarse al integrar el riesgo. La combinación clínica, bioquímica e imagenológica sustenta pancreatitis aguda de probable etiología biliar.

Pregunta: ¿Qué condición justificaría una intervención biliar urgente?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- C. buscar obstrucción biliar persistente o colangitis antes de indicar una intervención endoscópica urgente*
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: La obstrucción persistente acompañada de colangitis requiere descompresión biliar; la endoscopia urgente no es rutinaria en todos los casos. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Diagnóstico y Tratamiento de Pancreatitis Aguda. GPC-IMSS-239-09.

Especialidad: Cirugía

Tema: Patología Pancreática

Subtema: Pancreatitis Aguda

Dificultad: alta

Caso clínico: Paciente de 52 años con dolor epigástrico intenso irradiado a espalda, náusea y vómito. Tiene lipasa elevada más de tres veces el límite superior y ultrasonido con litiasis vesicular. Al ingreso presenta hemoconcentración leve, sin hipotensión sostenida, ictericia ni datos de colangitis. La revisión de medicamentos identifica una posible exposición reciente que debe considerarse al integrar el riesgo. La combinación clínica, bioquímica e imagenológica sustenta pancreatitis aguda de probable etiología biliar.

Pregunta: ¿Qué conducta antimicrobiana es correcta?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- C. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación
- D. no usar antibióticos profilácticos en pancreatitis intersticial sin infección documentada*

Explicación: Los antibióticos profilácticos no previenen de forma consistente infección pancreática y exponen a efectos adversos y resistencia. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Diagnóstico y Tratamiento de Pancreatitis Aguda. GPC-IMSS-239-09.

Especialidad: Cirugía

Tema: Patología Pancreática

Subtema: Pancreatitis Aguda

Dificultad: alta

Caso clínico: Paciente de 52 años con dolor epigástrico intenso irradiado a espalda, náusea y vómito. Tiene lipasa elevada más de tres veces el límite superior y ultrasonido con litiasis vesicular. Al ingreso presenta hemoconcentración leve, sin hipotensión sostenida, ictericia ni datos de colangitis. La revisión de medicamentos identifica una posible exposición reciente que debe considerarse al integrar el riesgo. La combinación clínica, bioquímica e imagenológica sustenta pancreatitis aguda de probable etiología biliar.

Pregunta: ¿Qué medida previene recurrencia en pancreatitis biliar leve?

- A. planear colecistectomía durante el mismo ingreso si se confirma enfermedad biliar leve y se resuelve el episodio*
- B. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- C. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: En pancreatitis biliar leve, resolver la fuente litiasica durante el ingreso reduce recurrencias. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Diagnóstico y Tratamiento de Pancreatitis Aguda. GPC-IMSS-239-09.

Especialidad: Cirugía

Tema: Patología Pancreática

Subtema: Pancreatitis Aguda

Dificultad: alta

Caso clínico: Paciente de 52 años con dolor epigástrico intenso irradiado a espalda, náusea y vómito. Tiene lipasa elevada más de tres veces el límite superior y ultrasonido con litiasis vesicular. Al ingreso presenta hemoconcentración leve, sin hipotensión sostenida, ictericia ni datos de colangitis. Los signos vitales se repiten después de una primera medida de soporte y muestran la misma tendencia clínica. La combinación clínica, bioquímica e imagenológica sustenta pancreatitis aguda de probable etiología biliar.

Pregunta: ¿Cuál es la intervención inicial más apropiada?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. iniciar reanimación con cristaloides, analgesia, vigilancia clínica estrecha y alimentación enteral temprana cuando sea tolerada*
- C. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: El soporte inicial se centra en líquidos, analgesia, vigilancia y nutrición enteral tan pronto sea posible; son medidas que modifican evolución. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Diagnóstico y Tratamiento de Pancreatitis Aguda. GPC-IMSS-239-09.

Especialidad: Cirugía

Tema: Patología Pancreática

Subtema: Pancreatitis Aguda

Dificultad: alta

Caso clínico: Paciente de 52 años con dolor epigástrico intenso irradiado a espalda, náusea y vómito. Tiene lipasa elevada más de tres veces el límite superior y ultrasonido con litiasis vesicular. Al ingreso presenta hemoconcentración leve, sin hipotensión sostenida, ictericia ni datos de colangitis. Los signos vitales se repiten después de una primera medida de soporte y muestran la misma tendencia clínica. La combinación clínica, bioquímica e imagenológica sustenta pancreatitis aguda de probable etiología biliar.

Pregunta: ¿Qué evaluación permite ajustar la intensidad de vigilancia?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- C. estratificar gravedad con datos de falla orgánica, respuesta a reanimación y evolución durante las primeras horas*
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: La gravedad no se define por una sola enzima; falla orgánica y respuesta temprana guían la necesidad de cuidados críticos. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Diagnóstico y Tratamiento de Pancreatitis Aguda. GPC-IMSS-239-09.

Especialidad: Cirugía

Tema: Patología Pancreática

Subtema: Pancreatitis Aguda

Dificultad: alta

Caso clínico: Paciente de 52 años con dolor epigástrico intenso irradiado a espalda, náusea y vómito. Tiene lipasa elevada más de tres veces el límite superior y ultrasonido con litiasis vesicular. Al ingreso presenta hemoconcentración leve, sin hipotensión sostenida, ictericia ni datos de colangitis. Los signos vitales se repiten después de una primera medida de soporte y muestran la misma tendencia clínica. La combinación clínica, bioquímica e imagenológica sustenta pancreatitis aguda de probable etiología biliar.

Pregunta: ¿Qué condición justificaría una intervención biliar urgente?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- C. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación
- D. buscar obstrucción biliar persistente o colangitis antes de indicar una intervención endoscópica urgente*

Explicación: La obstrucción persistente acompañada de colangitis requiere descompresión biliar; la endoscopia urgente no es rutinaria en todos los casos. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Diagnóstico y Tratamiento de Pancreatitis Aguda. GPC-IMSS-239-09.

Especialidad: Cirugía

Tema: Patología Pancreática

Subtema: Pancreatitis Aguda

Dificultad: alta

Caso clínico: Paciente de 52 años con dolor epigástrico intenso irradiado a espalda, náusea y vómito. Tiene lipasa elevada más de tres veces el límite superior y ultrasonido con litiasis vesicular. Al ingreso presenta hemoconcentración leve, sin hipotensión sostenida, ictericia ni datos de colangitis. Los signos vitales se repiten después de una primera medida de soporte y muestran la misma tendencia clínica. La combinación clínica, bioquímica e imagenológica sustenta pancreatitis aguda de probable etiología biliar.

Pregunta: ¿Qué conducta antimicrobiana es correcta?

- A. no usar antibióticos profilácticos en pancreatitis intersticial sin infección documentada*
- B. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- C. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: Los antibióticos profilácticos no previenen de forma consistente infección pancreática y exponen a efectos adversos y resistencia. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Diagnóstico y Tratamiento de Pancreatitis Aguda. GPC-IMSS-239-09.

Especialidad: Cirugía

Tema: Patología Pancreática

Subtema: Pancreatitis Aguda

Dificultad: alta

Caso clínico: Paciente de 52 años con dolor epigástrico intenso irradiado a espalda, náusea y vómito. Tiene lipasa elevada más de tres veces el límite superior y ultrasonido con litiasis vesicular. Al ingreso presenta hemoconcentración leve, sin hipotensión sostenida, ictericia ni datos de colangitis. Los signos vitales se repiten después de una primera medida de soporte y muestran la misma tendencia clínica. La combinación clínica, bioquímica e imagenológica sustenta pancreatitis aguda de probable etiología biliar.

Pregunta: ¿Qué medida previene recurrencia en pancreatitis biliar leve?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. planear colecistectomía durante el mismo ingreso si se confirma enfermedad biliar leve y se resuelve el episodio*
- C. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: En pancreatitis biliar leve, resolver la fuente litiasica durante el ingreso reduce recurrencias. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Diagnóstico y Tratamiento de Pancreatitis Aguda. GPC-IMSS-239-09.

Especialidad: Pediatría

Tema: Uropedia

Subtema: IVU

Dificultad: alta

Caso clínico: Lactante de 8 meses con fiebre de 39 grados, irritabilidad y rechazo parcial al alimento, sin un foco respiratorio o gastrointestinal claro. El examen general de orina obtenido con técnica adecuada muestra leucocituria y esterasa leucocitaria positiva; se toma muestra para cultivo antes de antimicrobianos. La evolución se ha modificado durante las últimas 12 horas y los familiares pueden aportar una cronología fiable. En un lactante febril, el conjunto de datos obliga a considerar infección de vías urinarias y a confirmar con cultivo apropiado.

Pregunta: ¿Cuál es la acción diagnóstica-terapéutica inicial más sólida?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- C. obtener urocultivo con una muestra confiable antes de la primera dosis, sin retrasar tratamiento si la condición clínica lo exige*
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: El cultivo de una muestra obtenida correctamente documenta el diagnóstico y permite dirigir tratamiento; debe obtenerse antes del antibiótico cuando sea posible. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Secretaría de Salud e Instituto Mexicano del Seguro Social. Abordaje Diagnóstico de Infección de Vías Urinarias No Complicada en Menores de 18 Años. GPC-SS-027-08.

Especialidad: Pediatría

Tema: Uropedia

Subtema: IVU

Dificultad: alta

Caso clínico: Lactante de 8 meses con fiebre de 39 grados, irritabilidad y rechazo parcial al alimento, sin un foco respiratorio o gastrointestinal claro. El examen general de orina obtenido con técnica adecuada muestra leucocituria y esterasa leucocitaria positiva; se toma muestra para cultivo antes de antimicrobianos. La evolución se ha modificado durante las últimas 12 horas y los familiares pueden aportar una cronología fiable. En un lactante febril, el conjunto de datos obliga a considerar infección de vías urinarias y a confirmar con cultivo apropiado.

Pregunta: ¿Qué enfoque define la necesidad de atención de mayor complejidad?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- C. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación
- D. estratificar riesgo de complicación por edad, estado general, respuesta, recurrencia y anomalías conocidas*

Explicación: Edad, estado clínico y anomalías urológicas determinan el riesgo; no todos los niños febriles siguen el mismo trayecto. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Secretaría de Salud e Instituto Mexicano del Seguro Social. Abordaje Diagnóstico de Infección de Vías Urinarias No Complicada en Menores de 18 Años. GPC-SS-027-08.

Especialidad: Pediatría

Tema: Uropedia

Subtema: IVU

Dificultad: alta

Caso clínico: Lactante de 8 meses con fiebre de 39 grados, irritabilidad y rechazo parcial al alimento, sin un foco respiratorio o gastrointestinal claro. El examen general de orina obtenido con técnica adecuada muestra leucocituria y esterasa leucocitaria positiva; se toma muestra para cultivo antes de antimicrobianos. La evolución se ha modificado durante las últimas 12 horas y los familiares pueden aportar una cronología fiable. En un lactante febril, el conjunto de datos obliga a considerar infección de vías urinarias y a confirmar con cultivo apropiado.

Pregunta: ¿En qué situación es más apropiado escalar el nivel de atención?

- A. referir u hospitalizar si hay mal estado general, vómito persistente, deshidratación o imposibilidad de tratamiento oral*
- B. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- C. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: Incapacidad para hidratación o tratamiento oral y datos de sepsis aumentan el riesgo y justifican vigilancia hospitalaria. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Secretaría de Salud e Instituto Mexicano del Seguro Social. Abordaje Diagnóstico de Infección de Vías Urinarias No Complicada en Menores de 18 Años. GPC-SS-027-08.

Especialidad: Pediatría

Tema: Uropedia

Subtema: IVU

Dificultad: alta

Caso clínico: Lactante de 8 meses con fiebre de 39 grados, irritabilidad y rechazo parcial al alimento, sin un foco respiratorio o gastrointestinal claro. El examen general de orina obtenido con técnica adecuada muestra leucocituria y esterasa leucocitaria positiva; se toma muestra para cultivo antes de antimicrobianos. La evolución se ha modificado durante las últimas 12 horas y los familiares pueden aportar una cronología fiable. En un lactante febril, el conjunto de datos obliga a considerar infección de vías urinarias y a confirmar con cultivo apropiado.

Pregunta: ¿Qué conducta evita antibiótico innecesariamente amplio o prolongado?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. ajustar el antimicrobiano al urocultivo y a la evolución clínica, evitando prolongarlo sin indicación*
- C. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: El resultado microbiológico y la respuesta permiten desescalar y definir duración; la persistencia empírica sin reevaluación es insegura. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Secretaría de Salud e Instituto Mexicano del Seguro Social. Abordaje Diagnóstico de Infección de Vías Urinarias No Complicada en Menores de 18 Años. GPC-SS-027-08.

Especialidad: Pediatría

Tema: Uropedia

Subtema: IVU

Dificultad: alta

Caso clínico: Lactante de 8 meses con fiebre de 39 grados, irritabilidad y rechazo parcial al alimento, sin un foco respiratorio o gastrointestinal claro. El examen general de orina obtenido con técnica adecuada muestra leucocituria y esterasa leucocitaria positiva; se toma muestra para cultivo antes de antimicrobianos. La evolución se ha modificado durante las últimas 12 horas y los familiares pueden aportar una cronología fiable. En un lactante febril, el conjunto de datos obliga a considerar infección de vías urinarias y a confirmar con cultivo apropiado.

Pregunta: ¿Cómo debe decidirse el seguimiento posterior?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- C. indicar estudios de imagen y seguimiento conforme al riesgo, respuesta y recurrencia, no de manera idéntica para todos*
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: La imagen y la profilaxis se reservan según riesgo y curso clínico, para equilibrar detección de anomalías y uso racional de recursos. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Secretaría de Salud e Instituto Mexicano del Seguro Social. Abordaje Diagnóstico de Infección de Vías Urinarias No Complicada en Menores de 18 Años. GPC-SS-027-08.

Especialidad: Pediatría

Tema: Uropedia

Subtema: IVU

Dificultad: alta

Caso clínico: Lactante de 8 meses con fiebre de 39 grados, irritabilidad y rechazo parcial al alimento, sin un foco respiratorio o gastrointestinal claro. El examen general de orina obtenido con técnica adecuada muestra leucocituria y esterasa leucocitaria positiva; se toma muestra para cultivo antes de antimicrobianos. No existen antecedentes de alergia medicamentosa, pero hay barreras para regresar con rapidez si empeora. En un lactante febril, el conjunto de datos obliga a considerar infección de vías urinarias y a confirmar con cultivo apropiado.

Pregunta: ¿Cuál es la acción diagnóstica-terapéutica inicial más sólida?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- C. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación
- D. obtener urocultivo con una muestra confiable antes de la primera dosis, sin retrasar tratamiento si la condición clínica lo exige*

Explicación: El cultivo de una muestra obtenida correctamente documenta el diagnóstico y permite dirigir tratamiento; debe obtenerse antes del antibiótico cuando sea posible. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Secretaría de Salud e Instituto Mexicano del Seguro Social. Abordaje Diagnóstico de Infección de Vías Urinarias No Complicada en Menores de 18 Años. GPC-SS-027-08.

Especialidad: Pediatría

Tema: Uropedia

Subtema: IVU

Dificultad: alta

Caso clínico: Lactante de 8 meses con fiebre de 39 grados, irritabilidad y rechazo parcial al alimento, sin un foco respiratorio o gastrointestinal claro. El examen general de orina obtenido con técnica adecuada muestra leucocituria y esterasa leucocitaria positiva; se toma muestra para cultivo antes de antimicrobianos. No existen antecedentes de alergia medicamentosa, pero hay barreras para regresar con rapidez si empeora. En un lactante febril, el conjunto de datos obliga a considerar infección de vías urinarias y a confirmar con cultivo apropiado.

Pregunta: ¿Qué enfoque define la necesidad de atención de mayor complejidad?

- A. estratificar riesgo de complicación por edad, estado general, respuesta, recurrencia y anomalías conocidas*
- B. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- C. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: Edad, estado clínico y anomalías urológicas determinan el riesgo; no todos los niños febriles siguen el mismo trayecto. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Secretaría de Salud e Instituto Mexicano del Seguro Social. Abordaje Diagnóstico de Infección de Vías Urinarias No Complicada en Menores de 18 Años. GPC-SS-027-08.

Especialidad: Pediatría

Tema: Uropedia

Subtema: IVU

Dificultad: alta

Caso clínico: Lactante de 8 meses con fiebre de 39 grados, irritabilidad y rechazo parcial al alimento, sin un foco respiratorio o gastrointestinal claro. El examen general de orina obtenido con técnica adecuada muestra leucocituria y esterasa leucocitaria positiva; se toma muestra para cultivo antes de antimicrobianos. No existen antecedentes de alergia medicamentosa, pero hay barreras para regresar con rapidez si empeora. En un lactante febril, el conjunto de datos obliga a considerar infección de vías urinarias y a confirmar con cultivo apropiado.

Pregunta: ¿En qué situación es más apropiado escalar el nivel de atención?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. referir u hospitalizar si hay mal estado general, vómito persistente, deshidratación o imposibilidad de tratamiento oral*
- C. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: Incapacidad para hidratación o tratamiento oral y datos de sepsis aumentan el riesgo y justifican vigilancia hospitalaria. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Secretaría de Salud e Instituto Mexicano del Seguro Social. Abordaje Diagnóstico de Infección de Vías Urinarias No Complicada en Menores de 18 Años. GPC-SS-027-08.

Especialidad: Pediatría

Tema: Uropedia

Subtema: IVU

Dificultad: alta

Caso clínico: Lactante de 8 meses con fiebre de 39 grados, irritabilidad y rechazo parcial al alimento, sin un foco respiratorio o gastrointestinal claro. El examen general de orina obtenido con técnica adecuada muestra leucocituria y esterasa leucocitaria positiva; se toma muestra para cultivo antes de antimicrobianos. No existen antecedentes de alergia medicamentosa, pero hay barreras para regresar con rapidez si empeora. En un lactante febril, el conjunto de datos obliga a considerar infección de vías urinarias y a confirmar con cultivo apropiado.

Pregunta: ¿Qué conducta evita antibiótico innecesariamente amplio o prolongado?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- C. ajustar el antimicrobiano al urocultivo y a la evolución clínica, evitando prolongarlo sin indicación*
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: El resultado microbiológico y la respuesta permiten desescalar y definir duración; la persistencia empírica sin reevaluación es insegura. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Secretaría de Salud e Instituto Mexicano del Seguro Social. Abordaje Diagnóstico de Infección de Vías Urinarias No Complicada en Menores de 18 Años. GPC-SS-027-08.

Especialidad: Pediatría

Tema: Uropedia

Subtema: IVU

Dificultad: alta

Caso clínico: Lactante de 8 meses con fiebre de 39 grados, irritabilidad y rechazo parcial al alimento, sin un foco respiratorio o gastrointestinal claro. El examen general de orina obtenido con técnica adecuada muestra leucocituria y esterasa leucocitaria positiva; se toma muestra para cultivo antes de antimicrobianos. No existen antecedentes de alergia medicamentosa, pero hay barreras para regresar con rapidez si empeora. En un lactante febril, el conjunto de datos obliga a considerar infección de vías urinarias y a confirmar con cultivo apropiado.

Pregunta: ¿Cómo debe decidirse el seguimiento posterior?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- C. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación
- D. indicar estudios de imagen y seguimiento conforme al riesgo, respuesta y recurrencia, no de manera idéntica para todos*

Explicación: La imagen y la profilaxis se reservan según riesgo y curso clínico, para equilibrar detección de anomalías y uso racional de recursos. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Secretaría de Salud e Instituto Mexicano del Seguro Social. Abordaje Diagnóstico de Infección de Vías Urinarias No Complicada en Menores de 18 Años. GPC-SS-027-08.

Especialidad: Pediatría

Tema: Uropedia

Subtema: IVU

Dificultad: alta

Caso clínico: Lactante de 8 meses con fiebre de 39 grados, irritabilidad y rechazo parcial al alimento, sin un foco respiratorio o gastrointestinal claro. El examen general de orina obtenido con técnica adecuada muestra leucocituria y esterasa leucocitaria positiva; se toma muestra para cultivo antes de antimicrobianos. La revisión de medicamentos identifica una posible exposición reciente que debe considerarse al integrar el riesgo. En un lactante febril, el conjunto de datos obliga a considerar infección de vías urinarias y a confirmar con cultivo apropiado.

Pregunta: ¿Cuál es la acción diagnóstica-terapéutica inicial más sólida?

- A. obtener urocultivo con una muestra confiable antes de la primera dosis, sin retrasar tratamiento si la condición clínica lo exige*
- B. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- C. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: El cultivo de una muestra obtenida correctamente documenta el diagnóstico y permite dirigir tratamiento; debe obtenerse antes del antibiótico cuando sea posible. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Secretaría de Salud e Instituto Mexicano del Seguro Social. Abordaje Diagnóstico de Infección de Vías Urinarias No Complicada en Menores de 18 Años. GPC-SS-027-08.

Especialidad: Pediatría

Tema: Uropedia

Subtema: IVU

Dificultad: alta

Caso clínico: Lactante de 8 meses con fiebre de 39 grados, irritabilidad y rechazo parcial al alimento, sin un foco respiratorio o gastrointestinal claro. El examen general de orina obtenido con técnica adecuada muestra leucocituria y esterasa leucocitaria positiva; se toma muestra para cultivo antes de antimicrobianos. La revisión de medicamentos identifica una posible exposición reciente que debe considerarse al integrar el riesgo. En un lactante febril, el conjunto de datos obliga a considerar infección de vías urinarias y a confirmar con cultivo apropiado.

Pregunta: ¿Qué enfoque define la necesidad de atención de mayor complejidad?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. estratificar riesgo de complicación por edad, estado general, respuesta, recurrencia y anomalías conocidas*
- C. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: Edad, estado clínico y anomalías urológicas determinan el riesgo; no todos los niños febriles siguen el mismo trayecto. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Secretaría de Salud e Instituto Mexicano del Seguro Social. Abordaje Diagnóstico de Infección de Vías Urinarias No Complicada en Menores de 18 Años. GPC-SS-027-08.

Especialidad: Pediatría

Tema: Uropedia

Subtema: IVU

Dificultad: alta

Caso clínico: Lactante de 8 meses con fiebre de 39 grados, irritabilidad y rechazo parcial al alimento, sin un foco respiratorio o gastrointestinal claro. El examen general de orina obtenido con técnica adecuada muestra leucocituria y esterasa leucocitaria positiva; se toma muestra para cultivo antes de antimicrobianos. La revisión de medicamentos identifica una posible exposición reciente que debe considerarse al integrar el riesgo. En un lactante febril, el conjunto de datos obliga a considerar infección de vías urinarias y a confirmar con cultivo apropiado.

Pregunta: ¿En qué situación es más apropiado escalar el nivel de atención?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- C. referir u hospitalizar si hay mal estado general, vómito persistente, deshidratación o imposibilidad de tratamiento oral*
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: Incapacidad para hidratación o tratamiento oral y datos de sepsis aumentan el riesgo y justifican vigilancia hospitalaria. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Secretaría de Salud e Instituto Mexicano del Seguro Social. Abordaje Diagnóstico de Infección de Vías Urinarias No Complicada en Menores de 18 Años. GPC-SS-027-08.

Especialidad: Pediatría

Tema: Uropedia

Subtema: IVU

Dificultad: alta

Caso clínico: Lactante de 8 meses con fiebre de 39 grados, irritabilidad y rechazo parcial al alimento, sin un foco respiratorio o gastrointestinal claro. El examen general de orina obtenido con técnica adecuada muestra leucocituria y esterasa leucocitaria positiva; se toma muestra para cultivo antes de antimicrobianos. La revisión de medicamentos identifica una posible exposición reciente que debe considerarse al integrar el riesgo. En un lactante febril, el conjunto de datos obliga a considerar infección de vías urinarias y a confirmar con cultivo apropiado.

Pregunta: ¿Qué conducta evita antibiótico innecesariamente amplio o prolongado?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- C. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación
- D. ajustar el antimicrobiano al urocultivo y a la evolución clínica, evitando prolongarlo sin indicación*

Explicación: El resultado microbiológico y la respuesta permiten desescalar y definir duración; la persistencia empírica sin reevaluación es insegura. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Secretaría de Salud e Instituto Mexicano del Seguro Social. Abordaje Diagnóstico de Infección de Vías Urinarias No Complicada en Menores de 18 Años. GPC-SS-027-08.

Especialidad: Pediatría

Tema: Uropedia

Subtema: IVU

Dificultad: alta

Caso clínico: Lactante de 8 meses con fiebre de 39 grados, irritabilidad y rechazo parcial al alimento, sin un foco respiratorio o gastrointestinal claro. El examen general de orina obtenido con técnica adecuada muestra leucocituria y esterasa leucocitaria positiva; se toma muestra para cultivo antes de antimicrobianos. La revisión de medicamentos identifica una posible exposición reciente que debe considerarse al integrar el riesgo. En un lactante febril, el conjunto de datos obliga a considerar infección de vías urinarias y a confirmar con cultivo apropiado.

Pregunta: ¿Cómo debe decidirse el seguimiento posterior?

- A. indicar estudios de imagen y seguimiento conforme al riesgo, respuesta y recurrencia, no de manera idéntica para todos*
- B. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- C. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: La imagen y la profilaxis se reservan según riesgo y curso clínico, para equilibrar detección de anomalías y uso racional de recursos. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Secretaría de Salud e Instituto Mexicano del Seguro Social. Abordaje Diagnóstico de Infección de Vías Urinarias No Complicada en Menores de 18 Años. GPC-SS-027-08.

Especialidad: Pediatría

Tema: Uropedia

Subtema: IVU

Dificultad: alta

Caso clínico: Lactante de 8 meses con fiebre de 39 grados, irritabilidad y rechazo parcial al alimento, sin un foco respiratorio o gastrointestinal claro. El examen general de orina obtenido con técnica adecuada muestra leucocituria y esterasa leucocitaria positiva; se toma muestra para cultivo antes de antimicrobianos. Los signos vitales se repiten después de una primera medida de soporte y muestran la misma tendencia clínica. En un lactante febril, el conjunto de datos obliga a considerar infección de vías urinarias y a confirmar con cultivo apropiado.

Pregunta: ¿Cuál es la acción diagnóstica-terapéutica inicial más sólida?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. obtener urocultivo con una muestra confiable antes de la primera dosis, sin retrasar tratamiento si la condición clínica lo exige*
- C. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: El cultivo de una muestra obtenida correctamente documenta el diagnóstico y permite dirigir tratamiento; debe obtenerse antes del antibiótico cuando sea posible. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Secretaría de Salud e Instituto Mexicano del Seguro Social. Abordaje Diagnóstico de Infección de Vías Urinarias No Complicada en Menores de 18 Años. GPC-SS-027-08.

Especialidad: Pediatría

Tema: Uropedia

Subtema: IVU

Dificultad: alta

Caso clínico: Lactante de 8 meses con fiebre de 39 grados, irritabilidad y rechazo parcial al alimento, sin un foco respiratorio o gastrointestinal claro. El examen general de orina obtenido con técnica adecuada muestra leucocituria y esterasa leucocitaria positiva; se toma muestra para cultivo antes de antimicrobianos. Los signos vitales se repiten después de una primera medida de soporte y muestran la misma tendencia clínica. En un lactante febril, el conjunto de datos obliga a considerar infección de vías urinarias y a confirmar con cultivo apropiado.

Pregunta: ¿Qué enfoque define la necesidad de atención de mayor complejidad?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- C. estratificar riesgo de complicación por edad, estado general, respuesta, recurrencia y anomalías conocidas*
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: Edad, estado clínico y anomalías urológicas determinan el riesgo; no todos los niños febriles siguen el mismo trayecto. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Secretaría de Salud e Instituto Mexicano del Seguro Social. Abordaje Diagnóstico de Infección de Vías Urinarias No Complicada en Menores de 18 Años. GPC-SS-027-08.

Especialidad: Pediatría

Tema: Uropedia

Subtema: IVU

Dificultad: alta

Caso clínico: Lactante de 8 meses con fiebre de 39 grados, irritabilidad y rechazo parcial al alimento, sin un foco respiratorio o gastrointestinal claro. El examen general de orina obtenido con técnica adecuada muestra leucocituria y esterasa leucocitaria positiva; se toma muestra para cultivo antes de antimicrobianos. Los signos vitales se repiten después de una primera medida de soporte y muestran la misma tendencia clínica. En un lactante febril, el conjunto de datos obliga a considerar infección de vías urinarias y a confirmar con cultivo apropiado.

Pregunta: ¿En qué situación es más apropiado escalar el nivel de atención?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- C. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación
- D. referir u hospitalizar si hay mal estado general, vómito persistente, deshidratación o imposibilidad de tratamiento oral*

Explicación: Incapacidad para hidratación o tratamiento oral y datos de sepsis aumentan el riesgo y justifican vigilancia hospitalaria. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Secretaría de Salud e Instituto Mexicano del Seguro Social. Abordaje Diagnóstico de Infección de Vías Urinarias No Complicada en Menores de 18 Años. GPC-SS-027-08.

Especialidad: Pediatría

Tema: Uropedia

Subtema: IVU

Dificultad: alta

Caso clínico: Lactante de 8 meses con fiebre de 39 grados, irritabilidad y rechazo parcial al alimento, sin un foco respiratorio o gastrointestinal claro. El examen general de orina obtenido con técnica adecuada muestra leucocituria y esterasa leucocitaria positiva; se toma muestra para cultivo antes de antimicrobianos. Los signos vitales se repiten después de una primera medida de soporte y muestran la misma tendencia clínica. En un lactante febril, el conjunto de datos obliga a considerar infección de vías urinarias y a confirmar con cultivo apropiado.

Pregunta: ¿Qué conducta evita antibiótico innecesariamente amplio o prolongado?

- A. ajustar el antimicrobiano al urocultivo y a la evolución clínica, evitando prolongarlo sin indicación*
- B. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- C. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: El resultado microbiológico y la respuesta permiten desescalar y definir duración; la persistencia empírica sin reevaluación es insegura. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Secretaría de Salud e Instituto Mexicano del Seguro Social. Abordaje Diagnóstico de Infección de Vías Urinarias No Complicada en Menores de 18 Años. GPC-SS-027-08.

Especialidad: Pediatría

Tema: Uropedia

Subtema: IVU

Dificultad: alta

Caso clínico: Lactante de 8 meses con fiebre de 39 grados, irritabilidad y rechazo parcial al alimento, sin un foco respiratorio o gastrointestinal claro. El examen general de orina obtenido con técnica adecuada muestra leucocituria y esterasa leucocitaria positiva; se toma muestra para cultivo antes de antimicrobianos. Los signos vitales se repiten después de una primera medida de soporte y muestran la misma tendencia clínica. En un lactante febril, el conjunto de datos obliga a considerar infección de vías urinarias y a confirmar con cultivo apropiado.

Pregunta: ¿Cómo debe decidirse el seguimiento posterior?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. indicar estudios de imagen y seguimiento conforme al riesgo, respuesta y recurrencia, no de manera idéntica para todos*
- C. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: La imagen y la profilaxis se reservan según riesgo y curso clínico, para equilibrar detección de anomalías y uso racional de recursos. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Secretaría de Salud e Instituto Mexicano del Seguro Social. Abordaje Diagnóstico de Infección de Vías Urinarias No Complicada en Menores de 18 Años. GPC-SS-027-08.

Especialidad: Pediatría

Tema: Diarrea en el Pediátrico

Subtema: Planes de Hidratación

Dificultad: alta

Caso clínico: Niña de 20 meses con 24 horas de evacuaciones líquidas, dos vómitos y menor diuresis. Está alerta, con lágrimas escasas, mucosa oral seca y llenado capilar de dos segundos; no hay sangre en heces, rigidez de nuca ni distensión abdominal. La familia ha ofrecido sólo agua y bebidas azucaradas. La evolución se ha modificado durante las últimas 12 horas y los familiares pueden aportar una cronología fiable. Se integra diarrea aguda con grado de deshidratación que debe clasificarse clínicamente para elegir el plan de rehidratación.

Pregunta: ¿Cuál es el siguiente paso terapéutico más adecuado?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- C. clasificar deshidratación por signos clínicos y administrar solución de rehidratación oral en volumen y tiempo acordes con esa clasificación*
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: La solución oral y la clasificación clínica corrigen pérdidas de manera segura; agua sola y bebidas azucaradas no reemplazan electrolitos adecuadamente. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de la Diarrea Aguda en Niños de Dos Meses a Cinco Años en el Primero y Segundo Nivel de Atención. GPC-IMSS-156-08.

Especialidad: Pediatría

Tema: Diarrea en el Pediátrico

Subtema: Planes de Hidratación

Dificultad: alta

Caso clínico: Niña de 20 meses con 24 horas de evacuaciones líquidas, dos vómitos y menor diuresis. Está alerta, con lágrimas escasas, mucosa oral seca y llenado capilar de dos segundos; no hay sangre en heces, rigidez de nuca ni distensión abdominal. La familia ha ofrecido sólo agua y bebidas azucaradas. La evolución se ha modificado durante las últimas 12 horas y los familiares pueden aportar una cronología fiable. Se integra diarrea aguda con grado de deshidratación que debe clasificarse clínicamente para elegir el plan de rehidratación.

Pregunta: ¿Qué recomendación nutricional debe acompañar la hidratación?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- C. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación
- D. continuar alimentación apropiada para la edad y lactancia, aun durante la rehidratación*

Explicación: Mantener lactancia y alimentación apropiada disminuye deterioro nutricional y favorece recuperación. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de la Diarrea Aguda en Niños de Dos Meses a Cinco Años en el Primero y Segundo Nivel de Atención. GPC-IMSS-156-08.

Especialidad: Pediatría

Tema: Diarrea en el Pediátrico

Subtema: Planes de Hidratación

Dificultad: alta

Caso clínico: Niña de 20 meses con 24 horas de evacuaciones líquidas, dos vómitos y menor diuresis. Está alerta, con lágrimas escasas, mucosa oral seca y llenado capilar de dos segundos; no hay sangre en heces, rigidez de nuca ni distensión abdominal. La familia ha ofrecido sólo agua y bebidas azucaradas. La evolución se ha modificado durante las últimas 12 horas y los familiares pueden aportar una cronología fiable. Se integra diarrea aguda con grado de deshidratación que debe clasificarse clínicamente para elegir el plan de rehidratación.

Pregunta: ¿Qué evaluación es indispensable antes del egreso?

- A. revalorar tolerancia oral, diuresis, estado mental y signos vitales antes de decidir alta*
- B. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- C. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: La reevaluación objetiva evita dar de alta a un menor que no tolera líquidos o progresa a deshidratación. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de la Diarrea Aguda en Niños de Dos Meses a Cinco Años en el Primero y Segundo Nivel de Atención. GPC-IMSS-156-08.

Especialidad: Pediatría

Tema: Diarrea en el Pediátrico

Subtema: Planes de Hidratación

Dificultad: alta

Caso clínico: Niña de 20 meses con 24 horas de evacuaciones líquidas, dos vómitos y menor diuresis. Está alerta, con lágrimas escasas, mucosa oral seca y llenado capilar de dos segundos; no hay sangre en heces, rigidez de nuca ni distensión abdominal. La familia ha ofrecido sólo agua y bebidas azucaradas. La evolución se ha modificado durante las últimas 12 horas y los familiares pueden aportar una cronología fiable. Se integra diarrea aguda con grado de deshidratación que debe clasificarse clínicamente para elegir el plan de rehidratación.

Pregunta: ¿Cuándo debe cambiarse a rehidratación intravenosa?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. usar líquidos intravenosos si existe choque, deterioro del estado mental o fracaso de rehidratación oral supervisada*
- C. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: Choque, alteración de conciencia o fracaso de la vía oral obligan a una estrategia intravenosa y vigilancia estrecha. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de la Diarrea Aguda en Niños de Dos Meses a Cinco Años en el Primero y Segundo Nivel de Atención. GPC-IMSS-156-08.

Especialidad: Pediatría

Tema: Diarrea en el Pediátrico

Subtema: Planes de Hidratación

Dificultad: alta

Caso clínico: Niña de 20 meses con 24 horas de evacuaciones líquidas, dos vómitos y menor diuresis. Está alerta, con lágrimas escasas, mucosa oral seca y llenado capilar de dos segundos; no hay sangre en heces, rigidez de nuca ni distensión abdominal. La familia ha ofrecido sólo agua y bebidas azucaradas. La evolución se ha modificado durante las últimas 12 horas y los familiares pueden aportar una cronología fiable. Se integra diarrea aguda con grado de deshidratación que debe clasificarse clínicamente para elegir el plan de rehidratación.

Pregunta: ¿Qué medida domiciliaria reduce errores y retraso en la atención?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- C. educar sobre preparación correcta de solución oral y signos que ameritan regreso inmediato*
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: La técnica de preparación y los signos de alarma son parte del tratamiento porque evitan recurrencia de deshidratación y consultas tardías. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de la Diarrea Aguda en Niños de Dos Meses a Cinco Años en el Primero y Segundo Nivel de Atención. GPC-IMSS-156-08.

Especialidad: Pediatría

Tema: Diarrea en el Pediátrico

Subtema: Planes de Hidratación

Dificultad: alta

Caso clínico: Niña de 20 meses con 24 horas de evacuaciones líquidas, dos vómitos y menor diuresis. Está alerta, con lágrimas escasas, mucosa oral seca y llenado capilar de dos segundos; no hay sangre en heces, rigidez de nuca ni distensión abdominal. La familia ha ofrecido sólo agua y bebidas azucaradas. No existen antecedentes de alergia medicamentosa, pero hay barreras para regresar con rapidez si empeora. Se integra diarrea aguda con grado de deshidratación que debe clasificarse clínicamente para elegir el plan de rehidratación.

Pregunta: ¿Cuál es el siguiente paso terapéutico más adecuado?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- C. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación
- D. clasificar deshidratación por signos clínicos y administrar solución de rehidratación oral en volumen y tiempo acordes con esa clasificación*

Explicación: La solución oral y la clasificación clínica corrigen pérdidas de manera segura; agua sola y bebidas azucaradas no reemplazan electrolitos adecuadamente. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de la Diarrea Aguda en Niños de Dos Meses a Cinco Años en el Primero y Segundo Nivel de Atención. GPC-IMSS-156-08.

Especialidad: Pediatría

Tema: Diarrea en el Pediátrico

Subtema: Planes de Hidratación

Dificultad: alta

Caso clínico: Niña de 20 meses con 24 horas de evacuaciones líquidas, dos vómitos y menor diuresis. Está alerta, con lágrimas escasas, mucosa oral seca y llenado capilar de dos segundos; no hay sangre en heces, rigidez de nuca ni distensión abdominal. La familia ha ofrecido sólo agua y bebidas azucaradas. No existen antecedentes de alergia medicamentosa, pero hay barreras para regresar con rapidez si empeora. Se integra diarrea aguda con grado de deshidratación que debe clasificarse clínicamente para elegir el plan de rehidratación.

Pregunta: ¿Qué recomendación nutricional debe acompañar la hidratación?

- A. continuar alimentación apropiada para la edad y lactancia, aun durante la rehidratación*
- B. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- C. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: Mantener lactancia y alimentación apropiada disminuye deterioro nutricional y favorece recuperación. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de la Diarrea Aguda en Niños de Dos Meses a Cinco Años en el Primero y Segundo Nivel de Atención. GPC-IMSS-156-08.

Especialidad: Pediatría

Tema: Diarrea en el Pediátrico

Subtema: Planes de Hidratación

Dificultad: alta

Caso clínico: Niña de 20 meses con 24 horas de evacuaciones líquidas, dos vómitos y menor diuresis. Está alerta, con lágrimas escasas, mucosa oral seca y llenado capilar de dos segundos; no hay sangre en heces, rigidez de nuca ni distensión abdominal. La familia ha ofrecido sólo agua y bebidas azucaradas. No existen antecedentes de alergia medicamentosa, pero hay barreras para regresar con rapidez si empeora. Se integra diarrea aguda con grado de deshidratación que debe clasificarse clínicamente para elegir el plan de rehidratación.

Pregunta: ¿Qué evaluación es indispensable antes del egreso?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. revalorar tolerancia oral, diuresis, estado mental y signos vitales antes de decidir alta*
- C. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: La reevaluación objetiva evita dar de alta a un menor que no tolera líquidos o progresa a deshidratación. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de la Diarrea Aguda en Niños de Dos Meses a Cinco Años en el Primero y Segundo Nivel de Atención. GPC-IMSS-156-08.

Especialidad: Pediatría

Tema: Diarrea en el Pediátrico

Subtema: Planes de Hidratación

Dificultad: alta

Caso clínico: Niña de 20 meses con 24 horas de evacuaciones líquidas, dos vómitos y menor diuresis. Está alerta, con lágrimas escasas, mucosa oral seca y llenado capilar de dos segundos; no hay sangre en heces, rigidez de nuca ni distensión abdominal. La familia ha ofrecido sólo agua y bebidas azucaradas. No existen antecedentes de alergia medicamentosa, pero hay barreras para regresar con rapidez si empeora. Se integra diarrea aguda con grado de deshidratación que debe clasificarse clínicamente para elegir el plan de rehidratación.

Pregunta: ¿Cuándo debe cambiarse a rehidratación intravenosa?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- C. usar líquidos intravenosos si existe choque, deterioro del estado mental o fracaso de rehidratación oral supervisada*
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: Choque, alteración de conciencia o fracaso de la vía oral obligan a una estrategia intravenosa y vigilancia estrecha. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de la Diarrea Aguda en Niños de Dos Meses a Cinco Años en el Primero y Segundo Nivel de Atención. GPC-IMSS-156-08.

Especialidad: Pediatría

Tema: Diarrea en el Pediátrico

Subtema: Planes de Hidratación

Dificultad: alta

Caso clínico: Niña de 20 meses con 24 horas de evacuaciones líquidas, dos vómitos y menor diuresis. Está alerta, con lágrimas escasas, mucosa oral seca y llenado capilar de dos segundos; no hay sangre en heces, rigidez de nuca ni distensión abdominal. La familia ha ofrecido sólo agua y bebidas azucaradas. No existen antecedentes de alergia medicamentosa, pero hay barreras para regresar con rapidez si empeora. Se integra diarrea aguda con grado de deshidratación que debe clasificarse clínicamente para elegir el plan de rehidratación.

Pregunta: ¿Qué medida domiciliaria reduce errores y retraso en la atención?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- C. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación
- D. educar sobre preparación correcta de solución oral y signos que ameritan regreso inmediato*

Explicación: La técnica de preparación y los signos de alarma son parte del tratamiento porque evitan recurrencia de deshidratación y consultas tardías. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de la Diarrea Aguda en Niños de Dos Meses a Cinco Años en el Primero y Segundo Nivel de Atención. GPC-IMSS-156-08.

Especialidad: Pediatría

Tema: Diarrea en el Pediátrico

Subtema: Planes de Hidratación

Dificultad: alta

Caso clínico: Niña de 20 meses con 24 horas de evacuaciones líquidas, dos vómitos y menor diuresis. Está alerta, con lágrimas escasas, mucosa oral seca y llenado capilar de dos segundos; no hay sangre en heces, rigidez de nuca ni distensión abdominal. La familia ha ofrecido sólo agua y bebidas azucaradas. La revisión de medicamentos identifica una posible exposición reciente que debe considerarse al integrar el riesgo. Se integra diarrea aguda con grado de deshidratación que debe clasificarse clínicamente para elegir el plan de rehidratación.

Pregunta: ¿Cuál es el siguiente paso terapéutico más adecuado?

- A. clasificar deshidratación por signos clínicos y administrar solución de rehidratación oral en volumen y tiempo acordes con esa clasificación*
- B. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- C. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: La solución oral y la clasificación clínica corrigen pérdidas de manera segura; agua sola y bebidas azucaradas no reemplazan electrolitos adecuadamente. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de la Diarrea Aguda en Niños de Dos Meses a Cinco Años en el Primero y Segundo Nivel de Atención. GPC-IMSS-156-08.

Especialidad: Pediatría

Tema: Diarrea en el Pediátrico

Subtema: Planes de Hidratación

Dificultad: alta

Caso clínico: Niña de 20 meses con 24 horas de evacuaciones líquidas, dos vómitos y menor diuresis. Está alerta, con lágrimas escasas, mucosa oral seca y llenado capilar de dos segundos; no hay sangre en heces, rigidez de nuca ni distensión abdominal. La familia ha ofrecido sólo agua y bebidas azucaradas. La revisión de medicamentos identifica una posible exposición reciente que debe considerarse al integrar el riesgo. Se integra diarrea aguda con grado de deshidratación que debe clasificarse clínicamente para elegir el plan de rehidratación.

Pregunta: ¿Qué recomendación nutricional debe acompañar la hidratación?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. continuar alimentación apropiada para la edad y lactancia, aun durante la rehidratación*
- C. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: Mantener lactancia y alimentación apropiada disminuye deterioro nutricional y favorece recuperación. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de la Diarrea Aguda en Niños de Dos Meses a Cinco Años en el Primero y Segundo Nivel de Atención. GPC-IMSS-156-08.

Especialidad: Pediatría

Tema: Diarrea en el Pediátrico

Subtema: Planes de Hidratación

Dificultad: alta

Caso clínico: Niña de 20 meses con 24 horas de evacuaciones líquidas, dos vómitos y menor diuresis. Está alerta, con lágrimas escasas, mucosa oral seca y llenado capilar de dos segundos; no hay sangre en heces, rigidez de nuca ni distensión abdominal. La familia ha ofrecido sólo agua y bebidas azucaradas. La revisión de medicamentos identifica una posible exposición reciente que debe considerarse al integrar el riesgo. Se integra diarrea aguda con grado de deshidratación que debe clasificarse clínicamente para elegir el plan de rehidratación.

Pregunta: ¿Qué evaluación es indispensable antes del egreso?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- C. revalorar tolerancia oral, diuresis, estado mental y signos vitales antes de decidir alta*
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: La reevaluación objetiva evita dar de alta a un menor que no tolera líquidos o progresa a deshidratación. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de la Diarrea Aguda en Niños de Dos Meses a Cinco Años en el Primero y Segundo Nivel de Atención. GPC-IMSS-156-08.

Especialidad: Pediatría

Tema: Diarrea en el Pediátrico

Subtema: Planes de Hidratación

Dificultad: alta

Caso clínico: Niña de 20 meses con 24 horas de evacuaciones líquidas, dos vómitos y menor diuresis. Está alerta, con lágrimas escasas, mucosa oral seca y llenado capilar de dos segundos; no hay sangre en heces, rigidez de nuca ni distensión abdominal. La familia ha ofrecido sólo agua y bebidas azucaradas. La revisión de medicamentos identifica una posible exposición reciente que debe considerarse al integrar el riesgo. Se integra diarrea aguda con grado de deshidratación que debe clasificarse clínicamente para elegir el plan de rehidratación.

Pregunta: ¿Cuándo debe cambiarse a rehidratación intravenosa?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- C. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación
- D. usar líquidos intravenosos si existe choque, deterioro del estado mental o fracaso de rehidratación oral supervisada*

Explicación: Choque, alteración de conciencia o fracaso de la vía oral obligan a una estrategia intravenosa y vigilancia estrecha. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de la Diarrea Aguda en Niños de Dos Meses a Cinco Años en el Primero y Segundo Nivel de Atención. GPC-IMSS-156-08.

Especialidad: Pediatría

Tema: Diarrea en el Pediátrico

Subtema: Planes de Hidratación

Dificultad: alta

Caso clínico: Niña de 20 meses con 24 horas de evacuaciones líquidas, dos vómitos y menor diuresis. Está alerta, con lágrimas escasas, mucosa oral seca y llenado capilar de dos segundos; no hay sangre en heces, rigidez de nuca ni distensión abdominal. La familia ha ofrecido sólo agua y bebidas azucaradas. La revisión de medicamentos identifica una posible exposición reciente que debe considerarse al integrar el riesgo. Se integra diarrea aguda con grado de deshidratación que debe clasificarse clínicamente para elegir el plan de rehidratación.

Pregunta: ¿Qué medida domiciliaria reduce errores y retraso en la atención?

- A. educar sobre preparación correcta de solución oral y signos que ameritan regreso inmediato*
- B. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- C. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: La técnica de preparación y los signos de alarma son parte del tratamiento porque evitan recurrencia de deshidratación y consultas tardías. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de la Diarrea Aguda en Niños de Dos Meses a Cinco Años en el Primero y Segundo Nivel de Atención. GPC-IMSS-156-08.

Especialidad: Pediatría

Tema: Diarrea en el Pediátrico

Subtema: Planes de Hidratación

Dificultad: alta

Caso clínico: Niña de 20 meses con 24 horas de evacuaciones líquidas, dos vómitos y menor diuresis. Está alerta, con lágrimas escasas, mucosa oral seca y llenado capilar de dos segundos; no hay sangre en heces, rigidez de nuca ni distensión abdominal. La familia ha ofrecido sólo agua y bebidas azucaradas. Los signos vitales se repiten después de una primera medida de soporte y muestran la misma tendencia clínica. Se integra diarrea aguda con grado de deshidratación que debe clasificarse clínicamente para elegir el plan de rehidratación.

Pregunta: ¿Cuál es el siguiente paso terapéutico más adecuado?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. clasificar deshidratación por signos clínicos y administrar solución de rehidratación oral en volumen y tiempo acordes con esa clasificación*
- C. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: La solución oral y la clasificación clínica corrigen pérdidas de manera segura; agua sola y bebidas azucaradas no reemplazan electrolitos adecuadamente. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de la Diarrea Aguda en Niños de Dos Meses a Cinco Años en el Primero y Segundo Nivel de Atención. GPC-IMSS-156-08.

Especialidad: Pediatría

Tema: Diarrea en el Pediátrico

Subtema: Planes de Hidratación

Dificultad: alta

Caso clínico: Niña de 20 meses con 24 horas de evacuaciones líquidas, dos vómitos y menor diuresis. Está alerta, con lágrimas escasas, mucosa oral seca y llenado capilar de dos segundos; no hay sangre en heces, rigidez de nuca ni distensión abdominal. La familia ha ofrecido sólo agua y bebidas azucaradas. Los signos vitales se repiten después de una primera medida de soporte y muestran la misma tendencia clínica. Se integra diarrea aguda con grado de deshidratación que debe clasificarse clínicamente para elegir el plan de rehidratación.

Pregunta: ¿Qué recomendación nutricional debe acompañar la hidratación?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- C. continuar alimentación apropiada para la edad y lactancia, aun durante la rehidratación*
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: Mantener lactancia y alimentación apropiada disminuye deterioro nutricional y favorece recuperación. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de la Diarrea Aguda en Niños de Dos Meses a Cinco Años en el Primero y Segundo Nivel de Atención. GPC-IMSS-156-08.

Especialidad: Pediatría

Tema: Diarrea en el Pediátrico

Subtema: Planes de Hidratación

Dificultad: alta

Caso clínico: Niña de 20 meses con 24 horas de evacuaciones líquidas, dos vómitos y menor diuresis. Está alerta, con lágrimas escasas, mucosa oral seca y llenado capilar de dos segundos; no hay sangre en heces, rigidez de nuca ni distensión abdominal. La familia ha ofrecido sólo agua y bebidas azucaradas. Los signos vitales se repiten después de una primera medida de soporte y muestran la misma tendencia clínica. Se integra diarrea aguda con grado de deshidratación que debe clasificarse clínicamente para elegir el plan de rehidratación.

Pregunta: ¿Qué evaluación es indispensable antes del egreso?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- C. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación
- D. revalorar tolerancia oral, diuresis, estado mental y signos vitales antes de decidir alta*

Explicación: La reevaluación objetiva evita dar de alta a un menor que no tolera líquidos o progresa a deshidratación. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de la Diarrea Aguda en Niños de Dos Meses a Cinco Años en el Primero y Segundo Nivel de Atención. GPC-IMSS-156-08.

Especialidad: Pediatría

Tema: Diarrea en el Pediátrico

Subtema: Planes de Hidratación

Dificultad: alta

Caso clínico: Niña de 20 meses con 24 horas de evacuaciones líquidas, dos vómitos y menor diuresis. Está alerta, con lágrimas escasas, mucosa oral seca y llenado capilar de dos segundos; no hay sangre en heces, rigidez de nuca ni distensión abdominal. La familia ha ofrecido sólo agua y bebidas azucaradas. Los signos vitales se repiten después de una primera medida de soporte y muestran la misma tendencia clínica. Se integra diarrea aguda con grado de deshidratación que debe clasificarse clínicamente para elegir el plan de rehidratación.

Pregunta: ¿Cuándo debe cambiarse a rehidratación intravenosa?

- A. usar líquidos intravenosos si existe choque, deterioro del estado mental o fracaso de rehidratación oral supervisada*
- B. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- C. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: Choque, alteración de conciencia o fracaso de la vía oral obligan a una estrategia intravenosa y vigilancia estrecha. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de la Diarrea Aguda en Niños de Dos Meses a Cinco Años en el Primero y Segundo Nivel de Atención. GPC-IMSS-156-08.

Especialidad: Pediatría

Tema: Diarrea en el Pediátrico

Subtema: Planes de Hidratación

Dificultad: alta

Caso clínico: Niña de 20 meses con 24 horas de evacuaciones líquidas, dos vómitos y menor diuresis. Está alerta, con lágrimas escasas, mucosa oral seca y llenado capilar de dos segundos; no hay sangre en heces, rigidez de nuca ni distensión abdominal. La familia ha ofrecido sólo agua y bebidas azucaradas. Los signos vitales se repiten después de una primera medida de soporte y muestran la misma tendencia clínica. Se integra diarrea aguda con grado de deshidratación que debe clasificarse clínicamente para elegir el plan de rehidratación.

Pregunta: ¿Qué medida domiciliaria reduce errores y retraso en la atención?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. educar sobre preparación correcta de solución oral y signos que ameritan regreso inmediato*
- C. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: La técnica de preparación y los signos de alarma son parte del tratamiento porque evitan recurrencia de deshidratación y consultas tardías. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de la Diarrea Aguda en Niños de Dos Meses a Cinco Años en el Primero y Segundo Nivel de Atención. GPC-IMSS-156-08.

Especialidad: Pediatría

Tema: Patología Respiratoria del Pediátrico

Subtema: Enfermedad de Membrana Hialina

Dificultad: alta

Caso clínico: Recién nacido de 29 semanas, producto de parto pretérmino, presenta desde el nacimiento quejido espiratorio, retracciones subcostales, aleteo nasal y necesidad creciente de oxígeno. La radiografía muestra volumen pulmonar reducido y patrón reticulogranular difuso con broncograma aéreo. La evolución se ha modificado durante las últimas 12 horas y los familiares pueden aportar una cronología fiable. La edad gestacional, inicio inmediato y patrón radiológico son característicos de síndrome de dificultad respiratoria por deficiencia de surfactante.

Pregunta: ¿Cuál es el soporte inicial más apropiado en un recién nacido estable?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- C. iniciar soporte respiratorio no invasivo temprano cuando la condición lo permita y titular oxígeno para evitar hipoxemia e hiperoxia*
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: La presión positiva continua y oxígeno titulado favorecen reclutamiento alveolar y limitan exposición innecesaria a ventilación invasiva. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Síndrome de Dificultad Respiratoria en el Recién Nacido. GPC-IMSS-137-08.

Especialidad: Pediatría

Tema: Patología Respiratoria del Pediátrico

Subtema: Enfermedad de Membrana Hialina

Dificultad: alta

Caso clínico: Recién nacido de 29 semanas, producto de parto pretérmino, presenta desde el nacimiento quejido espiratorio, retracciones subcostales, aleteo nasal y necesidad creciente de oxígeno. La radiografía muestra volumen pulmonar reducido y patrón reticulogranular difuso con broncograma aéreo. La evolución se ha modificado durante las últimas 12 horas y los familiares pueden aportar una cronología fiable. La edad gestacional, inicio inmediato y patrón radiológico son característicos de síndrome de dificultad respiratoria por deficiencia de surfactante.

Pregunta: ¿Qué intervención se indica si persiste dificultad significativa?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- C. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación
- D. administrar surfactante por técnica menos invasiva o ventilación según gravedad y respuesta al soporte inicial*

Explicación: La persistencia de insuficiencia respiratoria a pesar del soporte inicial indica reemplazo de surfactante según gravedad. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Síndrome de Dificultad Respiratoria en el Recién Nacido. GPC-IMSS-137-08.

Especialidad: Pediatría

Tema: Patología Respiratoria del Pediátrico

Subtema: Enfermedad de Membrana Hialina

Dificultad: alta

Caso clínico: Recién nacido de 29 semanas, producto de parto pretérmino, presenta desde el nacimiento quejido espiratorio, retracciones subcostales, aleteo nasal y necesidad creciente de oxígeno. La radiografía muestra volumen pulmonar reducido y patrón reticulogranular difuso con broncograma aéreo. La evolución se ha modificado durante las últimas 12 horas y los familiares pueden aportar una cronología fiable. La edad gestacional, inicio inmediato y patrón radiológico son característicos de síndrome de dificultad respiratoria por deficiencia de surfactante.

Pregunta: ¿Qué criterio guía un escalamiento oportuno?

- A. vigilar gases, trabajo respiratorio, perfusión y necesidad de escalamiento sin retrasar apoyo ventilatorio si fracasa el manejo inicial*
- B. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- C. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: El deterioro de gases, trabajo respiratorio o perfusión identifica fracaso temprano y obliga a reevaluar la modalidad ventilatoria. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Síndrome de Dificultad Respiratoria en el Recién Nacido. GPC-IMSS-137-08.

Especialidad: Pediatría

Tema: Patología Respiratoria del Pediátrico

Subtema: Enfermedad de Membrana Hialina

Dificultad: alta

Caso clínico: Recién nacido de 29 semanas, producto de parto pretérmino, presenta desde el nacimiento quejido espiratorio, retracciones subcostales, aleteo nasal y necesidad creciente de oxígeno. La radiografía muestra volumen pulmonar reducido y patrón reticulogranular difuso con broncograma aéreo. La evolución se ha modificado durante las últimas 12 horas y los familiares pueden aportar una cronología fiable. La edad gestacional, inicio inmediato y patrón radiológico son característicos de síndrome de dificultad respiratoria por deficiencia de surfactante.

Pregunta: ¿Qué medida de soporte no respiratorio es esencial?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. mantener temperatura, glucosa y hemodinamia adecuadas porque agravan el consumo de oxígeno y la insuficiencia respiratoria*
- C. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: Hipotermia, hipoglucemia y mala perfusión aumentan demanda metabólica y empeoran la oxigenación. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Síndrome de Dificultad Respiratoria en el Recién Nacido. GPC-IMSS-137-08.

Especialidad: Pediatría

Tema: Patología Respiratoria del Pediátrico

Subtema: Enfermedad de Membrana Hialina

Dificultad: alta

Caso clínico: Recién nacido de 29 semanas, producto de parto pretérmino, presenta desde el nacimiento quejido espiratorio, retracciones subcostales, aleteo nasal y necesidad creciente de oxígeno. La radiografía muestra volumen pulmonar reducido y patrón reticulogranular difuso con broncograma aéreo. La evolución se ha modificado durante las últimas 12 horas y los familiares pueden aportar una cronología fiable. La edad gestacional, inicio inmediato y patrón radiológico son característicos de síndrome de dificultad respiratoria por deficiencia de surfactante.

Pregunta: ¿Qué principio reduce lesión pulmonar asociada al tratamiento?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- C. evitar ventilación invasiva prolongada cuando exista alternativa segura por su relación con lesión pulmonar*
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: La ventilación debe usar la menor invasividad y presión compatibles con estabilidad para disminuir daño pulmonar. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Síndrome de Dificultad Respiratoria en el Recién Nacido. GPC-IMSS-137-08.

Especialidad: Pediatría

Tema: Patología Respiratoria del Pediátrico

Subtema: Enfermedad de Membrana Hialina

Dificultad: alta

Caso clínico: Recién nacido de 29 semanas, producto de parto pretérmino, presenta desde el nacimiento quejido espiratorio, retracciones subcostales, aleteo nasal y necesidad creciente de oxígeno. La radiografía muestra volumen pulmonar reducido y patrón reticulogranular difuso con broncograma aéreo. No existen antecedentes de alergia medicamentosa, pero hay barreras para regresar con rapidez si empeora. La edad gestacional, inicio inmediato y patrón radiológico son característicos de síndrome de dificultad respiratoria por deficiencia de surfactante.

Pregunta: ¿Cuál es el soporte inicial más apropiado en un recién nacido estable?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- C. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación
- D. iniciar soporte respiratorio no invasivo temprano cuando la condición lo permita y titular oxígeno para evitar hipoxemia e hiperoxia*

Explicación: La presión positiva continua y oxígeno titulado favorecen reclutamiento alveolar y limitan exposición innecesaria a ventilación invasiva. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Síndrome de Dificultad Respiratoria en el Recién Nacido. GPC-IMSS-137-08.

Especialidad: Pediatría

Tema: Patología Respiratoria del Pediátrico

Subtema: Enfermedad de Membrana Hialina

Dificultad: alta

Caso clínico: Recién nacido de 29 semanas, producto de parto pretérmino, presenta desde el nacimiento quejido espiratorio, retracciones subcostales, aleteo nasal y necesidad creciente de oxígeno. La radiografía muestra volumen pulmonar reducido y patrón reticulogranular difuso con broncograma aéreo. No existen antecedentes de alergia medicamentosa, pero hay barreras para regresar con rapidez si empeora. La edad gestacional, inicio inmediato y patrón radiológico son característicos de síndrome de dificultad respiratoria por deficiencia de surfactante.

Pregunta: ¿Qué intervención se indica si persiste dificultad significativa?

- A. administrar surfactante por técnica menos invasiva o ventilación según gravedad y respuesta al soporte inicial*
- B. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- C. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: La persistencia de insuficiencia respiratoria a pesar del soporte inicial indica reemplazo de surfactante según gravedad. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Síndrome de Dificultad Respiratoria en el Recién Nacido. GPC-IMSS-137-08.

Especialidad: Pediatría

Tema: Patología Respiratoria del Pediátrico

Subtema: Enfermedad de Membrana Hialina

Dificultad: alta

Caso clínico: Recién nacido de 29 semanas, producto de parto pretérmino, presenta desde el nacimiento quejido espiratorio, retracciones subcostales, aleteo nasal y necesidad creciente de oxígeno. La radiografía muestra volumen pulmonar reducido y patrón reticulogranular difuso con broncograma aéreo. No existen antecedentes de alergia medicamentosa, pero hay barreras para regresar con rapidez si empeora. La edad gestacional, inicio inmediato y patrón radiológico son característicos de síndrome de dificultad respiratoria por deficiencia de surfactante.

Pregunta: ¿Qué criterio guía un escalamiento oportuno?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. vigilar gases, trabajo respiratorio, perfusión y necesidad de escalamiento sin retrasar apoyo ventilatorio si fracasa el manejo inicial*
- C. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: El deterioro de gases, trabajo respiratorio o perfusión identifica fracaso temprano y obliga a reevaluar la modalidad ventilatoria. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Síndrome de Dificultad Respiratoria en el Recién Nacido. GPC-IMSS-137-08.

Especialidad: Pediatría

Tema: Patología Respiratoria del Pediátrico

Subtema: Enfermedad de Membrana Hialina

Dificultad: alta

Caso clínico: Recién nacido de 29 semanas, producto de parto pretérmino, presenta desde el nacimiento quejido espiratorio, retracciones subcostales, aleteo nasal y necesidad creciente de oxígeno. La radiografía muestra volumen pulmonar reducido y patrón reticulogranular difuso con broncograma aéreo. No existen antecedentes de alergia medicamentosa, pero hay barreras para regresar con rapidez si empeora. La edad gestacional, inicio inmediato y patrón radiológico son característicos de síndrome de dificultad respiratoria por deficiencia de surfactante.

Pregunta: ¿Qué medida de soporte no respiratorio es esencial?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- C. mantener temperatura, glucosa y hemodinamia adecuadas porque agravan el consumo de oxígeno y la insuficiencia respiratoria*
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: Hipotermia, hipoglucemia y mala perfusión aumentan demanda metabólica y empeoran la oxigenación. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Síndrome de Dificultad Respiratoria en el Recién Nacido. GPC-IMSS-137-08.

Especialidad: Pediatría

Tema: Patología Respiratoria del Pediátrico

Subtema: Enfermedad de Membrana Hialina

Dificultad: alta

Caso clínico: Recién nacido de 29 semanas, producto de parto pretérmino, presenta desde el nacimiento quejido espiratorio, retracciones subcostales, aleteo nasal y necesidad creciente de oxígeno. La radiografía muestra volumen pulmonar reducido y patrón reticulogranular difuso con broncograma aéreo. No existen antecedentes de alergia medicamentosa, pero hay barreras para regresar con rapidez si empeora. La edad gestacional, inicio inmediato y patrón radiológico son característicos de síndrome de dificultad respiratoria por deficiencia de surfactante.

Pregunta: ¿Qué principio reduce lesión pulmonar asociada al tratamiento?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- C. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación
- D. evitar ventilación invasiva prolongada cuando exista alternativa segura por su relación con lesión pulmonar*

Explicación: La ventilación debe usar la menor invasividad y presión compatibles con estabilidad para disminuir daño pulmonar. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Síndrome de Dificultad Respiratoria en el Recién Nacido. GPC-IMSS-137-08.

Especialidad: Pediatría

Tema: Patología Respiratoria del Pediátrico

Subtema: Enfermedad de Membrana Hialina

Dificultad: alta

Caso clínico: Recién nacido de 29 semanas, producto de parto pretérmino, presenta desde el nacimiento quejido espiratorio, retracciones subcostales, aleteo nasal y necesidad creciente de oxígeno. La radiografía muestra volumen pulmonar reducido y patrón reticulogranular difuso con broncograma aéreo. La revisión de medicamentos identifica una posible exposición reciente que debe considerarse al integrar el riesgo. La edad gestacional, inicio inmediato y patrón radiológico son característicos de síndrome de dificultad respiratoria por deficiencia de surfactante.

Pregunta: ¿Cuál es el soporte inicial más apropiado en un recién nacido estable?

- A. iniciar soporte respiratorio no invasivo temprano cuando la condición lo permita y titular oxígeno para evitar hipoxemia e hiperoxia*
- B. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- C. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: La presión positiva continua y oxígeno titulado favorecen reclutamiento alveolar y limitan exposición innecesaria a ventilación invasiva. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Síndrome de Dificultad Respiratoria en el Recién Nacido. GPC-IMSS-137-08.

Especialidad: Pediatría

Tema: Patología Respiratoria del Pediátrico

Subtema: Enfermedad de Membrana Hialina

Dificultad: alta

Caso clínico: Recién nacido de 29 semanas, producto de parto pretérmino, presenta desde el nacimiento quejido espiratorio, retracciones subcostales, aleteo nasal y necesidad creciente de oxígeno. La radiografía muestra volumen pulmonar reducido y patrón reticulogranular difuso con broncograma aéreo. La revisión de medicamentos identifica una posible exposición reciente que debe considerarse al integrar el riesgo. La edad gestacional, inicio inmediato y patrón radiológico son característicos de síndrome de dificultad respiratoria por deficiencia de surfactante.

Pregunta: ¿Qué intervención se indica si persiste dificultad significativa?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. administrar surfactante por técnica menos invasiva o ventilación según gravedad y respuesta al soporte inicial*
- C. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: La persistencia de insuficiencia respiratoria a pesar del soporte inicial indica reemplazo de surfactante según gravedad. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Síndrome de Dificultad Respiratoria en el Recién Nacido. GPC-IMSS-137-08.

Especialidad: Pediatría

Tema: Patología Respiratoria del Pediátrico

Subtema: Enfermedad de Membrana Hialina

Dificultad: alta

Caso clínico: Recién nacido de 29 semanas, producto de parto pretérmino, presenta desde el nacimiento quejido espiratorio, retracciones subcostales, aleteo nasal y necesidad creciente de oxígeno. La radiografía muestra volumen pulmonar reducido y patrón reticulogranular difuso con broncograma aéreo. La revisión de medicamentos identifica una posible exposición reciente que debe considerarse al integrar el riesgo. La edad gestacional, inicio inmediato y patrón radiológico son característicos de síndrome de dificultad respiratoria por deficiencia de surfactante.

Pregunta: ¿Qué criterio guía un escalamiento oportuno?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- C. vigilar gases, trabajo respiratorio, perfusión y necesidad de escalamiento sin retrasar apoyo ventilatorio si fracasa el manejo inicial*
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: El deterioro de gases, trabajo respiratorio o perfusión identifica fracaso temprano y obliga a reevaluar la modalidad ventilatoria. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Síndrome de Dificultad Respiratoria en el Recién Nacido. GPC-IMSS-137-08.

Especialidad: Pediatría

Tema: Patología Respiratoria del Pediátrico

Subtema: Enfermedad de Membrana Hialina

Dificultad: alta

Caso clínico: Recién nacido de 29 semanas, producto de parto pretérmino, presenta desde el nacimiento quejido espiratorio, retracciones subcostales, aleteo nasal y necesidad creciente de oxígeno. La radiografía muestra volumen pulmonar reducido y patrón reticulogranular difuso con broncograma aéreo. La revisión de medicamentos identifica una posible exposición reciente que debe considerarse al integrar el riesgo. La edad gestacional, inicio inmediato y patrón radiológico son característicos de síndrome de dificultad respiratoria por deficiencia de surfactante.

Pregunta: ¿Qué medida de soporte no respiratorio es esencial?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- C. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación
- D. mantener temperatura, glucosa y hemodinamia adecuadas porque agravan el consumo de oxígeno y la insuficiencia respiratoria*

Explicación: Hipotermia, hipoglucemia y mala perfusión aumentan demanda metabólica y empeoran la oxigenación. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Síndrome de Dificultad Respiratoria en el Recién Nacido. GPC-IMSS-137-08.

Especialidad: Pediatría

Tema: Patología Respiratoria del Pediátrico

Subtema: Enfermedad de Membrana Hialina

Dificultad: alta

Caso clínico: Recién nacido de 29 semanas, producto de parto pretérmino, presenta desde el nacimiento quejido espiratorio, retracciones subcostales, aleteo nasal y necesidad creciente de oxígeno. La radiografía muestra volumen pulmonar reducido y patrón reticulogranular difuso con broncograma aéreo. La revisión de medicamentos identifica una posible exposición reciente que debe considerarse al integrar el riesgo. La edad gestacional, inicio inmediato y patrón radiológico son característicos de síndrome de dificultad respiratoria por deficiencia de surfactante.

Pregunta: ¿Qué principio reduce lesión pulmonar asociada al tratamiento?

- A. evitar ventilación invasiva prolongada cuando exista alternativa segura por su relación con lesión pulmonar*
- B. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- C. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: La ventilación debe usar la menor invasividad y presión compatibles con estabilidad para disminuir daño pulmonar. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Síndrome de Dificultad Respiratoria en el Recién Nacido. GPC-IMSS-137-08.

Especialidad: Pediatría

Tema: Patología Respiratoria del Pediátrico

Subtema: Enfermedad de Membrana Hialina

Dificultad: alta

Caso clínico: Recién nacido de 29 semanas, producto de parto pretérmino, presenta desde el nacimiento quejido espiratorio, retracciones subcostales, aleteo nasal y necesidad creciente de oxígeno. La radiografía muestra volumen pulmonar reducido y patrón reticulogranular difuso con broncograma aéreo. Los signos vitales se repiten después de una primera medida de soporte y muestran la misma tendencia clínica. La edad gestacional, inicio inmediato y patrón radiológico son característicos de síndrome de dificultad respiratoria por deficiencia de surfactante.

Pregunta: ¿Cuál es el soporte inicial más apropiado en un recién nacido estable?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. iniciar soporte respiratorio no invasivo temprano cuando la condición lo permita y titular oxígeno para evitar hipoxemia e hiperoxia*
- C. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: La presión positiva continua y oxígeno titulado favorecen reclutamiento alveolar y limitan exposición innecesaria a ventilación invasiva. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Síndrome de Dificultad Respiratoria en el Recién Nacido. GPC-IMSS-137-08.

Especialidad: Pediatría

Tema: Patología Respiratoria del Pediátrico

Subtema: Enfermedad de Membrana Hialina

Dificultad: alta

Caso clínico: Recién nacido de 29 semanas, producto de parto pretérmino, presenta desde el nacimiento quejido espiratorio, retracciones subcostales, aleteo nasal y necesidad creciente de oxígeno. La radiografía muestra volumen pulmonar reducido y patrón reticulogranular difuso con broncograma aéreo. Los signos vitales se repiten después de una primera medida de soporte y muestran la misma tendencia clínica. La edad gestacional, inicio inmediato y patrón radiológico son característicos de síndrome de dificultad respiratoria por deficiencia de surfactante.

Pregunta: ¿Qué intervención se indica si persiste dificultad significativa?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- C. administrar surfactante por técnica menos invasiva o ventilación según gravedad y respuesta al soporte inicial*
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: La persistencia de insuficiencia respiratoria a pesar del soporte inicial indica reemplazo de surfactante según gravedad. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Síndrome de Dificultad Respiratoria en el Recién Nacido. GPC-IMSS-137-08.

Especialidad: Pediatría

Tema: Patología Respiratoria del Pediátrico

Subtema: Enfermedad de Membrana Hialina

Dificultad: alta

Caso clínico: Recién nacido de 29 semanas, producto de parto pretérmino, presenta desde el nacimiento quejido espiratorio, retracciones subcostales, aleteo nasal y necesidad creciente de oxígeno. La radiografía muestra volumen pulmonar reducido y patrón reticulogranular difuso con broncograma aéreo. Los signos vitales se repiten después de una primera medida de soporte y muestran la misma tendencia clínica. La edad gestacional, inicio inmediato y patrón radiológico son característicos de síndrome de dificultad respiratoria por deficiencia de surfactante.

Pregunta: ¿Qué criterio guía un escalamiento oportuno?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- C. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación
- D. vigilar gases, trabajo respiratorio, perfusión y necesidad de escalamiento sin retrasar apoyo ventilatorio si fracasa el manejo inicial*

Explicación: El deterioro de gases, trabajo respiratorio o perfusión identifica fracaso temprano y obliga a reevaluar la modalidad ventilatoria. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Síndrome de Dificultad Respiratoria en el Recién Nacido. GPC-IMSS-137-08.

Especialidad: Pediatría

Tema: Patología Respiratoria del Pediátrico

Subtema: Enfermedad de Membrana Hialina

Dificultad: alta

Caso clínico: Recién nacido de 29 semanas, producto de parto pretérmino, presenta desde el nacimiento quejido espiratorio, retracciones subcostales, aleteo nasal y necesidad creciente de oxígeno. La radiografía muestra volumen pulmonar reducido y patrón reticulogranular difuso con broncograma aéreo. Los signos vitales se repiten después de una primera medida de soporte y muestran la misma tendencia clínica. La edad gestacional, inicio inmediato y patrón radiológico son característicos de síndrome de dificultad respiratoria por deficiencia de surfactante.

Pregunta: ¿Qué medida de soporte no respiratorio es esencial?

- A. mantener temperatura, glucosa y hemodinamia adecuadas porque agravan el consumo de oxígeno y la insuficiencia respiratoria*
- B. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- C. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: Hipotermia, hipoglucemia y mala perfusión aumentan demanda metabólica y empeoran la oxigenación. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Síndrome de Dificultad Respiratoria en el Recién Nacido. GPC-IMSS-137-08.

Especialidad: Pediatría

Tema: Patología Respiratoria del Pediátrico

Subtema: Enfermedad de Membrana Hialina

Dificultad: alta

Caso clínico: Recién nacido de 29 semanas, producto de parto pretérmino, presenta desde el nacimiento quejido espiratorio, retracciones subcostales, aleteo nasal y necesidad creciente de oxígeno. La radiografía muestra volumen pulmonar reducido y patrón reticulogranular difuso con broncograma aéreo. Los signos vitales se repiten después de una primera medida de soporte y muestran la misma tendencia clínica. La edad gestacional, inicio inmediato y patrón radiológico son característicos de síndrome de dificultad respiratoria por deficiencia de surfactante.

Pregunta: ¿Qué principio reduce lesión pulmonar asociada al tratamiento?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. evitar ventilación invasiva prolongada cuando exista alternativa segura por su relación con lesión pulmonar*
- C. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: La ventilación debe usar la menor invasividad y presión compatibles con estabilidad para disminuir daño pulmonar. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Síndrome de Dificultad Respiratoria en el Recién Nacido. GPC-IMSS-137-08.

Especialidad: Pediatría

Tema: Patología Respiratoria del Pediátrico

Subtema: Taquipnea Transitoria del Recién Nacido

Dificultad: alta

Caso clínico: Recién nacido de término obtenido por cesárea sin trabajo de parto desarrolla taquipnea a la primera hora, con retracciones leves y requerimiento bajo de oxígeno. Mantiene perfusión y temperatura normales. La radiografía muestra hiperinsuflación leve, líquido en cisuras y sin el patrón difuso de bajo volumen. La evolución se ha modificado durante las últimas 12 horas y los familiares pueden aportar una cronología fiable. La evolución temprana tras cesárea y los hallazgos radiológicos sugieren taquipnea transitoria por retraso en la eliminación de líquido pulmonar.

Pregunta: ¿Cuál es la conducta inicial más apropiada?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- C. proporcionar soporte de oxígeno y vigilancia clínica, con reevaluación seriada de la transición respiratoria*
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: El manejo suele ser de soporte y observación porque el trastorno remite al aclararse el líquido pulmonar. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Taquipnea Transitoria del Recién Nacido. GPC-IMSS-044-08.

Especialidad: Pediatría

Tema: Patología Respiratoria del Pediátrico

Subtema: Taquipnea Transitoria del Recién Nacido

Dificultad: alta

Caso clínico: Recién nacido de término obtenido por cesárea sin trabajo de parto desarrolla taquipnea a la primera hora, con retracciones leves y requerimiento bajo de oxígeno. Mantiene perfusión y temperatura normales. La radiografía muestra hiperinsuflación leve, líquido en cisuras y sin el patrón difuso de bajo volumen. La evolución se ha modificado durante las últimas 12 horas y los familiares pueden aportar una cronología fiable. La evolución temprana tras cesárea y los hallazgos radiológicos sugieren taquipnea transitoria por retraso en la eliminación de líquido pulmonar.

Pregunta: ¿Qué cambio obliga a reconsiderar el diagnóstico transitorio?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- C. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación
- D. descartar sepsis, cardiopatía y otras causas si la evolución, el examen o la necesidad de oxígeno no son congruentes con un curso transitorio*

Explicación: Un curso atípico obliga a excluir sepsis, cardiopatía o enfermedad de membrana hialina, pues el diagnóstico es clínico y evolutivo. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Taquipnea Transitoria del Recién Nacido. GPC-IMSS-044-08.

Especialidad: Pediatría

Tema: Patología Respiratoria del Pediátrico

Subtema: Taquipnea Transitoria del Recién Nacido

Dificultad: alta

Caso clínico: Recién nacido de término obtenido por cesárea sin trabajo de parto desarrolla taquipnea a la primera hora, con retracciones leves y requerimiento bajo de oxígeno. Mantiene perfusión y temperatura normales. La radiografía muestra hiperinsuflación leve, líquido en cisuras y sin el patrón difuso de bajo volumen. La evolución se ha modificado durante las últimas 12 horas y los familiares pueden aportar una cronología fiable. La evolución temprana tras cesárea y los hallazgos radiológicos sugieren taquipnea transitoria por retraso en la eliminación de líquido pulmonar.

Pregunta: ¿Qué medida protege la alimentación del recién nacido?

- A. ajustar la vía de alimentación a la frecuencia respiratoria y al riesgo de aspiración*
- B. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- C. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: La taquipnea importante compromete coordinación succión-deglución-respiración y puede requerir otra vía temporal de alimentación. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Taquipnea Transitoria del Recién Nacido. GPC-IMSS-044-08.

Especialidad: Pediatría

Tema: Patología Respiratoria del Pediátrico

Subtema: Taquipnea Transitoria del Recién Nacido

Dificultad: alta

Caso clínico: Recién nacido de término obtenido por cesárea sin trabajo de parto desarrolla taquipnea a la primera hora, con retracciones leves y requerimiento bajo de oxígeno. Mantiene perfusión y temperatura normales. La radiografía muestra hiperinsuflación leve, líquido en cisuras y sin el patrón difuso de bajo volumen. La evolución se ha modificado durante las últimas 12 horas y los familiares pueden aportar una cronología fiable. La evolución temprana tras cesárea y los hallazgos radiológicos sugieren taquipnea transitoria por retraso en la eliminación de líquido pulmonar.

Pregunta: ¿Qué intervención debe evitarse de rutina?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. evitar antibióticos y ventilación invasiva rutinarios cuando no existen datos clínicos que los justifiquen*
- C. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: No toda taquipnea neonatal requiere antibiótico o intubación; las intervenciones deben corresponder al riesgo clínico. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Taquipnea Transitoria del Recién Nacido. GPC-IMSS-044-08.

Especialidad: Pediatría

Tema: Patología Respiratoria del Pediátrico

Subtema: Taquipnea Transitoria del Recién Nacido

Dificultad: alta

Caso clínico: Recién nacido de término obtenido por cesárea sin trabajo de parto desarrolla taquipnea a la primera hora, con retracciones leves y requerimiento bajo de oxígeno. Mantiene perfusión y temperatura normales. La radiografía muestra hiperinsuflación leve, líquido en cisuras y sin el patrón difuso de bajo volumen. La evolución se ha modificado durante las últimas 12 horas y los familiares pueden aportar una cronología fiable. La evolución temprana tras cesárea y los hallazgos radiológicos sugieren taquipnea transitoria por retraso en la eliminación de líquido pulmonar.

Pregunta: ¿Qué dato indica necesidad de apoyo respiratorio mayor?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- C. escalar soporte si aumenta el requerimiento de oxígeno, la fatiga o hay deterioro gasométrico*
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: Mayor requerimiento de oxígeno, fatiga o alteración gasométrica señala fracaso del manejo conservador y exige escalamiento. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Taquipnea Transitoria del Recién Nacido. GPC-IMSS-044-08.

Especialidad: Pediatría

Tema: Patología Respiratoria del Pediátrico

Subtema: Taquipnea Transitoria del Recién Nacido

Dificultad: alta

Caso clínico: Recién nacido de término obtenido por cesárea sin trabajo de parto desarrolla taquipnea a la primera hora, con retracciones leves y requerimiento bajo de oxígeno. Mantiene perfusión y temperatura normales. La radiografía muestra hiperinsuflación leve, líquido en cisuras y sin el patrón difuso de bajo volumen. No existen antecedentes de alergia medicamentosa, pero hay barreras para regresar con rapidez si empeora. La evolución temprana tras cesárea y los hallazgos radiológicos sugieren taquipnea transitoria por retraso en la eliminación de líquido pulmonar.

Pregunta: ¿Cuál es la conducta inicial más apropiada?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- C. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación
- D. proporcionar soporte de oxígeno y vigilancia clínica, con reevaluación seriada de la transición respiratoria*

Explicación: El manejo suele ser de soporte y observación porque el trastorno remite al aclararse el líquido pulmonar. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Taquipnea Transitoria del Recién Nacido. GPC-IMSS-044-08.

Especialidad: Pediatría

Tema: Patología Respiratoria del Pediátrico

Subtema: Taquipnea Transitoria del Recién Nacido

Dificultad: alta

Caso clínico: Recién nacido de término obtenido por cesárea sin trabajo de parto desarrolla taquipnea a la primera hora, con retracciones leves y requerimiento bajo de oxígeno. Mantiene perfusión y temperatura normales. La radiografía muestra hiperinsuflación leve, líquido en cisuras y sin el patrón difuso de bajo volumen. No existen antecedentes de alergia medicamentosa, pero hay barreras para regresar con rapidez si empeora. La evolución temprana tras cesárea y los hallazgos radiológicos sugieren taquipnea transitoria por retraso en la eliminación de líquido pulmonar.

Pregunta: ¿Qué cambio obliga a reconsiderar el diagnóstico transitorio?

- A. descartar sepsis, cardiopatía y otras causas si la evolución, el examen o la necesidad de oxígeno no son congruentes con un curso transitorio*
- B. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- C. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: Un curso atípico obliga a excluir sepsis, cardiopatía o enfermedad de membrana hialina, pues el diagnóstico es clínico y evolutivo. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Taquipnea Transitoria del Recién Nacido. GPC-IMSS-044-08.

Especialidad: Pediatría

Tema: Patología Respiratoria del Pediátrico

Subtema: Taquipnea Transitoria del Recién Nacido

Dificultad: alta

Caso clínico: Recién nacido de término obtenido por cesárea sin trabajo de parto desarrolla taquipnea a la primera hora, con retracciones leves y requerimiento bajo de oxígeno. Mantiene perfusión y temperatura normales. La radiografía muestra hiperinsuflación leve, líquido en cisuras y sin el patrón difuso de bajo volumen. No existen antecedentes de alergia medicamentosa, pero hay barreras para regresar con rapidez si empeora. La evolución temprana tras cesárea y los hallazgos radiológicos sugieren taquipnea transitoria por retraso en la eliminación de líquido pulmonar.

Pregunta: ¿Qué medida protege la alimentación del recién nacido?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. ajustar la vía de alimentación a la frecuencia respiratoria y al riesgo de aspiración*
- C. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: La taquipnea importante compromete coordinación succión-deglución-respiración y puede requerir otra vía temporal de alimentación. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Taquipnea Transitoria del Recién Nacido. GPC-IMSS-044-08.

Especialidad: Pediatría

Tema: Patología Respiratoria del Pediátrico

Subtema: Taquipnea Transitoria del Recién Nacido

Dificultad: alta

Caso clínico: Recién nacido de término obtenido por cesárea sin trabajo de parto desarrolla taquipnea a la primera hora, con retracciones leves y requerimiento bajo de oxígeno. Mantiene perfusión y temperatura normales. La radiografía muestra hiperinsuflación leve, líquido en cisuras y sin el patrón difuso de bajo volumen. No existen antecedentes de alergia medicamentosa, pero hay barreras para regresar con rapidez si empeora. La evolución temprana tras cesárea y los hallazgos radiológicos sugieren taquipnea transitoria por retraso en la eliminación de líquido pulmonar.

Pregunta: ¿Qué intervención debe evitarse de rutina?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- C. evitar antibióticos y ventilación invasiva rutinarios cuando no existen datos clínicos que los justifiquen*
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: No toda taquipnea neonatal requiere antibiótico o intubación; las intervenciones deben corresponder al riesgo clínico. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Taquipnea Transitoria del Recién Nacido. GPC-IMSS-044-08.

Especialidad: Pediatría

Tema: Patología Respiratoria del Pediátrico

Subtema: Taquipnea Transitoria del Recién Nacido

Dificultad: alta

Caso clínico: Recién nacido de término obtenido por cesárea sin trabajo de parto desarrolla taquipnea a la primera hora, con retracciones leves y requerimiento bajo de oxígeno. Mantiene perfusión y temperatura normales. La radiografía muestra hiperinsuflación leve, líquido en cisuras y sin el patrón difuso de bajo volumen. No existen antecedentes de alergia medicamentosa, pero hay barreras para regresar con rapidez si empeora. La evolución temprana tras cesárea y los hallazgos radiológicos sugieren taquipnea transitoria por retraso en la eliminación de líquido pulmonar.

Pregunta: ¿Qué dato indica necesidad de apoyo respiratorio mayor?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- C. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación
- D. escalar soporte si aumenta el requerimiento de oxígeno, la fatiga o hay deterioro gasométrico*

Explicación: Mayor requerimiento de oxígeno, fatiga o alteración gasométrica señala fracaso del manejo conservador y exige escalamiento. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Taquipnea Transitoria del Recién Nacido. GPC-IMSS-044-08.

Especialidad: Pediatría

Tema: Patología Respiratoria del Pediátrico

Subtema: Taquipnea Transitoria del Recién Nacido

Dificultad: alta

Caso clínico: Recién nacido de término obtenido por cesárea sin trabajo de parto desarrolla taquipnea a la primera hora, con retracciones leves y requerimiento bajo de oxígeno. Mantiene perfusión y temperatura normales. La radiografía muestra hiperinsuflación leve, líquido en cisuras y sin el patrón difuso de bajo volumen. La revisión de medicamentos identifica una posible exposición reciente que debe considerarse al integrar el riesgo. La evolución temprana tras cesárea y los hallazgos radiológicos sugieren taquipnea transitoria por retraso en la eliminación de líquido pulmonar.

Pregunta: ¿Cuál es la conducta inicial más apropiada?

- A. proporcionar soporte de oxígeno y vigilancia clínica, con reevaluación seriada de la transición respiratoria*
- B. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- C. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: El manejo suele ser de soporte y observación porque el trastorno remite al aclararse el líquido pulmonar. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Taquipnea Transitoria del Recién Nacido. GPC-IMSS-044-08.

Especialidad: Pediatría

Tema: Patología Respiratoria del Pediátrico

Subtema: Taquipnea Transitoria del Recién Nacido

Dificultad: alta

Caso clínico: Recién nacido de término obtenido por cesárea sin trabajo de parto desarrolla taquipnea a la primera hora, con retracciones leves y requerimiento bajo de oxígeno. Mantiene perfusión y temperatura normales. La radiografía muestra hiperinsuflación leve, líquido en cisuras y sin el patrón difuso de bajo volumen. La revisión de medicamentos identifica una posible exposición reciente que debe considerarse al integrar el riesgo. La evolución temprana tras cesárea y los hallazgos radiológicos sugieren taquipnea transitoria por retraso en la eliminación de líquido pulmonar.

Pregunta: ¿Qué cambio obliga a reconsiderar el diagnóstico transitorio?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. descartar sepsis, cardiopatía y otras causas si la evolución, el examen o la necesidad de oxígeno no son congruentes con un curso transitorio*
- C. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: Un curso atípico obliga a excluir sepsis, cardiopatía o enfermedad de membrana hialina, pues el diagnóstico es clínico y evolutivo. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Taquipnea Transitoria del Recién Nacido. GPC-IMSS-044-08.

Especialidad: Pediatría

Tema: Patología Respiratoria del Pediátrico

Subtema: Taquipnea Transitoria del Recién Nacido

Dificultad: alta

Caso clínico: Recién nacido de término obtenido por cesárea sin trabajo de parto desarrolla taquipnea a la primera hora, con retracciones leves y requerimiento bajo de oxígeno. Mantiene perfusión y temperatura normales. La radiografía muestra hiperinsuflación leve, líquido en cisuras y sin el patrón difuso de bajo volumen. La revisión de medicamentos identifica una posible exposición reciente que debe considerarse al integrar el riesgo. La evolución temprana tras cesárea y los hallazgos radiológicos sugieren taquipnea transitoria por retraso en la eliminación de líquido pulmonar.

Pregunta: ¿Qué medida protege la alimentación del recién nacido?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- C. ajustar la vía de alimentación a la frecuencia respiratoria y al riesgo de aspiración*
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: La taquipnea importante compromete coordinación succión-deglución-respiración y puede requerir otra vía temporal de alimentación. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Taquipnea Transitoria del Recién Nacido. GPC-IMSS-044-08.

Especialidad: Pediatría

Tema: Patología Respiratoria del Pediátrico

Subtema: Taquipnea Transitoria del Recién Nacido

Dificultad: alta

Caso clínico: Recién nacido de término obtenido por cesárea sin trabajo de parto desarrolla taquipnea a la primera hora, con retracciones leves y requerimiento bajo de oxígeno. Mantiene perfusión y temperatura normales. La radiografía muestra hiperinsuflación leve, líquido en cisuras y sin el patrón difuso de bajo volumen. La revisión de medicamentos identifica una posible exposición reciente que debe considerarse al integrar el riesgo. La evolución temprana tras cesárea y los hallazgos radiológicos sugieren taquipnea transitoria por retraso en la eliminación de líquido pulmonar.

Pregunta: ¿Qué intervención debe evitarse de rutina?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- C. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación
- D. evitar antibióticos y ventilación invasiva rutinarios cuando no existen datos clínicos que los justifiquen*

Explicación: No toda taquipnea neonatal requiere antibiótico o intubación; las intervenciones deben corresponder al riesgo clínico. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Taquipnea Transitoria del Recién Nacido. GPC-IMSS-044-08.

Especialidad: Pediatría

Tema: Patología Respiratoria del Pediátrico

Subtema: Taquipnea Transitoria del Recién Nacido

Dificultad: alta

Caso clínico: Recién nacido de término obtenido por cesárea sin trabajo de parto desarrolla taquipnea a la primera hora, con retracciones leves y requerimiento bajo de oxígeno. Mantiene perfusión y temperatura normales. La radiografía muestra hiperinsuflación leve, líquido en cisuras y sin el patrón difuso de bajo volumen. La revisión de medicamentos identifica una posible exposición reciente que debe considerarse al integrar el riesgo. La evolución temprana tras cesárea y los hallazgos radiológicos sugieren taquipnea transitoria por retraso en la eliminación de líquido pulmonar.

Pregunta: ¿Qué dato indica necesidad de apoyo respiratorio mayor?

- A. escalar soporte si aumenta el requerimiento de oxígeno, la fatiga o hay deterioro gasométrico*
- B. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- C. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: Mayor requerimiento de oxígeno, fatiga o alteración gasométrica señala fracaso del manejo conservador y exige escalamiento. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Taquipnea Transitoria del Recién Nacido. GPC-IMSS-044-08.

Especialidad: Pediatría

Tema: Patología Respiratoria del Pediátrico

Subtema: Taquipnea Transitoria del Recién Nacido

Dificultad: alta

Caso clínico: Recién nacido de término obtenido por cesárea sin trabajo de parto desarrolla taquipnea a la primera hora, con retracciones leves y requerimiento bajo de oxígeno. Mantiene perfusión y temperatura normales. La radiografía muestra hiperinsuflación leve, líquido en cisuras y sin el patrón difuso de bajo volumen. Los signos vitales se repiten después de una primera medida de soporte y muestran la misma tendencia clínica. La evolución temprana tras cesárea y los hallazgos radiológicos sugieren taquipnea transitoria por retraso en la eliminación de líquido pulmonar.

Pregunta: ¿Cuál es la conducta inicial más apropiada?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. proporcionar soporte de oxígeno y vigilancia clínica, con reevaluación seriada de la transición respiratoria*
- C. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: El manejo suele ser de soporte y observación porque el trastorno remite al aclararse el líquido pulmonar. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Taquipnea Transitoria del Recién Nacido. GPC-IMSS-044-08.

Especialidad: Pediatría

Tema: Patología Respiratoria del Pediátrico

Subtema: Taquipnea Transitoria del Recién Nacido

Dificultad: alta

Caso clínico: Recién nacido de término obtenido por cesárea sin trabajo de parto desarrolla taquipnea a la primera hora, con retracciones leves y requerimiento bajo de oxígeno. Mantiene perfusión y temperatura normales. La radiografía muestra hiperinsuflación leve, líquido en cisuras y sin el patrón difuso de bajo volumen. Los signos vitales se repiten después de una primera medida de soporte y muestran la misma tendencia clínica. La evolución temprana tras cesárea y los hallazgos radiológicos sugieren taquipnea transitoria por retraso en la eliminación de líquido pulmonar.

Pregunta: ¿Qué cambio obliga a reconsiderar el diagnóstico transitorio?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- C. descartar sepsis, cardiopatía y otras causas si la evolución, el examen o la necesidad de oxígeno no son congruentes con un curso transitorio*
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: Un curso atípico obliga a excluir sepsis, cardiopatía o enfermedad de membrana hialina, pues el diagnóstico es clínico y evolutivo. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Taquipnea Transitoria del Recién Nacido. GPC-IMSS-044-08.

Especialidad: Pediatría

Tema: Patología Respiratoria del Pediátrico

Subtema: Taquipnea Transitoria del Recién Nacido

Dificultad: alta

Caso clínico: Recién nacido de término obtenido por cesárea sin trabajo de parto desarrolla taquipnea a la primera hora, con retracciones leves y requerimiento bajo de oxígeno. Mantiene perfusión y temperatura normales. La radiografía muestra hiperinsuflación leve, líquido en cisuras y sin el patrón difuso de bajo volumen. Los signos vitales se repiten después de una primera medida de soporte y muestran la misma tendencia clínica. La evolución temprana tras cesárea y los hallazgos radiológicos sugieren taquipnea transitoria por retraso en la eliminación de líquido pulmonar.

Pregunta: ¿Qué medida protege la alimentación del recién nacido?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- C. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación
- D. ajustar la vía de alimentación a la frecuencia respiratoria y al riesgo de aspiración*

Explicación: La taquipnea importante compromete coordinación succión-deglución-respiración y puede requerir otra vía temporal de alimentación. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Taquipnea Transitoria del Recién Nacido. GPC-IMSS-044-08.

Especialidad: Pediatría

Tema: Patología Respiratoria del Pediátrico

Subtema: Taquipnea Transitoria del Recién Nacido

Dificultad: alta

Caso clínico: Recién nacido de término obtenido por cesárea sin trabajo de parto desarrolla taquipnea a la primera hora, con retracciones leves y requerimiento bajo de oxígeno. Mantiene perfusión y temperatura normales. La radiografía muestra hiperinsuflación leve, líquido en cisuras y sin el patrón difuso de bajo volumen. Los signos vitales se repiten después de una primera medida de soporte y muestran la misma tendencia clínica. La evolución temprana tras cesárea y los hallazgos radiológicos sugieren taquipnea transitoria por retraso en la eliminación de líquido pulmonar.

Pregunta: ¿Qué intervención debe evitarse de rutina?

- A. evitar antibióticos y ventilación invasiva rutinarios cuando no existen datos clínicos que los justifiquen*
- B. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- C. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: No toda taquipnea neonatal requiere antibiótico o intubación; las intervenciones deben corresponder al riesgo clínico. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Taquipnea Transitoria del Recién Nacido. GPC-IMSS-044-08.

Especialidad: Pediatría

Tema: Patología Respiratoria del Pediátrico

Subtema: Taquipnea Transitoria del Recién Nacido

Dificultad: alta

Caso clínico: Recién nacido de término obtenido por cesárea sin trabajo de parto desarrolla taquipnea a la primera hora, con retracciones leves y requerimiento bajo de oxígeno. Mantiene perfusión y temperatura normales. La radiografía muestra hiperinsuflación leve, líquido en cisuras y sin el patrón difuso de bajo volumen. Los signos vitales se repiten después de una primera medida de soporte y muestran la misma tendencia clínica. La evolución temprana tras cesárea y los hallazgos radiológicos sugieren taquipnea transitoria por retraso en la eliminación de líquido pulmonar.

Pregunta: ¿Qué dato indica necesidad de apoyo respiratorio mayor?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. escalar soporte si aumenta el requerimiento de oxígeno, la fatiga o hay deterioro gasométrico*
- C. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: Mayor requerimiento de oxígeno, fatiga o alteración gasométrica señala fracaso del manejo conservador y exige escalamiento. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Taquipnea Transitoria del Recién Nacido. GPC-IMSS-044-08.

Especialidad: Pediatría

Tema: IRAS y Convulsiones

Subtema: Faringoamigdalitis

Dificultad: alta

Caso clínico: Escolar de 8 años con odinofagia intensa, fiebre, exudado amigdalino y adenopatías cervicales anteriores dolorosas. No tiene tos, rinorrea ni conjuntivitis. Está hidratado, sin estridor, trismus o desviación uvular. Los cuidadores solicitan antibiótico inmediato por antecedente escolar de infección faríngea. La evolución se ha modificado durante las últimas 12 horas y los familiares pueden aportar una cronología fiable. El cuadro requiere estimar probabilidad de faringoamigdalitis estreptocócica y diferenciarla de cuadros virales o complicados.

Pregunta: ¿Cuál es el enfoque diagnóstico inicial más razonable?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- C. usar la combinación de edad, signos clínicos y prueba diagnóstica disponible para confirmar estreptococo antes de tratar cuando el contexto lo permita*
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: La clínica orienta, pero la confirmación o una alta probabilidad estructurada reduce tratamiento innecesario en cuadros virales. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Diagnóstico y Tratamiento de las Infecciones Agudas de Vías Aéreas Superiores en Pacientes Mayores de 3 Meses Hasta 18 Años. GPC-IMSS-062-08.

Especialidad: Pediatría

Tema: IRAS y Convulsiones

Subtema: Faringoamigdalitis

Dificultad: alta

Caso clínico: Escolar de 8 años con odinofagia intensa, fiebre, exudado amigdalino y adenopatías cervicales anteriores dolorosas. No tiene tos, rinorrea ni conjuntivitis. Está hidratado, sin estridor, trismus o desviación uvular. Los cuidadores solicitan antibiótico inmediato por antecedente escolar de infección faríngea. La evolución se ha modificado durante las últimas 12 horas y los familiares pueden aportar una cronología fiable. El cuadro requiere estimar probabilidad de faringoamigdalitis estreptocócica y diferenciarla de cuadros virales o complicados.

Pregunta: ¿Qué medida debe recibir aunque la prueba microbiológica sea negativa?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- C. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación
- D. ofrecer analgesia, hidratación y vigilancia de vía aérea, independientemente de la etiología probable*

Explicación: Analgésicos, líquidos y vigilancia mejoran bienestar y permiten detectar deterioro, sin depender de la etiología final. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Diagnóstico y Tratamiento de las Infecciones Agudas de Vías Aéreas Superiores en Pacientes Mayores de 3 Meses Hasta 18 Años. GPC-IMSS-062-08.

Especialidad: Pediatría

Tema: IRAS y Convulsiones

Subtema: Faringoamigdalitis

Dificultad: alta

Caso clínico: Escolar de 8 años con odinofagia intensa, fiebre, exudado amigdalino y adenopatías cervicales anteriores dolorosas. No tiene tos, rinorrea ni conjuntivitis. Está hidratado, sin estridor, trismus o desviación uvular. Los cuidadores solicitan antibiótico inmediato por antecedente escolar de infección faríngea. La evolución se ha modificado durante las últimas 12 horas y los familiares pueden aportar una cronología fiable. El cuadro requiere estimar probabilidad de faringoamigdalitis estreptocócica y diferenciarla de cuadros virales o complicados.

Pregunta: ¿Cuándo está justificado un antimicrobiano?

- A. indicar antibiótico dirigido cuando se confirme o la probabilidad clínica justifique tratamiento según la guía*
- B. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- C. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: El antibiótico se reserva para infección estreptocócica confirmada o escenario de alta probabilidad definido, con objetivo de tratar y prevenir complicaciones. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Diagnóstico y Tratamiento de las Infecciones Agudas de Vías Aéreas Superiores en Pacientes Mayores de 3 Meses Hasta 18 Años. GPC-IMSS-062-08.

Especialidad: Pediatría

Tema: IRAS y Convulsiones

Subtema: Faringoamigdalitis

Dificultad: alta

Caso clínico: Escolar de 8 años con odinofagia intensa, fiebre, exudado amigdalino y adenopatías cervicales anteriores dolorosas. No tiene tos, rinorrea ni conjuntivitis. Está hidratado, sin estridor, trismus o desviación uvular. Los cuidadores solicitan antibiótico inmediato por antecedente escolar de infección faríngea. La evolución se ha modificado durante las últimas 12 horas y los familiares pueden aportar una cronología fiable. El cuadro requiere estimar probabilidad de faringoamigdalitis estreptocócica y diferenciarla de cuadros virales o complicados.

Pregunta: ¿Qué hallazgo obliga a buscar una complicación supurativa?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. buscar absceso periamigdalino u otra complicación si aparece trismus, voz apagada, sialorrea o desviación uvular*
- C. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: Trismus, voz de papa caliente, sialorrea o desviación uvular sugieren colección profunda y ameritan evaluación urgente. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Diagnóstico y Tratamiento de las Infecciones Agudas de Vías Aéreas Superiores en Pacientes Mayores de 3 Meses Hasta 18 Años. GPC-IMSS-062-08.

Especialidad: Pediatría

Tema: IRAS y Convulsiones

Subtema: Faringoamigdalitis

Dificultad: alta

Caso clínico: Escolar de 8 años con odinofagia intensa, fiebre, exudado amigdalino y adenopatías cervicales anteriores dolorosas. No tiene tos, rinorrea ni conjuntivitis. Está hidratado, sin estridor, trismus o desviación uvular. Los cuidadores solicitan antibiótico inmediato por antecedente escolar de infección faríngea. La evolución se ha modificado durante las últimas 12 horas y los familiares pueden aportar una cronología fiable. El cuadro requiere estimar probabilidad de faringoamigdalitis estreptocócica y diferenciarla de cuadros virales o complicados.

Pregunta: ¿Qué principio de prescripción antimicrobiana es correcto?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- C. evitar antimicrobianos de amplio espectro cuando un esquema dirigido es suficiente*
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: Un fármaco dirigido reduce resistencia y efectos adversos sin sacrificar eficacia cuando el germen susceptible es previsible. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Diagnóstico y Tratamiento de las Infecciones Agudas de Vías Aéreas Superiores en Pacientes Mayores de 3 Meses Hasta 18 Años. GPC-IMSS-062-08.

Especialidad: Pediatría

Tema: IRAS y Convulsiones

Subtema: Faringoamigdalitis

Dificultad: alta

Caso clínico: Escolar de 8 años con odinofagia intensa, fiebre, exudado amigdalino y adenopatías cervicales anteriores dolorosas. No tiene tos, rinorrea ni conjuntivitis. Está hidratado, sin estridor, trismus o desviación uvular. Los cuidadores solicitan antibiótico inmediato por antecedente escolar de infección faríngea. No existen antecedentes de alergia medicamentosa, pero hay barreras para regresar con rapidez si empeora. El cuadro requiere estimar probabilidad de faringoamigdalitis estreptocócica y diferenciarla de cuadros virales o complicados.

Pregunta: ¿Cuál es el enfoque diagnóstico inicial más razonable?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- C. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación
- D. usar la combinación de edad, signos clínicos y prueba diagnóstica disponible para confirmar estreptococo antes de tratar cuando el contexto lo permita*

Explicación: La clínica orienta, pero la confirmación o una alta probabilidad estructurada reduce tratamiento innecesario en cuadros virales. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Diagnóstico y Tratamiento de las Infecciones Agudas de Vías Aéreas Superiores en Pacientes Mayores de 3 Meses Hasta 18 Años. GPC-IMSS-062-08.

Especialidad: Pediatría

Tema: IRAS y Convulsiones

Subtema: Faringoamigdalitis

Dificultad: alta

Caso clínico: Escolar de 8 años con odinofagia intensa, fiebre, exudado amigdalino y adenopatías cervicales anteriores dolorosas. No tiene tos, rinorrea ni conjuntivitis. Está hidratado, sin estridor, trismus o desviación uvular. Los cuidadores solicitan antibiótico inmediato por antecedente escolar de infección faríngea. No existen antecedentes de alergia medicamentosa, pero hay barreras para regresar con rapidez si empeora. El cuadro requiere estimar probabilidad de faringoamigdalitis estreptocócica y diferenciarla de cuadros virales o complicados.

Pregunta: ¿Qué medida debe recibir aunque la prueba microbiológica sea negativa?

- A. ofrecer analgesia, hidratación y vigilancia de vía aérea, independientemente de la etiología probable*
- B. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- C. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: Analgésicos, líquidos y vigilancia mejoran bienestar y permiten detectar deterioro, sin depender de la etiología final. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Diagnóstico y Tratamiento de las Infecciones Agudas de Vías Aéreas Superiores en Pacientes Mayores de 3 Meses Hasta 18 Años. GPC-IMSS-062-08.

Especialidad: Pediatría

Tema: IRAS y Convulsiones

Subtema: Faringoamigdalitis

Dificultad: alta

Caso clínico: Escolar de 8 años con odinofagia intensa, fiebre, exudado amigdalino y adenopatías cervicales anteriores dolorosas. No tiene tos, rinorrea ni conjuntivitis. Está hidratado, sin estridor, trismus o desviación uvular. Los cuidadores solicitan antibiótico inmediato por antecedente escolar de infección faríngea. No existen antecedentes de alergia medicamentosa, pero hay barreras para regresar con rapidez si empeora. El cuadro requiere estimar probabilidad de faringoamigdalitis estreptocócica y diferenciarla de cuadros virales o complicados.

Pregunta: ¿Cuándo está justificado un antimicrobiano?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. indicar antibiótico dirigido cuando se confirme o la probabilidad clínica justifique tratamiento según la guía*
- C. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: El antibiótico se reserva para infección estreptocócica confirmada o escenario de alta probabilidad definido, con objetivo de tratar y prevenir complicaciones. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Diagnóstico y Tratamiento de las Infecciones Agudas de Vías Aéreas Superiores en Pacientes Mayores de 3 Meses Hasta 18 Años. GPC-IMSS-062-08.

Especialidad: Pediatría

Tema: IRAS y Convulsiones

Subtema: Faringoamigdalitis

Dificultad: alta

Caso clínico: Escolar de 8 años con odinofagia intensa, fiebre, exudado amigdalino y adenopatías cervicales anteriores dolorosas. No tiene tos, rinorrea ni conjuntivitis. Está hidratado, sin estridor, trismus o desviación uvular. Los cuidadores solicitan antibiótico inmediato por antecedente escolar de infección faríngea. No existen antecedentes de alergia medicamentosa, pero hay barreras para regresar con rapidez si empeora. El cuadro requiere estimar probabilidad de faringoamigdalitis estreptocócica y diferenciarla de cuadros virales o complicados.

Pregunta: ¿Qué hallazgo obliga a buscar una complicación supurativa?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- C. buscar absceso periamigdalino u otra complicación si aparece trismus, voz apagada, sialorrea o desviación uvular*
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: Trismus, voz de papa caliente, sialorrea o desviación uvular sugieren colección profunda y ameritan evaluación urgente. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Diagnóstico y Tratamiento de las Infecciones Agudas de Vías Aéreas Superiores en Pacientes Mayores de 3 Meses Hasta 18 Años. GPC-IMSS-062-08.

Especialidad: Pediatría

Tema: IRAS y Convulsiones

Subtema: Faringoamigdalitis

Dificultad: alta

Caso clínico: Escolar de 8 años con odinofagia intensa, fiebre, exudado amigdalino y adenopatías cervicales anteriores dolorosas. No tiene tos, rinorrea ni conjuntivitis. Está hidratado, sin estridor, trismus o desviación uvular. Los cuidadores solicitan antibiótico inmediato por antecedente escolar de infección faríngea. No existen antecedentes de alergia medicamentosa, pero hay barreras para regresar con rapidez si empeora. El cuadro requiere estimar probabilidad de faringoamigdalitis estreptocócica y diferenciarla de cuadros virales o complicados.

Pregunta: ¿Qué principio de prescripción antimicrobiana es correcto?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- C. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación
- D. evitar antimicrobianos de amplio espectro cuando un esquema dirigido es suficiente*

Explicación: Un fármaco dirigido reduce resistencia y efectos adversos sin sacrificar eficacia cuando el germen susceptible es previsible. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Diagnóstico y Tratamiento de las Infecciones Agudas de Vías Aéreas Superiores en Pacientes Mayores de 3 Meses Hasta 18 Años. GPC-IMSS-062-08.

Especialidad: Pediatría

Tema: IRAS y Convulsiones

Subtema: Faringoamigdalitis

Dificultad: alta

Caso clínico: Escolar de 8 años con odinofagia intensa, fiebre, exudado amigdalino y adenopatías cervicales anteriores dolorosas. No tiene tos, rinorrea ni conjuntivitis. Está hidratado, sin estridor, trismus o desviación uvular. Los cuidadores solicitan antibiótico inmediato por antecedente escolar de infección faríngea. La revisión de medicamentos identifica una posible exposición reciente que debe considerarse al integrar el riesgo. El cuadro requiere estimar probabilidad de faringoamigdalitis estreptocócica y diferenciarla de cuadros virales o complicados.

Pregunta: ¿Cuál es el enfoque diagnóstico inicial más razonable?

- A. usar la combinación de edad, signos clínicos y prueba diagnóstica disponible para confirmar estreptococo antes de tratar cuando el contexto lo permita*
- B. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- C. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: La clínica orienta, pero la confirmación o una alta probabilidad estructurada reduce tratamiento innecesario en cuadros virales. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Diagnóstico y Tratamiento de las Infecciones Agudas de Vías Aéreas Superiores en Pacientes Mayores de 3 Meses Hasta 18 Años. GPC-IMSS-062-08.

Especialidad: Pediatría

Tema: IRAS y Convulsiones

Subtema: Faringoamigdalitis

Dificultad: alta

Caso clínico: Escolar de 8 años con odinofagia intensa, fiebre, exudado amigdalino y adenopatías cervicales anteriores dolorosas. No tiene tos, rinorrea ni conjuntivitis. Está hidratado, sin estridor, trismus o desviación uvular. Los cuidadores solicitan antibiótico inmediato por antecedente escolar de infección faríngea. La revisión de medicamentos identifica una posible exposición reciente que debe considerarse al integrar el riesgo. El cuadro requiere estimar probabilidad de faringoamigdalitis estreptocócica y diferenciarla de cuadros virales o complicados.

Pregunta: ¿Qué medida debe recibir aunque la prueba microbiológica sea negativa?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. ofrecer analgesia, hidratación y vigilancia de vía aérea, independientemente de la etiología probable*
- C. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: Analgésicos, líquidos y vigilancia mejoran bienestar y permiten detectar deterioro, sin depender de la etiología final. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Diagnóstico y Tratamiento de las Infecciones Agudas de Vías Aéreas Superiores en Pacientes Mayores de 3 Meses Hasta 18 Años. GPC-IMSS-062-08.

Especialidad: Pediatría

Tema: IRAS y Convulsiones

Subtema: Faringoamigdalitis

Dificultad: alta

Caso clínico: Escolar de 8 años con odinofagia intensa, fiebre, exudado amigdalino y adenopatías cervicales anteriores dolorosas. No tiene tos, rinorrea ni conjuntivitis. Está hidratado, sin estridor, trismus o desviación uvular. Los cuidadores solicitan antibiótico inmediato por antecedente escolar de infección faríngea. La revisión de medicamentos identifica una posible exposición reciente que debe considerarse al integrar el riesgo. El cuadro requiere estimar probabilidad de faringoamigdalitis estreptocócica y diferenciarla de cuadros virales o complicados.

Pregunta: ¿Cuándo está justificado un antimicrobiano?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- C. indicar antibiótico dirigido cuando se confirme o la probabilidad clínica justifique tratamiento según la guía*
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: El antibiótico se reserva para infección estreptocócica confirmada o escenario de alta probabilidad definido, con objetivo de tratar y prevenir complicaciones. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Diagnóstico y Tratamiento de las Infecciones Agudas de Vías Aéreas Superiores en Pacientes Mayores de 3 Meses Hasta 18 Años. GPC-IMSS-062-08.

Especialidad: Pediatría

Tema: IRAS y Convulsiones

Subtema: Faringoamigdalitis

Dificultad: alta

Caso clínico: Escolar de 8 años con odinofagia intensa, fiebre, exudado amigdalino y adenopatías cervicales anteriores dolorosas. No tiene tos, rinorrea ni conjuntivitis. Está hidratado, sin estridor, trismus o desviación uvular. Los cuidadores solicitan antibiótico inmediato por antecedente escolar de infección faríngea. La revisión de medicamentos identifica una posible exposición reciente que debe considerarse al integrar el riesgo. El cuadro requiere estimar probabilidad de faringoamigdalitis estreptocócica y diferenciarla de cuadros virales o complicados.

Pregunta: ¿Qué hallazgo obliga a buscar una complicación supurativa?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- C. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación
- D. buscar absceso periamigdalino u otra complicación si aparece trismus, voz apagada, sialorrea o desviación uvular*

Explicación: Trismus, voz de papa caliente, sialorrea o desviación uvular sugieren colección profunda y ameritan evaluación urgente. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Diagnóstico y Tratamiento de las Infecciones Agudas de Vías Aéreas Superiores en Pacientes Mayores de 3 Meses Hasta 18 Años. GPC-IMSS-062-08.

Especialidad: Pediatría

Tema: IRAS y Convulsiones

Subtema: Faringoamigdalitis

Dificultad: alta

Caso clínico: Escolar de 8 años con odinofagia intensa, fiebre, exudado amigdalino y adenopatías cervicales anteriores dolorosas. No tiene tos, rinorrea ni conjuntivitis. Está hidratado, sin estridor, trismus o desviación uvular. Los cuidadores solicitan antibiótico inmediato por antecedente escolar de infección faríngea. La revisión de medicamentos identifica una posible exposición reciente que debe considerarse al integrar el riesgo. El cuadro requiere estimar probabilidad de faringoamigdalitis estreptocócica y diferenciarla de cuadros virales o complicados.

Pregunta: ¿Qué principio de prescripción antimicrobiana es correcto?

- A. evitar antimicrobianos de amplio espectro cuando un esquema dirigido es suficiente*
- B. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- C. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: Un fármaco dirigido reduce resistencia y efectos adversos sin sacrificar eficacia cuando el germen susceptible es previsible. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Diagnóstico y Tratamiento de las Infecciones Agudas de Vías Aéreas Superiores en Pacientes Mayores de 3 Meses Hasta 18 Años. GPC-IMSS-062-08.

Especialidad: Pediatría

Tema: IRAS y Convulsiones

Subtema: Faringoamigdalitis

Dificultad: alta

Caso clínico: Escolar de 8 años con odinofagia intensa, fiebre, exudado amigdalino y adenopatías cervicales anteriores dolorosas. No tiene tos, rinorrea ni conjuntivitis. Está hidratado, sin estridor, trismus o desviación uvular. Los cuidadores solicitan antibiótico inmediato por antecedente escolar de infección faríngea. Los signos vitales se repiten después de una primera medida de soporte y muestran la misma tendencia clínica. El cuadro requiere estimar probabilidad de faringoamigdalitis estreptocócica y diferenciarla de cuadros virales o complicados.

Pregunta: ¿Cuál es el enfoque diagnóstico inicial más razonable?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. usar la combinación de edad, signos clínicos y prueba diagnóstica disponible para confirmar estreptococo antes de tratar cuando el contexto lo permita*
- C. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: La clínica orienta, pero la confirmación o una alta probabilidad estructurada reduce tratamiento innecesario en cuadros virales. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Diagnóstico y Tratamiento de las Infecciones Agudas de Vías Aéreas Superiores en Pacientes Mayores de 3 Meses Hasta 18 Años. GPC-IMSS-062-08.

Especialidad: Pediatría

Tema: IRAS y Convulsiones

Subtema: Faringoamigdalitis

Dificultad: alta

Caso clínico: Escolar de 8 años con odinofagia intensa, fiebre, exudado amigdalino y adenopatías cervicales anteriores dolorosas. No tiene tos, rinorrea ni conjuntivitis. Está hidratado, sin estridor, trismus o desviación uvular. Los cuidadores solicitan antibiótico inmediato por antecedente escolar de infección faríngea. Los signos vitales se repiten después de una primera medida de soporte y muestran la misma tendencia clínica. El cuadro requiere estimar probabilidad de faringoamigdalitis estreptocócica y diferenciarla de cuadros virales o complicados.

Pregunta: ¿Qué medida debe recibir aunque la prueba microbiológica sea negativa?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- C. ofrecer analgesia, hidratación y vigilancia de vía aérea, independientemente de la etiología probable*
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: Analgésicos, líquidos y vigilancia mejoran bienestar y permiten detectar deterioro, sin depender de la etiología final. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Diagnóstico y Tratamiento de las Infecciones Agudas de Vías Aéreas Superiores en Pacientes Mayores de 3 Meses Hasta 18 Años. GPC-IMSS-062-08.

Especialidad: Pediatría

Tema: IRAS y Convulsiones

Subtema: Faringoamigdalitis

Dificultad: alta

Caso clínico: Escolar de 8 años con odinofagia intensa, fiebre, exudado amigdalino y adenopatías cervicales anteriores dolorosas. No tiene tos, rinorrea ni conjuntivitis. Está hidratado, sin estridor, trismus o desviación uvular. Los cuidadores solicitan antibiótico inmediato por antecedente escolar de infección faríngea. Los signos vitales se repiten después de una primera medida de soporte y muestran la misma tendencia clínica. El cuadro requiere estimar probabilidad de faringoamigdalitis estreptocócica y diferenciarla de cuadros virales o complicados.

Pregunta: ¿Cuándo está justificado un antimicrobiano?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- C. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación
- D. indicar antibiótico dirigido cuando se confirme o la probabilidad clínica justifique tratamiento según la guía*

Explicación: El antibiótico se reserva para infección estreptocócica confirmada o escenario de alta probabilidad definido, con objetivo de tratar y prevenir complicaciones. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Diagnóstico y Tratamiento de las Infecciones Agudas de Vías Aéreas Superiores en Pacientes Mayores de 3 Meses Hasta 18 Años. GPC-IMSS-062-08.

Especialidad: Pediatría

Tema: IRAS y Convulsiones

Subtema: Faringoamigdalitis

Dificultad: alta

Caso clínico: Escolar de 8 años con odinofagia intensa, fiebre, exudado amigdalino y adenopatías cervicales anteriores dolorosas. No tiene tos, rinorrea ni conjuntivitis. Está hidratado, sin estridor, trismus o desviación uvular. Los cuidadores solicitan antibiótico inmediato por antecedente escolar de infección faríngea. Los signos vitales se repiten después de una primera medida de soporte y muestran la misma tendencia clínica. El cuadro requiere estimar probabilidad de faringoamigdalitis estreptocócica y diferenciarla de cuadros virales o complicados.

Pregunta: ¿Qué hallazgo obliga a buscar una complicación supurativa?

- A. buscar absceso periamigdalino u otra complicación si aparece trismus, voz apagada, sialorrea o desviación uvular*
- B. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- C. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: Trismus, voz de papa caliente, sialorrea o desviación uvular sugieren colección profunda y ameritan evaluación urgente. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Diagnóstico y Tratamiento de las Infecciones Agudas de Vías Aéreas Superiores en Pacientes Mayores de 3 Meses Hasta 18 Años. GPC-IMSS-062-08.

Especialidad: Pediatría

Tema: IRAS y Convulsiones

Subtema: Faringoamigdalitis

Dificultad: alta

Caso clínico: Escolar de 8 años con odinofagia intensa, fiebre, exudado amigdalino y adenopatías cervicales anteriores dolorosas. No tiene tos, rinorrea ni conjuntivitis. Está hidratado, sin estridor, trismus o desviación uvular. Los cuidadores solicitan antibiótico inmediato por antecedente escolar de infección faríngea. Los signos vitales se repiten después de una primera medida de soporte y muestran la misma tendencia clínica. El cuadro requiere estimar probabilidad de faringoamigdalitis estreptocócica y diferenciarla de cuadros virales o complicados.

Pregunta: ¿Qué principio de prescripción antimicrobiana es correcto?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. evitar antimicrobianos de amplio espectro cuando un esquema dirigido es suficiente*
- C. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: Un fármaco dirigido reduce resistencia y efectos adversos sin sacrificar eficacia cuando el germen susceptible es previsible. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Diagnóstico y Tratamiento de las Infecciones Agudas de Vías Aéreas Superiores en Pacientes Mayores de 3 Meses Hasta 18 Años. GPC-IMSS-062-08.

Especialidad: Pediatría

Tema: Uropedia

Subtema: Torsión Testicular

Dificultad: alta

Caso clínico: Adolescente de 14 años despierta con dolor escrotal izquierdo súbito, intenso, acompañado de náusea. El testículo está alto y horizontal, con edema temprano y reflejo cremastérico ausente. No refiere disuria, fiebre ni traumatismo. El inicio fue hace cuatro horas. La evolución se ha modificado durante las últimas 12 horas y los familiares pueden aportar una cronología fiable. La instalación súbita, la posición testicular anormal y la ausencia de reflejo cremastérico hacen altamente probable torsión testicular.

Pregunta: ¿Cuál es la siguiente acción más importante?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- C. solicitar valoración urológica inmediata para exploración quirúrgica sin demorarla por estudios si la sospecha clínica es alta*
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: La alta sospecha de torsión es una urgencia quirúrgica; diferir exploración por pruebas puede costar viabilidad testicular. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Diagnóstico y Tratamiento del Escroto Agudo en el Niño y el Adolescente. GPC-IMSS-229-10.

Especialidad: Pediatría

Tema: Uropedía

Subtema: Torsión Testicular

Dificultad: alta

Caso clínico: Adolescente de 14 años despierta con dolor escrotal izquierdo súbito, intenso, acompañado de náusea. El testículo está alto y horizontal, con edema temprano y reflejo cremastérico ausente. No refiere disuria, fiebre ni traumatismo. El inicio fue hace cuatro horas. La evolución se ha modificado durante las últimas 12 horas y los familiares pueden aportar una cronología fiable. La instalación súbita, la posición testicular anormal y la ausencia de reflejo cremastérico hacen altamente probable torsión testicular.

Pregunta: ¿Cuál es el papel apropiado del Doppler?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- C. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación
- D. usar ultrasonido Doppler sólo si está disponible sin retrasar la resolución y persiste incertidumbre diagnóstica*

Explicación: El Doppler apoya en casos inciertos, pero nunca debe desplazar una exploración oportuna cuando la probabilidad clínica es alta. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Diagnóstico y Tratamiento del Escroto Agudo en el Niño y el Adolescente. GPC-IMSS-229-10.

Especialidad: Pediatría

Tema: Uropedia

Subtema: Torsión Testicular

Dificultad: alta

Caso clínico: Adolescente de 14 años despierta con dolor escrotal izquierdo súbito, intenso, acompañado de náusea. El testículo está alto y horizontal, con edema temprano y reflejo cremastérico ausente. No refiere disuria, fiebre ni traumatismo. El inicio fue hace cuatro horas. La evolución se ha modificado durante las últimas 12 horas y los familiares pueden aportar una cronología fiable. La instalación súbita, la posición testicular anormal y la ausencia de reflejo cremastérico hacen altamente probable torsión testicular.

Pregunta: ¿Qué error diagnóstico debe evitarse?

- A. no atribuir el cuadro a epididimitis en ausencia de datos urinarios o inflamatorios compatibles*
- B. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- C. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: Epididimitis suele asociarse a otros hallazgos; etiquetar empíricamente este patrón como infección retrasa el tratamiento definitivo. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Diagnóstico y Tratamiento del Escroto Agudo en el Niño y el Adolescente. GPC-IMSS-229-10.

Especialidad: Pediatría

Tema: Uropedia

Subtema: Torsión Testicular

Dificultad: alta

Caso clínico: Adolescente de 14 años despierta con dolor escrotal izquierdo súbito, intenso, acompañado de náusea. El testículo está alto y horizontal, con edema temprano y reflejo cremastérico ausente. No refiere disuria, fiebre ni traumatismo. El inicio fue hace cuatro horas. La evolución se ha modificado durante las últimas 12 horas y los familiares pueden aportar una cronología fiable. La instalación súbita, la posición testicular anormal y la ausencia de reflejo cremastérico hacen altamente probable torsión testicular.

Pregunta: ¿Qué medida complementaria se considera durante la resolución quirúrgica?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. considerar fijación contralateral durante el procedimiento por el riesgo anatómico bilateral*
- C. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: La deformidad predisponente puede ser bilateral, por lo que la fijación contralateral reduce riesgo futuro. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Diagnóstico y Tratamiento del Escroto Agudo en el Niño y el Adolescente. GPC-IMSS-229-10.

Especialidad: Pediatría

Tema: Uropedia

Subtema: Torsión Testicular

Dificultad: alta

Caso clínico: Adolescente de 14 años despierta con dolor escrotal izquierdo súbito, intenso, acompañado de náusea. El testículo está alto y horizontal, con edema temprano y reflejo cremastérico ausente. No refiere disuria, fiebre ni traumatismo. El inicio fue hace cuatro horas. La evolución se ha modificado durante las últimas 12 horas y los familiares pueden aportar una cronología fiable. La instalación súbita, la posición testicular anormal y la ausencia de reflejo cremastérico hacen altamente probable torsión testicular.

Pregunta: ¿Qué explicación debe guiar la urgencia del traslado?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- C. comunicar que el tiempo de isquemia condiciona viabilidad y exige decisión urgente*
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: La viabilidad disminuye conforme avanza la isquemia; la comunicación clara acelera decisiones y referencia. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Diagnóstico y Tratamiento del Escroto Agudo en el Niño y el Adolescente. GPC-IMSS-229-10.

Especialidad: Pediatría

Tema: Uropedia

Subtema: Torsión Testicular

Dificultad: alta

Caso clínico: Adolescente de 14 años despierta con dolor escrotal izquierdo súbito, intenso, acompañado de náusea. El testículo está alto y horizontal, con edema temprano y reflejo cremastérico ausente. No refiere disuria, fiebre ni traumatismo. El inicio fue hace cuatro horas. No existen antecedentes de alergia medicamentosa, pero hay barreras para regresar con rapidez si empeora. La instalación súbita, la posición testicular anormal y la ausencia de reflejo cremastérico hacen altamente probable torsión testicular.

Pregunta: ¿Cuál es la siguiente acción más importante?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- C. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación
- D. solicitar valoración urológica inmediata para exploración quirúrgica sin demorarla por estudios si la sospecha clínica es alta*

Explicación: La alta sospecha de torsión es una urgencia quirúrgica; diferir exploración por pruebas puede costar viabilidad testicular. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Diagnóstico y Tratamiento del Escroto Agudo en el Niño y el Adolescente. GPC-IMSS-229-10.

Especialidad: Pediatría

Tema: Uropedia

Subtema: Torsión Testicular

Dificultad: alta

Caso clínico: Adolescente de 14 años despierta con dolor escrotal izquierdo súbito, intenso, acompañado de náusea. El testículo está alto y horizontal, con edema temprano y reflejo cremastérico ausente. No refiere disuria, fiebre ni traumatismo. El inicio fue hace cuatro horas. No existen antecedentes de alergia medicamentosa, pero hay barreras para regresar con rapidez si empeora. La instalación súbita, la posición testicular anormal y la ausencia de reflejo cremastérico hacen altamente probable torsión testicular.

Pregunta: ¿Cuál es el papel apropiado del Doppler?

- A. usar ultrasonido Doppler sólo si está disponible sin retrasar la resolución y persiste incertidumbre diagnóstica*
- B. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- C. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: El Doppler apoya en casos inciertos, pero nunca debe desplazar una exploración oportuna cuando la probabilidad clínica es alta. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Diagnóstico y Tratamiento del Escroto Agudo en el Niño y el Adolescente. GPC-IMSS-229-10.

Especialidad: Pediatría

Tema: Uropedia

Subtema: Torsión Testicular

Dificultad: alta

Caso clínico: Adolescente de 14 años despierta con dolor escrotal izquierdo súbito, intenso, acompañado de náusea. El testículo está alto y horizontal, con edema temprano y reflejo cremastérico ausente. No refiere disuria, fiebre ni traumatismo. El inicio fue hace cuatro horas. No existen antecedentes de alergia medicamentosa, pero hay barreras para regresar con rapidez si empeora. La instalación súbita, la posición testicular anormal y la ausencia de reflejo cremastérico hacen altamente probable torsión testicular.

Pregunta: ¿Qué error diagnóstico debe evitarse?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. no atribuir el cuadro a epididimitis en ausencia de datos urinarios o inflamatorios compatibles*
- C. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: Epididimitis suele asociarse a otros hallazgos; etiquetar empíricamente este patrón como infección retrasa el tratamiento definitivo. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Diagnóstico y Tratamiento del Escroto Agudo en el Niño y el Adolescente. GPC-IMSS-229-10.

Especialidad: Pediatría

Tema: Uropedia

Subtema: Torsión Testicular

Dificultad: alta

Caso clínico: Adolescente de 14 años despierta con dolor escrotal izquierdo súbito, intenso, acompañado de náusea. El testículo está alto y horizontal, con edema temprano y reflejo cremastérico ausente. No refiere disuria, fiebre ni traumatismo. El inicio fue hace cuatro horas. No existen antecedentes de alergia medicamentosa, pero hay barreras para regresar con rapidez si empeora. La instalación súbita, la posición testicular anormal y la ausencia de reflejo cremastérico hacen altamente probable torsión testicular.

Pregunta: ¿Qué medida complementaria se considera durante la resolución quirúrgica?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- C. considerar fijación contralateral durante el procedimiento por el riesgo anatómico bilateral*
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: La deformidad predisponente puede ser bilateral, por lo que la fijación contralateral reduce riesgo futuro. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Diagnóstico y Tratamiento del Escroto Agudo en el Niño y el Adolescente. GPC-IMSS-229-10.

Especialidad: Pediatría

Tema: Uropedia

Subtema: Torsión Testicular

Dificultad: alta

Caso clínico: Adolescente de 14 años despierta con dolor escrotal izquierdo súbito, intenso, acompañado de náusea. El testículo está alto y horizontal, con edema temprano y reflejo cremastérico ausente. No refiere disuria, fiebre ni traumatismo. El inicio fue hace cuatro horas. No existen antecedentes de alergia medicamentosa, pero hay barreras para regresar con rapidez si empeora. La instalación súbita, la posición testicular anormal y la ausencia de reflejo cremastérico hacen altamente probable torsión testicular.

Pregunta: ¿Qué explicación debe guiar la urgencia del traslado?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- C. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación
- D. comunicar que el tiempo de isquemia condiciona viabilidad y exige decisión urgente*

Explicación: La viabilidad disminuye conforme avanza la isquemia; la comunicación clara acelera decisiones y referencia. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Diagnóstico y Tratamiento del Escroto Agudo en el Niño y el Adolescente. GPC-IMSS-229-10.

Especialidad: Pediatría

Tema: Uropedia

Subtema: Torsión Testicular

Dificultad: alta

Caso clínico: Adolescente de 14 años despierta con dolor escrotal izquierdo súbito, intenso, acompañado de náusea. El testículo está alto y horizontal, con edema temprano y reflejo cremastérico ausente. No refiere disuria, fiebre ni traumatismo. El inicio fue hace cuatro horas. La revisión de medicamentos identifica una posible exposición reciente que debe considerarse al integrar el riesgo. La instalación súbita, la posición testicular anormal y la ausencia de reflejo cremastérico hacen altamente probable torsión testicular.

Pregunta: ¿Cuál es la siguiente acción más importante?

- A. solicitar valoración urológica inmediata para exploración quirúrgica sin demorarla por estudios si la sospecha clínica es alta*
- B. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- C. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: La alta sospecha de torsión es una urgencia quirúrgica; diferir exploración por pruebas puede costar viabilidad testicular. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Diagnóstico y Tratamiento del Escroto Agudo en el Niño y el Adolescente. GPC-IMSS-229-10.

Especialidad: Pediatría

Tema: Uropedia

Subtema: Torsión Testicular

Dificultad: alta

Caso clínico: Adolescente de 14 años despierta con dolor escrotal izquierdo súbito, intenso, acompañado de náusea. El testículo está alto y horizontal, con edema temprano y reflejo cremastérico ausente. No refiere disuria, fiebre ni traumatismo. El inicio fue hace cuatro horas. La revisión de medicamentos identifica una posible exposición reciente que debe considerarse al integrar el riesgo. La instalación súbita, la posición testicular anormal y la ausencia de reflejo cremastérico hacen altamente probable torsión testicular.

Pregunta: ¿Cuál es el papel apropiado del Doppler?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. usar ultrasonido Doppler sólo si está disponible sin retrasar la resolución y persiste incertidumbre diagnóstica*
- C. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: El Doppler apoya en casos inciertos, pero nunca debe desplazar una exploración oportuna cuando la probabilidad clínica es alta. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Diagnóstico y Tratamiento del Escroto Agudo en el Niño y el Adolescente. GPC-IMSS-229-10.

Especialidad: Pediatría

Tema: Uropedia

Subtema: Torsión Testicular

Dificultad: alta

Caso clínico: Adolescente de 14 años despierta con dolor escrotal izquierdo súbito, intenso, acompañado de náusea. El testículo está alto y horizontal, con edema temprano y reflejo cremastérico ausente. No refiere disuria, fiebre ni traumatismo. El inicio fue hace cuatro horas. La revisión de medicamentos identifica una posible exposición reciente que debe considerarse al integrar el riesgo. La instalación súbita, la posición testicular anormal y la ausencia de reflejo cremastérico hacen altamente probable torsión testicular.

Pregunta: ¿Qué error diagnóstico debe evitarse?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- C. no atribuir el cuadro a epididimitis en ausencia de datos urinarios o inflamatorios compatibles*
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: Epididimitis suele asociarse a otros hallazgos; etiquetar empíricamente este patrón como infección retrasa el tratamiento definitivo. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Diagnóstico y Tratamiento del Escroto Agudo en el Niño y el Adolescente. GPC-IMSS-229-10.

Especialidad: Pediatría

Tema: Uropedia

Subtema: Torsión Testicular

Dificultad: alta

Caso clínico: Adolescente de 14 años despierta con dolor escrotal izquierdo súbito, intenso, acompañado de náusea. El testículo está alto y horizontal, con edema temprano y reflejo cremastérico ausente. No refiere disuria, fiebre ni traumatismo. El inicio fue hace cuatro horas. La revisión de medicamentos identifica una posible exposición reciente que debe considerarse al integrar el riesgo. La instalación súbita, la posición testicular anormal y la ausencia de reflejo cremastérico hacen altamente probable torsión testicular.

Pregunta: ¿Qué medida complementaria se considera durante la resolución quirúrgica?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- C. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación
- D. considerar fijación contralateral durante el procedimiento por el riesgo anatómico bilateral*

Explicación: La deformidad predisponente puede ser bilateral, por lo que la fijación contralateral reduce riesgo futuro. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Diagnóstico y Tratamiento del Escroto Agudo en el Niño y el Adolescente. GPC-IMSS-229-10.

Especialidad: Pediatría

Tema: Uropedia

Subtema: Torsión Testicular

Dificultad: alta

Caso clínico: Adolescente de 14 años despierta con dolor escrotal izquierdo súbito, intenso, acompañado de náusea. El testículo está alto y horizontal, con edema temprano y reflejo cremastérico ausente. No refiere disuria, fiebre ni traumatismo. El inicio fue hace cuatro horas. La revisión de medicamentos identifica una posible exposición reciente que debe considerarse al integrar el riesgo. La instalación súbita, la posición testicular anormal y la ausencia de reflejo cremastérico hacen altamente probable torsión testicular.

Pregunta: ¿Qué explicación debe guiar la urgencia del traslado?

- A. comunicar que el tiempo de isquemia condiciona viabilidad y exige decisión urgente*
- B. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- C. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: La viabilidad disminuye conforme avanza la isquemia; la comunicación clara acelera decisiones y referencia. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Diagnóstico y Tratamiento del Escroto Agudo en el Niño y el Adolescente. GPC-IMSS-229-10.

Especialidad: Pediatría

Tema: Uropedia

Subtema: Torsión Testicular

Dificultad: alta

Caso clínico: Adolescente de 14 años despierta con dolor escrotal izquierdo súbito, intenso, acompañado de náusea. El testículo está alto y horizontal, con edema temprano y reflejo cremastérico ausente. No refiere disuria, fiebre ni traumatismo. El inicio fue hace cuatro horas. Los signos vitales se repiten después de una primera medida de soporte y muestran la misma tendencia clínica. La instalación súbita, la posición testicular anormal y la ausencia de reflejo cremastérico hacen altamente probable torsión testicular.

Pregunta: ¿Cuál es la siguiente acción más importante?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. solicitar valoración urológica inmediata para exploración quirúrgica sin demorarla por estudios si la sospecha clínica es alta*
- C. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: La alta sospecha de torsión es una urgencia quirúrgica; diferir exploración por pruebas puede costar viabilidad testicular. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Diagnóstico y Tratamiento del Escroto Agudo en el Niño y el Adolescente. GPC-IMSS-229-10.

Especialidad: Pediatría

Tema: Uropedia

Subtema: Torsión Testicular

Dificultad: alta

Caso clínico: Adolescente de 14 años despierta con dolor escrotal izquierdo súbito, intenso, acompañado de náusea. El testículo está alto y horizontal, con edema temprano y reflejo cremastérico ausente. No refiere disuria, fiebre ni traumatismo. El inicio fue hace cuatro horas. Los signos vitales se repiten después de una primera medida de soporte y muestran la misma tendencia clínica. La instalación súbita, la posición testicular anormal y la ausencia de reflejo cremastérico hacen altamente probable torsión testicular.

Pregunta: ¿Cuál es el papel apropiado del Doppler?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- C. usar ultrasonido Doppler sólo si está disponible sin retrasar la resolución y persiste incertidumbre diagnóstica*
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: El Doppler apoya en casos inciertos, pero nunca debe desplazar una exploración oportuna cuando la probabilidad clínica es alta. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Diagnóstico y Tratamiento del Escroto Agudo en el Niño y el Adolescente. GPC-IMSS-229-10.

Especialidad: Pediatría

Tema: Uropedia

Subtema: Torsión Testicular

Dificultad: alta

Caso clínico: Adolescente de 14 años despierta con dolor escrotal izquierdo súbito, intenso, acompañado de náusea. El testículo está alto y horizontal, con edema temprano y reflejo cremastérico ausente. No refiere disuria, fiebre ni traumatismo. El inicio fue hace cuatro horas. Los signos vitales se repiten después de una primera medida de soporte y muestran la misma tendencia clínica. La instalación súbita, la posición testicular anormal y la ausencia de reflejo cremastérico hacen altamente probable torsión testicular.

Pregunta: ¿Qué error diagnóstico debe evitarse?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- C. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación
- D. no atribuir el cuadro a epididimitis en ausencia de datos urinarios o inflamatorios compatibles*

Explicación: Epididimitis suele asociarse a otros hallazgos; etiquetar empíricamente este patrón como infección retrasa el tratamiento definitivo. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Diagnóstico y Tratamiento del Escroto Agudo en el Niño y el Adolescente. GPC-IMSS-229-10.

Especialidad: Pediatría

Tema: Uropedia

Subtema: Torsión Testicular

Dificultad: alta

Caso clínico: Adolescente de 14 años despierta con dolor escrotal izquierdo súbito, intenso, acompañado de náusea. El testículo está alto y horizontal, con edema temprano y reflejo cremastérico ausente. No refiere disuria, fiebre ni traumatismo. El inicio fue hace cuatro horas. Los signos vitales se repiten después de una primera medida de soporte y muestran la misma tendencia clínica. La instalación súbita, la posición testicular anormal y la ausencia de reflejo cremastérico hacen altamente probable torsión testicular.

Pregunta: ¿Qué medida complementaria se considera durante la resolución quirúrgica?

- A. considerar fijación contralateral durante el procedimiento por el riesgo anatómico bilateral*
- B. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- C. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: La deformidad predisponente puede ser bilateral, por lo que la fijación contralateral reduce riesgo futuro. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Diagnóstico y Tratamiento del Escroto Agudo en el Niño y el Adolescente. GPC-IMSS-229-10.

Especialidad: Pediatría

Tema: Uropedia

Subtema: Torsión Testicular

Dificultad: alta

Caso clínico: Adolescente de 14 años despierta con dolor escrotal izquierdo súbito, intenso, acompañado de náusea. El testículo está alto y horizontal, con edema temprano y reflejo cremastérico ausente. No refiere disuria, fiebre ni traumatismo. El inicio fue hace cuatro horas. Los signos vitales se repiten después de una primera medida de soporte y muestran la misma tendencia clínica. La instalación súbita, la posición testicular anormal y la ausencia de reflejo cremastérico hacen altamente probable torsión testicular.

Pregunta: ¿Qué explicación debe guiar la urgencia del traslado?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. comunicar que el tiempo de isquemia condiciona viabilidad y exige decisión urgente*
- C. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: La viabilidad disminuye conforme avanza la isquemia; la comunicación clara acelera decisiones y referencia. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Diagnóstico y Tratamiento del Escroto Agudo en el Niño y el Adolescente. GPC-IMSS-229-10.

Especialidad: Ginecología y Obstetricia

Tema: Patología del Embarazo: Estados Hipertensivos

Subtema: Preeclampsia

Dificultad: alta

Caso clínico: Gestante de 32 semanas, previamente normotensa, presenta cefalea persistente, fosfenos y dolor epigástrico. Registra presión arterial severamente elevada en dos tomas adecuadas; tiene proteinuria y plaquetas en descenso, sin trabajo de parto. La evaluación fetal inicial muestra crecimiento conservado, con necesidad de vigilancia estrecha. La evolución se ha modificado durante las últimas 12 horas y los familiares pueden aportar una cronología fiable. La hipertensión de nueva aparición con proteinuria y datos de daño orgánico configura preeclampsia con criterios de gravedad.

Pregunta: ¿Cuál es la prioridad terapéutica inmediata?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- C. estabilizar la presión arterial severa con tratamiento antihipertensivo de acción apropiada y vigilancia materno-fetal estrecha*
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: La hipertensión severa expone a hemorragia cerebral, edema pulmonar y complicaciones fetales; debe tratarse mientras se completa la evaluación. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Secretaría de Salud e Instituto Mexicano del Seguro Social. Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de la Preeclampsia en Segundo y Tercer Nivel de Atención. GPC-SS-058-08.

Especialidad: Ginecología y Obstetricia

Tema: Patología del Embarazo: Estados Hipertensivos

Subtema: Preeclampsia

Dificultad: alta

Caso clínico: Gestante de 32 semanas, previamente normotensa, presenta cefalea persistente, fosfenos y dolor epigástrico. Registra presión arterial severamente elevada en dos tomas adecuadas; tiene proteinuria y plaquetas en descenso, sin trabajo de parto. La evaluación fetal inicial muestra crecimiento conservado, con necesidad de vigilancia estrecha. La evolución se ha modificado durante las últimas 12 horas y los familiares pueden aportar una cronología fiable. La hipertensión de nueva aparición con proteinuria y datos de daño orgánico configura preeclampsia con criterios de gravedad.

Pregunta: ¿Qué fármaco se utiliza para profilaxis de convulsiones?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- C. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación
- D. administrar sulfato de magnesio para prevención de convulsiones cuando existen criterios de gravedad*

Explicación: El sulfato de magnesio es la medida preventiva de elección contra eclampsia en preeclampsia con datos de gravedad. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Secretaría de Salud e Instituto Mexicano del Seguro Social. Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de la Preeclampsia en Segundo y Tercer Nivel de Atención. GPC-SS-058-08.

Especialidad: Ginecología y Obstetricia

Tema: Patología del Embarazo: Estados Hipertensivos

Subtema: Preeclampsia

Dificultad: alta

Caso clínico: Gestante de 32 semanas, previamente normotensa, presenta cefalea persistente, fosfenos y dolor epigástrico. Registra presión arterial severamente elevada en dos tomas adecuadas; tiene proteinuria y plaquetas en descenso, sin trabajo de parto. La evaluación fetal inicial muestra crecimiento conservado, con necesidad de vigilancia estrecha. La evolución se ha modificado durante las últimas 12 horas y los familiares pueden aportar una cronología fiable. La hipertensión de nueva aparición con proteinuria y datos de daño orgánico configura preeclampsia con criterios de gravedad.

Pregunta: ¿Qué vigilancia paraclínica identifica progresión de daño orgánico?

- A. obtener laboratorios seriados de plaquetas, función renal y hepática, y valorar síntomas de progresión*
- B. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- C. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: Plaquetas, creatinina y enzimas hepáticas permiten reconocer progresión hacia HELLP o disfunción multiorgánica. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Secretaría de Salud e Instituto Mexicano del Seguro Social. Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de la Preeclampsia en Segundo y Tercer Nivel de Atención. GPC-SS-058-08.

Especialidad: Ginecología y Obstetricia

Tema: Patología del Embarazo: Estados Hipertensivos

Subtema: Preeclampsia

Dificultad: alta

Caso clínico: Gestante de 32 semanas, previamente normotensa, presenta cefalea persistente, fosfenos y dolor epigástrico. Registra presión arterial severamente elevada en dos tomas adecuadas; tiene proteinuria y plaquetas en descenso, sin trabajo de parto. La evaluación fetal inicial muestra crecimiento conservado, con necesidad de vigilancia estrecha. La evolución se ha modificado durante las últimas 12 horas y los familiares pueden aportar una cronología fiable. La hipertensión de nueva aparición con proteinuria y datos de daño orgánico configura preeclampsia con criterios de gravedad.

Pregunta: ¿Qué principio determina la finalización del embarazo?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. definir momento de terminación del embarazo según estabilidad materna, edad gestacional, condición fetal y respuesta a estabilización*
- C. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: La finalización es el tratamiento definitivo, pero la oportunidad se individualiza tras estabilizar y valorar el balance materno-fetal. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Secretaría de Salud e Instituto Mexicano del Seguro Social. Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de la Preeclampsia en Segundo y Tercer Nivel de Atención. GPC-SS-058-08.

Especialidad: Ginecología y Obstetricia

Tema: Patología del Embarazo: Estados Hipertensivos

Subtema: Preeclampsia

Dificultad: alta

Caso clínico: Gestante de 32 semanas, previamente normotensa, presenta cefalea persistente, fosfenos y dolor epigástrico. Registra presión arterial severamente elevada en dos tomas adecuadas; tiene proteinuria y plaquetas en descenso, sin trabajo de parto. La evaluación fetal inicial muestra crecimiento conservado, con necesidad de vigilancia estrecha. La evolución se ha modificado durante las últimas 12 horas y los familiares pueden aportar una cronología fiable. La hipertensión de nueva aparición con proteinuria y datos de daño orgánico configura preeclampsia con criterios de gravedad.

Pregunta: ¿Qué modalidad de atención es inapropiada en este escenario?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- C. no indicar manejo ambulatorio ante síntomas persistentes o criterios de gravedad*
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: Los síntomas neurológicos, presión severa y datos de daño orgánico requieren hospitalización y capacidad de respuesta inmediata. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Secretaría de Salud e Instituto Mexicano del Seguro Social. Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de la Preeclampsia en Segundo y Tercer Nivel de Atención. GPC-SS-058-08.

Especialidad: Ginecología y Obstetricia

Tema: Patología del Embarazo: Estados Hipertensivos

Subtema: Preeclampsia

Dificultad: alta

Caso clínico: Gestante de 32 semanas, previamente normotensa, presenta cefalea persistente, fosfenos y dolor epigástrico. Registra presión arterial severamente elevada en dos tomas adecuadas; tiene proteinuria y plaquetas en descenso, sin trabajo de parto. La evaluación fetal inicial muestra crecimiento conservado, con necesidad de vigilancia estrecha. No existen antecedentes de alergia medicamentosa, pero hay barreras para regresar con rapidez si empeora. La hipertensión de nueva aparición con proteinuria y datos de daño orgánico configura preeclampsia con criterios de gravedad.

Pregunta: ¿Cuál es la prioridad terapéutica inmediata?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- C. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación
- D. estabilizar la presión arterial severa con tratamiento antihipertensivo de acción apropiada y vigilancia materno-fetal estrecha*

Explicación: La hipertensión severa expone a hemorragia cerebral, edema pulmonar y complicaciones fetales; debe tratarse mientras se completa la evaluación. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Secretaría de Salud e Instituto Mexicano del Seguro Social. Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de la Preeclampsia en Segundo y Tercer Nivel de Atención. GPC-SS-058-08.

Especialidad: Ginecología y Obstetricia

Tema: Patología del Embarazo: Estados Hipertensivos

Subtema: Preeclampsia

Dificultad: alta

Caso clínico: Gestante de 32 semanas, previamente normotensa, presenta cefalea persistente, fosfenos y dolor epigástrico. Registra presión arterial severamente elevada en dos tomas adecuadas; tiene proteinuria y plaquetas en descenso, sin trabajo de parto. La evaluación fetal inicial muestra crecimiento conservado, con necesidad de vigilancia estrecha. No existen antecedentes de alergia medicamentosa, pero hay barreras para regresar con rapidez si empeora. La hipertensión de nueva aparición con proteinuria y datos de daño orgánico configura preeclampsia con criterios de gravedad.

Pregunta: ¿Qué fármaco se utiliza para profilaxis de convulsiones?

- A. administrar sulfato de magnesio para prevención de convulsiones cuando existen criterios de gravedad*
- B. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- C. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: El sulfato de magnesio es la medida preventiva de elección contra eclampsia en preeclampsia con datos de gravedad. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Secretaría de Salud e Instituto Mexicano del Seguro Social. Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de la Preeclampsia en Segundo y Tercer Nivel de Atención. GPC-SS-058-08.

Especialidad: Ginecología y Obstetricia

Tema: Patología del Embarazo: Estados Hipertensivos

Subtema: Preeclampsia

Dificultad: alta

Caso clínico: Gestante de 32 semanas, previamente normotensa, presenta cefalea persistente, fosfenos y dolor epigástrico. Registra presión arterial severamente elevada en dos tomas adecuadas; tiene proteinuria y plaquetas en descenso, sin trabajo de parto. La evaluación fetal inicial muestra crecimiento conservado, con necesidad de vigilancia estrecha. No existen antecedentes de alergia medicamentosa, pero hay barreras para regresar con rapidez si empeora. La hipertensión de nueva aparición con proteinuria y datos de daño orgánico configura preeclampsia con criterios de gravedad.

Pregunta: ¿Qué vigilancia paraclínica identifica progresión de daño orgánico?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. obtener laboratorios seriados de plaquetas, función renal y hepática, y valorar síntomas de progresión*
- C. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: Plaquetas, creatinina y enzimas hepáticas permiten reconocer progresión hacia HELLP o disfunción multiorgánica. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Secretaría de Salud e Instituto Mexicano del Seguro Social. Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de la Preeclampsia en Segundo y Tercer Nivel de Atención. GPC-SS-058-08.

Especialidad: Ginecología y Obstetricia

Tema: Patología del Embarazo: Estados Hipertensivos

Subtema: Preeclampsia

Dificultad: alta

Caso clínico: Gestante de 32 semanas, previamente normotensa, presenta cefalea persistente, fosfenos y dolor epigástrico. Registra presión arterial severamente elevada en dos tomas adecuadas; tiene proteinuria y plaquetas en descenso, sin trabajo de parto. La evaluación fetal inicial muestra crecimiento conservado, con necesidad de vigilancia estrecha. No existen antecedentes de alergia medicamentosa, pero hay barreras para regresar con rapidez si empeora. La hipertensión de nueva aparición con proteinuria y datos de daño orgánico configura preeclampsia con criterios de gravedad.

Pregunta: ¿Qué principio determina la finalización del embarazo?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- C. definir momento de terminación del embarazo según estabilidad materna, edad gestacional, condición fetal y respuesta a estabilización*
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: La finalización es el tratamiento definitivo, pero la oportunidad se individualiza tras estabilizar y valorar el balance materno-fetal. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Secretaría de Salud e Instituto Mexicano del Seguro Social. Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de la Preeclampsia en Segundo y Tercer Nivel de Atención. GPC-SS-058-08.

Especialidad: Ginecología y Obstetricia

Tema: Patología del Embarazo: Estados Hipertensivos

Subtema: Preeclampsia

Dificultad: alta

Caso clínico: Gestante de 32 semanas, previamente normotensa, presenta cefalea persistente, fosfenos y dolor epigástrico. Registra presión arterial severamente elevada en dos tomas adecuadas; tiene proteinuria y plaquetas en descenso, sin trabajo de parto. La evaluación fetal inicial muestra crecimiento conservado, con necesidad de vigilancia estrecha. No existen antecedentes de alergia medicamentosa, pero hay barreras para regresar con rapidez si empeora. La hipertensión de nueva aparición con proteinuria y datos de daño orgánico configura preeclampsia con criterios de gravedad.

Pregunta: ¿Qué modalidad de atención es inapropiada en este escenario?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- C. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación
- D. no indicar manejo ambulatorio ante síntomas persistentes o criterios de gravedad*

Explicación: Los síntomas neurológicos, presión severa y datos de daño orgánico requieren hospitalización y capacidad de respuesta inmediata. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Secretaría de Salud e Instituto Mexicano del Seguro Social. Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de la Preeclampsia en Segundo y Tercer Nivel de Atención. GPC-SS-058-08.

Especialidad: Ginecología y Obstetricia

Tema: Patología del Embarazo: Estados Hipertensivos

Subtema: Preeclampsia

Dificultad: alta

Caso clínico: Gestante de 32 semanas, previamente normotensa, presenta cefalea persistente, fosfenos y dolor epigástrico. Registra presión arterial severamente elevada en dos tomas adecuadas; tiene proteinuria y plaquetas en descenso, sin trabajo de parto. La evaluación fetal inicial muestra crecimiento conservado, con necesidad de vigilancia estrecha. La revisión de medicamentos identifica una posible exposición reciente que debe considerarse al integrar el riesgo. La hipertensión de nueva aparición con proteinuria y datos de daño orgánico configura preeclampsia con criterios de gravedad.

Pregunta: ¿Cuál es la prioridad terapéutica inmediata?

- A. estabilizar la presión arterial severa con tratamiento antihipertensivo de acción apropiada y vigilancia materno-fetal estrecha*
- B. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- C. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: La hipertensión severa expone a hemorragia cerebral, edema pulmonar y complicaciones fetales; debe tratarse mientras se completa la evaluación. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Secretaría de Salud e Instituto Mexicano del Seguro Social. Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de la Preeclampsia en Segundo y Tercer Nivel de Atención. GPC-SS-058-08.

Especialidad: Ginecología y Obstetricia

Tema: Patología del Embarazo: Estados Hipertensivos

Subtema: Preeclampsia

Dificultad: alta

Caso clínico: Gestante de 32 semanas, previamente normotensa, presenta cefalea persistente, fosfenos y dolor epigástrico. Registra presión arterial severamente elevada en dos tomas adecuadas; tiene proteinuria y plaquetas en descenso, sin trabajo de parto. La evaluación fetal inicial muestra crecimiento conservado, con necesidad de vigilancia estrecha. La revisión de medicamentos identifica una posible exposición reciente que debe considerarse al integrar el riesgo. La hipertensión de nueva aparición con proteinuria y datos de daño orgánico configura preeclampsia con criterios de gravedad.

Pregunta: ¿Qué fármaco se utiliza para profilaxis de convulsiones?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. administrar sulfato de magnesio para prevención de convulsiones cuando existen criterios de gravedad*
- C. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: El sulfato de magnesio es la medida preventiva de elección contra eclampsia en preeclampsia con datos de gravedad. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Secretaría de Salud e Instituto Mexicano del Seguro Social. Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de la Preeclampsia en Segundo y Tercer Nivel de Atención. GPC-SS-058-08.

Especialidad: Ginecología y Obstetricia

Tema: Patología del Embarazo: Estados Hipertensivos

Subtema: Preeclampsia

Dificultad: alta

Caso clínico: Gestante de 32 semanas, previamente normotensa, presenta cefalea persistente, fosfenos y dolor epigástrico. Registra presión arterial severamente elevada en dos tomas adecuadas; tiene proteinuria y plaquetas en descenso, sin trabajo de parto. La evaluación fetal inicial muestra crecimiento conservado, con necesidad de vigilancia estrecha. La revisión de medicamentos identifica una posible exposición reciente que debe considerarse al integrar el riesgo. La hipertensión de nueva aparición con proteinuria y datos de daño orgánico configura preeclampsia con criterios de gravedad.

Pregunta: ¿Qué vigilancia paraclínica identifica progresión de daño orgánico?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- C. obtener laboratorios seriados de plaquetas, función renal y hepática, y valorar síntomas de progresión*
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: Plaquetas, creatinina y enzimas hepáticas permiten reconocer progresión hacia HELLP o disfunción multiorgánica. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Secretaría de Salud e Instituto Mexicano del Seguro Social. Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de la Preeclampsia en Segundo y Tercer Nivel de Atención. GPC-SS-058-08.

Especialidad: Ginecología y Obstetricia

Tema: Patología del Embarazo: Estados Hipertensivos

Subtema: Preeclampsia

Dificultad: alta

Caso clínico: Gestante de 32 semanas, previamente normotensa, presenta cefalea persistente, fosfenos y dolor epigástrico. Registra presión arterial severamente elevada en dos tomas adecuadas; tiene proteinuria y plaquetas en descenso, sin trabajo de parto. La evaluación fetal inicial muestra crecimiento conservado, con necesidad de vigilancia estrecha. La revisión de medicamentos identifica una posible exposición reciente que debe considerarse al integrar el riesgo. La hipertensión de nueva aparición con proteinuria y datos de daño orgánico configura preeclampsia con criterios de gravedad.

Pregunta: ¿Qué principio determina la finalización del embarazo?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- C. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación
- D. definir momento de terminación del embarazo según estabilidad materna, edad gestacional, condición fetal y respuesta a estabilización*

Explicación: La finalización es el tratamiento definitivo, pero la oportunidad se individualiza tras estabilizar y valorar el balance materno-fetal. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Secretaría de Salud e Instituto Mexicano del Seguro Social. Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de la Preeclampsia en Segundo y Tercer Nivel de Atención. GPC-SS-058-08.

Especialidad: Ginecología y Obstetricia

Tema: Patología del Embarazo: Estados Hipertensivos

Subtema: Preeclampsia

Dificultad: alta

Caso clínico: Gestante de 32 semanas, previamente normotensa, presenta cefalea persistente, fosfenos y dolor epigástrico. Registra presión arterial severamente elevada en dos tomas adecuadas; tiene proteinuria y plaquetas en descenso, sin trabajo de parto. La evaluación fetal inicial muestra crecimiento conservado, con necesidad de vigilancia estrecha. La revisión de medicamentos identifica una posible exposición reciente que debe considerarse al integrar el riesgo. La hipertensión de nueva aparición con proteinuria y datos de daño orgánico configura preeclampsia con criterios de gravedad.

Pregunta: ¿Qué modalidad de atención es inapropiada en este escenario?

- A. no indicar manejo ambulatorio ante síntomas persistentes o criterios de gravedad*
- B. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- C. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: Los síntomas neurológicos, presión severa y datos de daño orgánico requieren hospitalización y capacidad de respuesta inmediata. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Secretaría de Salud e Instituto Mexicano del Seguro Social. Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de la Preeclampsia en Segundo y Tercer Nivel de Atención. GPC-SS-058-08.

Especialidad: Ginecología y Obstetricia

Tema: Patología del Embarazo: Estados Hipertensivos

Subtema: Preeclampsia

Dificultad: alta

Caso clínico: Gestante de 32 semanas, previamente normotensa, presenta cefalea persistente, fosfenos y dolor epigástrico. Registra presión arterial severamente elevada en dos tomas adecuadas; tiene proteinuria y plaquetas en descenso, sin trabajo de parto. La evaluación fetal inicial muestra crecimiento conservado, con necesidad de vigilancia estrecha. Los signos vitales se repiten después de una primera medida de soporte y muestran la misma tendencia clínica. La hipertensión de nueva aparición con proteinuria y datos de daño orgánico configura preeclampsia con criterios de gravedad.

Pregunta: ¿Cuál es la prioridad terapéutica inmediata?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. estabilizar la presión arterial severa con tratamiento antihipertensivo de acción apropiada y vigilancia materno-fetal estrecha*
- C. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: La hipertensión severa expone a hemorragia cerebral, edema pulmonar y complicaciones fetales; debe tratarse mientras se completa la evaluación. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Secretaría de Salud e Instituto Mexicano del Seguro Social. Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de la Preeclampsia en Segundo y Tercer Nivel de Atención. GPC-SS-058-08.

Especialidad: Ginecología y Obstetricia

Tema: Patología del Embarazo: Estados Hipertensivos

Subtema: Preeclampsia

Dificultad: alta

Caso clínico: Gestante de 32 semanas, previamente normotensa, presenta cefalea persistente, fosfenos y dolor epigástrico. Registra presión arterial severamente elevada en dos tomas adecuadas; tiene proteinuria y plaquetas en descenso, sin trabajo de parto. La evaluación fetal inicial muestra crecimiento conservado, con necesidad de vigilancia estrecha. Los signos vitales se repiten después de una primera medida de soporte y muestran la misma tendencia clínica. La hipertensión de nueva aparición con proteinuria y datos de daño orgánico configura preeclampsia con criterios de gravedad.

Pregunta: ¿Qué fármaco se utiliza para profilaxis de convulsiones?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- C. administrar sulfato de magnesio para prevención de convulsiones cuando existen criterios de gravedad*
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: El sulfato de magnesio es la medida preventiva de elección contra eclampsia en preeclampsia con datos de gravedad. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Secretaría de Salud e Instituto Mexicano del Seguro Social. Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de la Preeclampsia en Segundo y Tercer Nivel de Atención. GPC-SS-058-08.

Especialidad: Ginecología y Obstetricia

Tema: Patología del Embarazo: Estados Hipertensivos

Subtema: Preeclampsia

Dificultad: alta

Caso clínico: Gestante de 32 semanas, previamente normotensa, presenta cefalea persistente, fosfenos y dolor epigástrico. Registra presión arterial severamente elevada en dos tomas adecuadas; tiene proteinuria y plaquetas en descenso, sin trabajo de parto. La evaluación fetal inicial muestra crecimiento conservado, con necesidad de vigilancia estrecha. Los signos vitales se repiten después de una primera medida de soporte y muestran la misma tendencia clínica. La hipertensión de nueva aparición con proteinuria y datos de daño orgánico configura preeclampsia con criterios de gravedad.

Pregunta: ¿Qué vigilancia paraclínica identifica progresión de daño orgánico?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- C. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación
- D. obtener laboratorios seriados de plaquetas, función renal y hepática, y valorar síntomas de progresión*

Explicación: Plaquetas, creatinina y enzimas hepáticas permiten reconocer progresión hacia HELLP o disfunción multiorgánica. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Secretaría de Salud e Instituto Mexicano del Seguro Social. Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de la Preeclampsia en Segundo y Tercer Nivel de Atención. GPC-SS-058-08.

Especialidad: Ginecología y Obstetricia

Tema: Patología del Embarazo: Estados Hipertensivos

Subtema: Preeclampsia

Dificultad: alta

Caso clínico: Gestante de 32 semanas, previamente normotensa, presenta cefalea persistente, fosfenos y dolor epigástrico. Registra presión arterial severamente elevada en dos tomas adecuadas; tiene proteinuria y plaquetas en descenso, sin trabajo de parto. La evaluación fetal inicial muestra crecimiento conservado, con necesidad de vigilancia estrecha. Los signos vitales se repiten después de una primera medida de soporte y muestran la misma tendencia clínica. La hipertensión de nueva aparición con proteinuria y datos de daño orgánico configura preeclampsia con criterios de gravedad.

Pregunta: ¿Qué principio determina la finalización del embarazo?

- A. definir momento de terminación del embarazo según estabilidad materna, edad gestacional, condición fetal y respuesta a estabilización*
- B. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- C. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- D. limitar la intervención a observación domiciliaria sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: La finalización es el tratamiento definitivo, pero la oportunidad se individualiza tras estabilizar y valorar el balance materno-fetal. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Secretaría de Salud e Instituto Mexicano del Seguro Social. Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de la Preeclampsia en Segundo y Tercer Nivel de Atención. GPC-SS-058-08.

Especialidad: Ginecología y Obstetricia

Tema: Patología del Embarazo: Estados Hipertensivos

Subtema: Preeclampsia

Dificultad: alta

Caso clínico: Gestante de 32 semanas, previamente normotensa, presenta cefalea persistente, fosfenos y dolor epigástrico. Registra presión arterial severamente elevada en dos tomas adecuadas; tiene proteinuria y plaquetas en descenso, sin trabajo de parto. La evaluación fetal inicial muestra crecimiento conservado, con necesidad de vigilancia estrecha. Los signos vitales se repiten después de una primera medida de soporte y muestran la misma tendencia clínica. La hipertensión de nueva aparición con proteinuria y datos de daño orgánico configura preeclampsia con criterios de gravedad.

Pregunta: ¿Qué modalidad de atención es inapropiada en este escenario?

- A. posponer la decisión hasta contar con un estudio no indispensable, aun si retrasa el manejo definitivo
- B. no indicar manejo ambulatorio ante síntomas persistentes o criterios de gravedad*
- C. indicar tratamiento empírico de amplio espectro sin integrar los datos clínicos, de laboratorio y evolución
- D. limitar la intervención a observación domiciliar sin parámetros objetivos de reevaluación

Explicación: Los síntomas neurológicos, presión severa y datos de daño orgánico requieren hospitalización y capacidad de respuesta inmediata. En este caso se debe integrar la estabilidad clínica, la etiología probable y la respuesta al tratamiento, con reevaluación documentada antes de desescalar o cambiar de nivel de atención.

Fuente: Secretaría de Salud e Instituto Mexicano del Seguro Social. Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de la Preeclampsia en Segundo y Tercer Nivel de Atención. GPC-SS-058-08.